



SANTE DE LA REPRODUCTION PLANIFICATION FAMILIALE

LICENCE 2 SECTION SAGE-FEMME

**UNITE PEDAGOGIQUE SANTE DE LA REPRODUCTION PLANIFICATION FAMILIALE/GESTION
LOGISTIQUE/APPROCHE GENRE**

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS.....	2
LISTE DES ACRONYMES ETABREVIATIONS	3
CHAP 1 : CONCEPT DE LA SANTE SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION	5
CHAP 2 : CONCEPT DE LA PLANIFICATION FAMILIALE.....	8
CHAP 3 : GENERALITES SUR LA CONTRACEPTION	13
CHAP 4 : CRITERES MEDICAUX D'ELIGIBILITE DE L'OMS DES METHODES CONTRACEPTIVES.....	16
CHAP 5 : CAUSERIE EDUCATIVE	19
CHAP 6 : COUNSELING EN PLANIFICATION FAMILIALE.....	21
CHAP 7 : CONSULTATION EN PLANIFICATION FAMILIALE	25
CHAP 8 : METHODES D'AUTO-OBSERVATION (MAO).....	28
CHAP 9 : COÏT INTERROMPU	36
CHAP 10 : METHODE D'ALLAITEMENT MATERNEL ET DE L'AMENORRHEE (MAMA).....	37
CHAP 11 : METHODES DE BARRIERE.....	40
CHAP 12 : CONTRACEPTIFS HORMONAUX COMBINES (CHC)	47
CHAP 13 : CONTRACEPTIFS HORMONAUX PROGESTATIFS (CHP).....	68
CHAP 14 : DISPOSITIF INTRA-UTERIN (DIU)	85
CHAP 15 : DISPOSITIF INTRA-UTERIN DU POST-PARTUM (DIUPP)	100
CHAP 16 : CONTRACEPTION CHIRURGICALE VOLONTAIRE (CCV)	121
CHAP 17 : GROUPES PARTICULIERS	125
CHAP 18: ORGANISATION ET GESTION D'UN CENTRE DE PF	135
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	138
GLOSSAIRE	139
ANNEXES	141

AVANT-PROPOS

Fédération Internationale pour la Planification Familiale (IPPF) a donné ses lettres de noblesse au concept de la santé sexuelle et de la reproduction dans son plan stratégique *vision 2000*. Approuvé par l'assemblée des membres de l'IPPF en 1992, ce plan a vu le jour à la suite d'un processus de consultation auquel a pris part l'ensemble de la Fédération. La priorité qui s'est dégagée était de faire en sorte que tous les individus et les couples puissent jouir de la meilleure santé sexuelle et reproductive possible.

En 1994, la conférence internationale sur la population et le développement du CAIRE a donné un coup d'accélérateur à la stratégie de l'IPPF en matière de santé sexuelle et de la reproduction.

Dans le cadre de cette conférence, les gouvernants du monde entier se sont fixés pour but jusqu'à 2015 l'accès universel à une gamme complète de service de santé reproductive de qualité parmi lesquels des services de santé sexuelle et de planification familiale.

La santé sexuelle et de la reproduction signifie que les gens sont en mesure d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et dépourvue de danger et qu'ils ont à la fois les moyens de procréer et la liberté de décider, quand et avec quelle fréquence ils le font. Cela sous-entend le droit des hommes et des femmes d'être informés et d'avoir accès à des méthodes de planification familiale de leur choix qui sont sans danger, efficaces, abordables et acceptables.

En tant qu'agent de santé, vous aurez dans le cadre de vos activités, à rencontrer des hommes, des femmes des adolescents et des jeunes qui vous solliciteront pour des services en planification familiale ou en Santé Sexuelle et de la Reproduction.

Nous sommes persuadés que les informations contenues dans ce document vous seront utiles d'abord en tant que futur praticien et aussi à répondre à vos préoccupations personnelles en tant qu'homme ou femme en âge de procréation.

Cellule pédagogique santé sexuelle et de la reproduction

LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS

SIGLE	DEFINITION
AES	Accidents d'Exposition au Sang
AIBEF	Association Ivoirienne pour le Bien Etre Familial
ARV	Anti R�tro viraux
ATCD	Ant�c�dents
CCC	Communication pour un Changement de Comportement
CCV	Contraception Chirurgicale Volontaire
CIC	Contraceptifs Injectables Combin�s
CIP	Contraceptifs Injectables Progestatifs
CIP	Communication Interpersonnelle
CIPD	Conf�rence Internationale pour la Population et le D�veloppement
CISP	Contraceptifs injectables � seul progestatif
CHC	Contraception Hormonale Combin�e
CHP	Contraception Hormonale Progestative
CMM	Consommation Mensuelle Moyenne
COC	Contraceptifs Oraux Combin�s
COP	Contraceptifs Oraux Progestatifs
CPN	Consultations Pr� Natales
CV	Communication Verbale
DBC	Distribution � Base Communautaire
DDR	Date des Derni�res R�gles
DHN	D�sinfection de Haut Niveau
DIU	Dispositif Intra Ut�rin
EE	Ethinyl Estradiol
EIS	Enqu�te sur les Indicateurs du Sida
Ex	Exemple
FSH	Follicule Stimulating Hormone
GEU	Grossesse Extra Ut�rine
HSG	Hyst�ro –Salpingographie
HTA	Hypertension Art�rielle
IEC	Information Education Communication
IEC	Information Education Communication
SIGLE	DEFINITION
IM	Intramusculaire
IST	Infection Sexuellement Transmissibles
ITG	Infections du Tractus G�nital
IVG	Interruption Volontaire de Grossesse en milieu assist�
LH	Hormone Lut�inisante
MIP	Maladies Inflammatoires du pelvis
OMI	�d�mes des Membres Inf�rieurs
OMS	Organisation Mondiale de la Sant�
PAQS	Processus d'Am�lioration de la Qualit� des Services

PCU	Pilule Contraceptive d'Urgence
PEV	Programme Elargi de Vaccination
PF	Planification Familiale
PFN	Planification Familiale Naturelle
PI	Prévention de l'infection
PIB	Produit Intérieur Brut
PMA	Paquet Minimum d'Activités
PP	Pilule Progestative
SIDA	Syndrome de l'Immuno Déficience Acquise
SIGL	Système d'Information et de Gestion Logistique
SR	Santé de la Reproduction
SSP	Soins de Santé Primaires
SSR	Santé Sexuelle et Reproductive
TA	Tension Artérielle
TBC	Température Basale du Corps
TEV	Thrombose Veineuse Profonde
TSF	Taux de Fécondité Spécifique
UMM	Utilisation Mensuelle Moyenne
UNFPA	Fonds des Nations Unies pour la Population
USAID	United States Agency for International Development
VHB	Virus de l'Hépatite B

CONCEPT DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

PREREQUIS : Avant d'assister à ce cours, l'apprenant doit avoir lu le contenu du chapitre concept de la Santé de la Reproduction
(cf Support pédagogique de PF/GL 2019)

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de s'approprier le concept de santé de la reproduction pour la pratique professionnelle.

ENONCES DE RESULTATS

- 2- Décrire le concept de Santé de la Reproduction (SR).
- 3- Enumérer 05 composantes spécifiques de chaque volet de la SR.
- 4- Citer les 06 champs d'activités de la SR en Côte d'Ivoire.
- 5- Citer les 09 programmes de santé impliqués dans la SR.

INTRODUCTION

La Santé de la Reproduction est une Stratégie globale de Soins de Santé Primaires. La planification familiale a démarré en Côte d'Ivoire 1988 avec l'AIBEF, puis en 1991 avec le ministère de la santé à travers le bureau national de coordination de la PF (Projet USAID et Projet UNFPA).

En 1996 il a été créé le programme PNSR/PF, suite à la CIPD au CAIRE (Egypte 1994). En 2015, il est créé **par arrêté N° 133/MSLS/CAB du 20 mars 2015** le Programme National de Santé de la Mère et de l'Enfant (PNSME) né de la fusion du Programme National de la Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale (PNSR/PF) et du Programme National de Santé Infantile et de la Survie de l'Enfant (PNSI/SE).

Le PNDS 1996 – 2005 et celui de 2016-2020 ont inclus la santé de la SR/PF comme une stratégie prioritaire. Les activités de SR/PF ont été intégrées dans le paquet minimum d'activité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

En 1998, les différents documents de PF ont été élaborés : Politiques normes et protocoles, Curricula de formation. Ces curricula ont été révisés en 2012.

I. DESCRIPTION DU CONCEPT DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

1.1 Définition

La santé de la reproduction ou la santé reproductive, qui s'inscrit dans le cadre de la santé telle qu'elle est définie par l'OMS, s'intéresse aux mécanismes de la procréation et au fonctionnement de l'appareil reproducteur à tous les stades de la vie.

C'est un état de bien-être général tant physique que mental et social de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non seulement, l'absence de maladies ou d'infirmités.

1.2 But de la sante de la reproduction

Les interventions dans le cadre de la santé de la reproduction visent à améliorer la qualité de la vie pour tous à travers le cycle de vie qui va de la naissance à l'âge avancé, en passant par les étapes de l'enfance, l'adolescence et la période de reproduction.

1.3 Volets de la sante de la reproduction

- Volet Santé de la femme / santé des mères
- Volet Santé du nouveau-né et de l'enfant
- Volet Santé des adolescents/jeunes
- Volet Santé des hommes
- Volet santé des personnes âgées

II. COMPOSANTES DE CHAQUEVOLET

VOLET SANTE DE LA FEMME / SANTE DE LA MERE
*Information-Conseil et Planification Familiale *IEC/CCC en matière de sexualité humaine et parenté responsable *CCC en rapport avec les pratiques traditionnelles néfastes *Soins prénatals *Soins préconceptionnels *Vaccination Accouchement *Soins postnatal et planification familiale *Soins gynécologiques *Prévention et traitement de l'infertilité *Prévention et traitement des complications médicales des avortements provoqués *Prévention et traitement des infections du tractus génital et urinaire *Détection et prise en charge des cancers du sein et de l'appareil génital *Gestion, Supervision, Formation, Recherche et Evaluation.
VOLET SANTE DU NOUVEAU NE DE L'ENFANT
*Soins néonataux *Allaitement *Alimentation et sevrage *Suivi de la croissance *CCC en rapport avec l'Enfant *Vaccination *Soins infantiles y compris la santé scolaire *CCC sur les pratiques traditionnelles néfastes *Gestion, Supervision, Formation, Recherche et Evaluation
VOLET SANTE DES ADOLESCENTS/JEUNES
*Soins néonataux *Allaitement *Alimentation et sevrage *Suivi de la croissance *CCC en rapport avec l'Enfant *Vaccination *Soins infantiles y compris la santé scolaire *CCC sur les pratiques traditionnelles néfastes *Gestion, Supervision, Formation, Recherche et Evaluation
SANTE DES HOMMES
*CCC en Santé de la Reproduction *Traitement des pathologies sexuelles et dysfonctionnements sexuels *Lutte contre l'Infertilité et les cancers génitaux *Gestion, Supervision, Formation, Recherche et Evaluation.
SANTE DES PERSONNES AGEES (SPA)
*Prévention des maladies de la sénescence *Gériatrie *Gérontologie *Nutrition *CCC en rapport avec la promotion de la SPA *Santé mentale *Soins palliatifs *Gestion, Supervision, Formation, Recherche et Evaluation.
COMPOSANTES COMMUNES DE LA SR
- Les services de Planification Familiale y compris la lutte contre les IST/sida, l'infertilité et l'infécondité - CCC en Santé de la Reproduction - Gestion des services - Dimension genre.

III. DIFFERENTS PROGRAMMES DE SANTE IMPLIQUANT LASR

SIGLE	DEFINITION
PNSME	Programme National de santé de la mère et de l'enfant
PEV	Programme Elargi de Vaccination
PNPEC	Programme National de Prise en charge de personne vivant avec le VIH
PNSI	Programme National de Santé Infantile
PNPL	Programme National de Lutte contre le Paludisme
PNSSU- SAJ	Programme National de Santé Scolaire et Universitaire-Santé des Adolescents et Jeunes
PNLca	Programme National de Lutte contre le Cancer
PNN	Programme National de Nutrition

IV. PRODUITS DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

- Contraceptifs.
- Condoms (féminin, masculin) prévention IST/VIH.
- Produits utilisés dans la prise en charge des femmes enceintes, des parturientes et dans le post-partum.
- Produits pour le diagnostic et la prise en charge IST/VIH/sida
- ARV pour les séro- positifs(VIH)
- Équipements médicaux destinés à la SR.
- Vaccins
- Micronutriments- A, Iode
- Produits de laboratoire, etc...

V. LES CHAMPS D'ACTIVITES DE LA SR EN COTE D'IVOIRE

- Les centres de PMI
- Les maternités
- Les centres de planification familiale
- Les services de santé scolaire et universitaire
- Les centres d'écoute et de conseils pour les jeunes
- Le service de conseil économique et juridique.

RECAPITULATIF

1. Définir le concept de Santé de la Reproduction (SR).
2. Décrire le but et les 05 volets de la SR.
3. Enumérer 05 composantes de chaque volet de la SR.
4. Citer les 06 champs d'activités de la SR en Côte d'Ivoire.
5. Citer les 09 programmes de santé impliqués dans la SR.

CONCEPT DE LA PLANIFICATION FAMILIALE

PREREQUIS :

Avant d'assister à ce cours, l'apprenant doit avoir lu et/ou assimilé le contenu du chapitre concept de la planification (cf Support pédagogique de PF/GL 2019).

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à emmener les apprenants à connaître le concept de la planification familiale pour leur pratique professionnelle.

ENONCES DE RESULTATS

- 1- Citer les 02 mouvements migratoires et leurs effets sur la population.
- 2- Enoncer les principaux indicateurs démographiques utilisés en SR/PF
- 3- Donner la définition selon le cours du concept de la PF, décès maternel, immigration, émigration, migration.
- 4- Décrire les 04 types d'avantages/bienfaits de la PF
- 5- Citer les 05 composantes de la PF en Côte d'Ivoire.
- 6- Enumérer les 03 types d'obstacles de la PF.

I. DYNAMIQUE DE LA POPULATION

2.1 DEFINITION

Le dynamisme de population est l'ensemble des facteurs qui influent sur l'augmentation et la diminution de la population. Dans plusieurs pays nous pouvons noter des mouvements externes et internes.

2.2 MOUVEMENTS

2.2.1 Mouvements externes

La migration : c'est le déplacement de la population, plus exactement c'est le franchissement d'une frontière particulière par des personnes cherchant à établir une résidence.

L'émigration : c'est le départ d'une population qui quitte sa région d'origine pour une autre.

L'immigration : c'est l'arrivée d'une population dans une région donnée autre que sa région d'origine.

2.2.2 Mouvements internes

- La natalité
- L'accroissement
- La fécondité
- Mortalité

2.3 INDICATEURS DE DYNAMISME DE POPULATION IMPORTANTS

2.3.1 Indicateurs démographiques

Taux de natalité

Taux d'accroissement

Taux de fécondité par âge = taux de fécondité spécifique (TSF)

2.3.2 *Indicateurs sanitaires*

Taux de mortalité maternelle

Taux de mortalité infantile

Ratio d'avortement

***Décès Maternel**

Décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu'en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivé, mais ni accidentel ni fortuite.

Décès en rapport avec la grossesse :

1- Soit au cours du travail, en suites de couches, soit à la suite d'un avortement, d'une hémorragie, d'une toxémie gravidique, d'une infection ou des accidents anesthésiques (causes obstétricales directes)

2 - Soit une maladie préexistante ou apparue au cours de la grossesse sans qu'elle soit due à des causes obstétricales directes mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la grossesse (causes indirectes).

*** Intervalle inter génésique :** Est la période qui sépare une naissance et le début de la grossesse suivant (24mois).

2.3.3 **Indicateurs socio-économiques et culturels**

La plupart de ces indicateurs sont difficilement quantifiables.

- Scolarisation basse par manque de ressources
- Taux élevé d'enfants abandonnés
- Mauvais sevrage des enfants par manque de moyen.
- Augmentation de la précocité des rapports sexuels hors mariage.
- Nombre élevé de mères célibataires.
- Abandon de l'allaitement maternel avant 1an.
- Nombre élevé d'enfant malnutris.

II. PROBLEMATIQUE DE POPULATION ET DE DEVELOPPEMENT EN COTE D'IVOIRE

La fécondité reste élevée et l'espérance de vie s'allonge ; donc la population augmente. La population ivoirienne est jeune : les jeunes de moins de 15 ans représentent 47% et ceux de moins de 20 ans représentent 57%. La population active représente 51%. Un actif à sa charge un inactif.

2.1. Croissance démographique mondiale

- Au début des années 1990, chaque année la planète comptait 93 Millions d'habitants de plus.
- A la fin des années 1990 ce chiffre est passé à 100 Millions.
- L'accroissement de la population se produit pour 95% dans les pays en voie développement.
- L'Afrique comptait 681 Millions d'habitants en 1992. En 2025, elle comptera 1 Milliard 580 Millions d'habitants.

D'ici 2050, la population de l'Afrique sera multipliée par 4. La population de l'Afrique augmente de 2,9% l'an. Alors que celle de l'Europe augmente de 0,3%.

La population mondiale est constituée de plus en plus de jeunes : en 1996, les jeunes représentaient 28% de la population mondiale, puis en 2000, 34% de la population mondiale.

C'est dans les pays ayant les plus faibles ressources que la population s'accroît le plus rapidement possible.

2.1 Croissance démographique en Côte d'Ivoire

- Entre 1975 et 1995, l'accroissement de la population s'est fait au rythme annuel de 5% dont 3,5% de croissance naturelle.
- Entre 1975 et 1988, l'accroissement de la population s'est fait au rythme annuel de 3,8% pour atteindre 22 Millions en 2007.

2.2 Conséquences d'une démographie galopante

• Besoins d'éducation

Une population jeune et nombreuse implique de grands besoins d'éducation.

- les besoins en infrastructures sont élevés
- les filles sont sacrifiées au profit des garçons.

• Emploi

Le taux de chômage est élevé et les femmes sont aux postes de subalternes et dans le secteur informel.

• Santé

**** Une fécondité non réfléchie entraîne des conséquences graves pour les femmes :**

- Grossesses trop précoces
- Grossesses nombreuses
- Grossesses trop rapprochées
- Grossesses trop tardives

**** Morbidité et mortalité élevées (614 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes) EIS 2012.**

- **Environnement**

La pression démographique menace l'environnement. Elle entraîne une surexploitation dangereuse des ressources et des énergies.

- **Habitat**

La croissance démographique entraîne la déforestation et l'exode rural avec pour conséquence le développement des habitats précaires en ville, exacerbant la pauvreté, et le chômage.

- **Economies nouvelles**

La croissance de la population est beaucoup plus rapide que la croissance des ressources, avec la baisse du PIB. L'Etat éprouve des difficultés pour faire face à ces charges classiques : Education - Santé – Nourriture.

Une des solutions pour contrôler la croissance démographique galopante et ainsi améliorer la situation socio-sanitaire et socio-économique des familles est la Planification Familiale.

III. GENERALITES SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE (PF)

3.1. Définition de la PF

La Planification Familiale est l'ensemble des moyens mis à la disposition des individus et des couples pour leur permettre d'assurer leur sexualité responsable, de façon à éviter les grossesses non désirées, d'espacer les naissances et de déterminer la taille souhaitée de leur famille.

3.2. Avantages de la PF

Avantages sanitaires	Avantages socio-économiques	Avantages Démographiques	Avantages Environnementaux
- Réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle, périnatale et infantile - Réduction des complications dues à la grossesse et à l'accouchement. - Prévention des grossesses à risques. - Amélioration de l'état nutritionnel de l'enfant, de la mère, et de la famille.	- Meilleure préparation à la vie familiale - Amélioration de la qualité de la vie - Disponibilité du couple sur le plan sexuel - Libération de la femme pour la réalisation des tâches lucratives - Accès à l'éducation pour tous les enfants - Diminution de la délinquance juvénile	- Etablissement d'un bon équilibre entre population et ressources. NB : La PF prise isolement ne peut à elle seule résoudre les problèmes de développement. Elle y contribue.	- Bonne hygiène de l'environnement - Exploitation rationnelle de l'environnement

3.3. Les composantes de la PF

En Côte d'Ivoire, les activités de PF portent sur :

- ◆ L'IEC/CCC
- ◆ La contraception
- ◆ La lutte contre l'infécondité /infertilité
- ◆ La lutte contre les IST/VIH/sida
- ◆ Genre.

3.4 Les obstacles à la PF

Obstacles socioculturels	Obstacles économiques	Obstacles Institutionnels
- Les coutumes - Le manque d'information - Le manque de communication - L'ignorance - Les questions sexuelles considérées comme tabou - L'analphabétisme - L'inconscience - L'effet de mode	- Le cout des services de PF - Le manque ou insuffisances de moyens financiers.	- Absence ou insuffisances de centre de PF - Insuffisance de personnel qualifié

RECAPITULATIF

1. Citer les principaux indicateurs démographiques utilisés en SR/PF.
2. Donner la définition du concept de la PF
3. Citer les avantages/bienfaits de la PF
4. Enumérer les obstacles de la PF
5. Citer les composantes de la PF en Côte d'Ivoire.

GENERALITES SUR LA CONTRACEPTION

PREREQUIS : Avant d'assister à ce cours, l'apprenant doit avoir lu et/ou assimilé le contenu des chapitres suivants :

- Anatomie et physiologie de la reproduction
- Généralités sur la contraception (cf Support pédagogique de PF/GL2019).

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître les aspects généraux de la contraception.

ENONCES DE RESULTATS

1. Décrire correctement la contraception.
2. Décrire les 07 qualités d'une méthode de contraception
3. Expliquer l'interférence de la contraception avec les conditions de survenue de la grossesse par méthode.

I. DESCRIPTION DE LA CONTRACEPTION

1.1. Définition de la contraception

La contraception est l'ensemble des méthodes naturelles ou artificielles mises à la disposition d'un couple ou d'un individu pour empêcher temporairement ou définitivement la conception.

1.2. Différentes méthodes contraceptives

METHODES TEMPORAIRES	Méthodes d'auto Observation (MAO)	Méthode du calendrier ou OGINO KNAUSS		
		Méthode de la température basale du corps (TBC)		
		Méthode de la glaire cervicale ou BILLINGS		
		Méthode sympto-thermique		
		Méthode des jours fixes (MJF)		
	Méthode naturelle	Méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée (MAMA)		
	Méthode traditionnelle	Coït interrompu		
	Méthode de barrière	Mécanique	Préservatif	Condom
			Femidom	
		Chimique	Cape cervicale et diaphragme	
			DIU TCU 380A ou MONALISA	
	Méthode hormonale Méthode hormonale (suite)	Progestative	Spermicide (NEOSAMPOOM)	
			Oral	COP
			Injectable	DEPO PROVERA
				NORISTERAT
				SAYANA PRESS
			Sous cutanée	IMPLANON
			Transdermique (intra vaginal)	JADELLE
				Anneau progestatif
		Œstroprogestative	Transdermique (intra vaginal)	Anneau combiné
			Orale	COC
			Injectable	CIC
			Transdermique (cutanée)	Patch combiné
METHODES PERMANENTES	Méthode chirurgicale volontaire	Féminine	Ligature ou stérilisation ou ablation des Trompes	
		Masculine	Vasectomie	

NB : De toutes ces méthodes contraceptives, seuls les préservatifs protègent les clients des IST y compris le VIH/sida et le VHB

II. QUALITES POUR UNE METHODE CONTRACEPTIVE

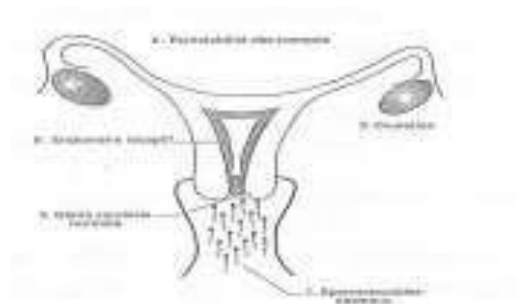
L'efficacité : Elle est la mesure dans laquelle une méthode de contraception est capable d'empêcher la survenue d'une grossesse. Ex : % de grossesse survenue après utilisation de la méthode.
La sécurité : Elle est la mesure dans laquelle une méthode de contraception n'entraîne pas d'effets secondaires défavorable ou dangereux. Ex : Contraceptifs oraux augmentent l'apparition des cas des accidents vasculaires cérébraux ou de tumeur du foie.
La tolérance : Elle est la mesure dans laquelle l'utilisateur est satisfait de la méthode. Exemple : absence d'ennui, facilité d'emploi. La tolérance à une méthode est directement liée à la rareté des effets secondaires inconfortables.
Le coût : C'est le prix de revient d'une méthode contraceptive pour une patiente suivie pendant un an. Le coût doit être abordable.
La continuité : C'est le pourcentage d'utilisatrices qui restent fidèles à la méthode après un temps donnée (1, 2,3 ou 5 ans par exemple)
La réversibilité : C'est la rapidité du retour à une fécondité normale après l'arrêt de la méthode. Normalement, sur 100 couples, on observe 87 grossesses après un an de rapports sexuels non protégés, si les deux partenaires sont fertiles.

III. INTERFERENCE AVEC LES CONDITIONS DE LA GROSSESSE

3.1. Les 5 conditions pour qu'une femme soit enceinte sont:

1. Des spermatozoïdes en qualité et en quantité suffisante qui doivent parvenir au niveau du col de l'utérus.
2. Une ovulation
3. Une perméabilité des trompes
4. Une glaire cervicale, transparente filante, abondante, perméable permettant la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule.
5. Un endomètre réceptif.

N.B : *Si une des conditions n'est pas respectée, la grossesse ne peut survenir.*



3.2. Interférence avec les conditions de grossesse

Les produits contraceptifs agissent sur une ou plusieurs conditions pour empêcher la survenue d'une grossesse. Ce tableau présente l'interférence de ces méthodes sur les conditions de la grossesse.

METHODES CONTRACEPTIVES	1spermatozoïdes	2Ovulation	3Trömpe	4gl'aïre	5Endometre
Méthodes de Barrière					
Spermicides	X				
Condoms	X				
Méthodes d'auto observation					
Méthodes d'auto observation	X				
Méthode naturelle					
MAMA		X			
Méthodes traditionnelles					
Coït interrompu	X				
Douche vaginale	X				
Méthodes médicales					
Hormonales		X		X	X
Mécanique	X			X	X
Chirurgie	X		X		

RECAPITULATIE

1. Qu'est-ce que la contraception?
2. Classer les méthodes de contraception
3. Décrire les qualités d'une méthode de contraception
4. Expliquer l'interférence de la contraception avec les conditions de survenue de la grossesse.

CRITERES MEDICAUX D'ELIGIBILITE DE L'OMS

PREREQUIS: Avant d'assister à ce cours, l'apprenant doit avoir lu et/ou assimilé le contenu des cours de

- pathologies médicales
- critères médicaux d'éligibilité

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de bien sélectionner les candidates pour chaque méthode contraceptive au regard de certaines pathologies et caractéristiques.

ENONCES DE RESULTATS

1. Donner la définition selon le cours des critères médicaux d'éligibilité.
2. Décrire les 04 catégories de classification des méthodes de contraception par type et spécificité.
3. Enoncer les 05 buts des MEC.
5. Décrire les critères médicaux d'éligibilité des méthodes contraceptives en utilisant le disque.

INTRODUCTION

Les Critères de recevabilité médicale pour l'adoption et l'utilisation continue de méthodes contraceptives, dont la première édition a été publiée en 1996, exposent les éléments d'orientation actuels de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en ce qui concerne l'utilisation sans risque de diverses méthodes contraceptives au regard de certaines pathologies et caractéristiques.

La cinquième édition publiée en 2015 est la dernière d'une série de mises à jour périodiques.

I. DEFINITION

Les critères médicaux d'éligibilité (MEC) ou critères de recevabilité médicale (CRM) sont un système de classification de l'OMS qui permet aux prestataires de savoir avant tout si la :

- Méthode contraceptive aggrave la pathologie ou engendre des risques supplémentaires pour la santé de la cliente,
- Situation médicale de la cliente nuit à l'efficacité de la méthode contraceptive.

En d'autres termes, la sécurité de la méthode doit être appréciée en tenant compte des avantages apportés par la prévention d'une grossesse non intentionnelle.

II. SYSTEME DECLASSIFICATION

C'est une classification en 4 catégories des états qui ont une incidence sur l'acceptabilité des méthodes contraceptives.

Ces états peuvent être des caractéristiques individuelles de la cliente (exple: âge, antécédents gestationnels) ou une pathologie connue.

Catégorie	Description	Avec jugement clinique
1	Aucune restriction d'utilisation	Utiliser la méthode dans n'importe quelles Circonstances
2	Les avantages l'emportent généralement sur les risques	Utiliser généralement la méthode
3	Les risques l'emportent généralement sur les avantages	L'utilisation de la méthode n'est généralement pas recommandée à moins qu'aucune autre méthode ne soit disponible ou acceptable
4	Risques inacceptables pour la santé	La méthode ne doit pas être utilisée

III. BUT DES MEC OU CRM

Les critères de recevabilité médicale :

- ◆ Fournissent des conseils sur 19 méthodes et 120 états et conditions médicales,
- ◆ Présentent 1700 recommandations au sujet des potentiels utilisateurs des différentes méthodes contraceptives et donnent des conseils relatifs au programme et prestataires pour les clients ayant des problèmes médicaux ou autres troubles particuliers,
- ◆ Procurent les meilleures preuves disponibles aux directives, politiques et normes nationales,
- ◆ Contribuent à la réduction des barrières des politiques et pratiques médicales,
- ◆ Permettent ainsi d'améliorer la qualité et l'utilisation des méthodes et services de PF.

IV. INTERPRETATION DES MEC OUCRM

Les questions auxquelles le CRM a répondu sont :

- ◆ « Face à une condition donnée ou un symptôme (ex. IST ou VIH/SIDA), une méthode particulière de PF peut-elle être employée?
- ◆ Et à quel degré de précaution ou de restriction, tel que reflété dans quatre catégories ou graduations de classification fondées sur les risques / avantages ?».

V. UTILISATION DES CATEGORIES DANS LA PRATIQUE CLINIQUE (utilisation du disque OMS)

5.1. Catégories pour les DIU, les méthodes hormonales et mécaniques

Catégorie	Description	Avec jugement clinique
1	Aucune restriction d'utilisation	Utiliser la méthode dans n'importe quelles circonstances
2	Les avantages l'emportent généralement sur les risques	Utiliser généralement la méthode
3	Les risques l'emportent généralement sur les avantages	L'utilisation de la méthode n'est généralement pas recommandée à moins qu'aucune autre méthode ne soit disponible ou acceptable
4	Risques inacceptables pour la santé	La méthode ne doit pas être utilisée

5.2. Catégories pour les DIU et les méthodes hormonales et mécaniques

Catégorie	En cas de jugement clinique limité
1	La méthode peut être utilisée
2	
3	La méthode ne peut pas être utilisée

5.3. Catégories pour la stérilisation masculine et féminine

Catégorie	Définition
Accepter	Aucune raison médicale de refuser la méthode
Prudence	Offrir avec beaucoup de précautions
Différer	Attendre que l'état pathologique soit évalué
Spécial	Requiert un équipement spécialisé, un chirurgien et un personnel expérimentés

5.4. Catégories pour les méthodes basées sur la connaissance de la fécondité

Catégorie	Situation
Accepter	Aucune raison médicale de refuser la méthode
Prudence	Offrir avec des précautions supplémentaires
Différer	Différer jusqu'à ce que la pathologie soit évaluée
Spécial	Non applicable

RECAPITULATIF

1. Qu'appelle-t-on critère d'éligibilité?
2. Définissez les catégories
3. Quels sont les catégories des critères de recevabilité qui permettent l'administration d'une méthode hormonale?
4. Quels sont les catégories des critères de recevabilité qui ne permettent l'administration d'une méthode hormonale?
5. Comment utiliser le disque (MEC)?

CAUSERIE EDUCATIVE

PREREQUIS : Avant d'assister à ce cours, l'étudiante doit avoir lu et/ou assimilé le contenu des chapitres suivants :

- Concept de la santé sexuelle et de la reproduction.
- Concept de la planification familiale.
- Généralités sur la contraception (cf Support pédagogique de PF/GL2019)
- Causerie éducative

OBJECTIF GENERAL :

Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître le processus d'animation d'une séance de causerie éducative.

ENONCES DE RESULTATS

1. Décrire correctement la causerie éducative
2. Expliquer tous les éléments à considérer pour une animation efficace en causerie

I. DESCRIPTION DE LA CAUSERIE EDUCATIVE

1.1. Définition de la causerie éducative

Une communication interpersonnelle au cours de laquelle un animateur échange avec un groupe homogène de personnes sur un sujet donné en santé de la reproduction dans un endroit préalablement choisi afin de leur apporter des informations et atteindre des objectifs fixés.

1.2. Différentes étapes de la causerie

Préparation	Exécution	Evaluation
- Choisir le sujet - Se documenter - Choisir le groupe cible (au plus 20 personnes) - Définir le but et les objectifs du thème - Élaborer les messages - Choisir les supports adaptés - Choisir le lieu - Contacter les autorités locales - Inviter la population cible - Préparer le lieu et installer le matériel - Déterminer le temps à l'avance.	- Accueillir et installer les invités - Saluer et se présenter - Introduire le thème - Demander l'avis de l'auditoire sur le thème - Développer le sujet selon le choix de la méthode - Recueillir les expériences de l'auditoire - Dissiper les rumeurs - Renforcer les connaissances - Soutenir les informations par les supports - Faire la synthèse - Remercier l'auditoire - Fixer un autre rendez-vous si possible.	- Poser des questions - Réponses - Faire des démonstrations - Observations.

1.3. Indicateurs d'une causerie éducative

- ◆ Connaissance des participants sur le sujet
- ◆ Nombre de questions / Nombre de participants
- ◆ Nombre de demande de service.

II. ELEMENTS D'UNE BONNE CAUSERIE

2.1. Local

- ◆ Propre, aéré, calme, bien éclairé
- ◆ Sièges suffisants et bien disposés.

2.2. Animateur

- ◆ Ponctuel, tenue propre adaptée au milieu,
- ◆ Pas de gestes inutiles,
- ◆ Position de l'animateur par rapport à l'auditoire,
- ◆ Langage claire et simple,
- ◆ Parler à haute voix varier le ton,
- ◆ Toujours rester dans le sujet,
- ◆ Sourire respectueux et courtois,
- ◆ Utiliser la méthode participative

2.3. Conseils pratiques

- ◆ Avoir un plan détaillé des idées maîtresses
- ◆ Respecter le public
- ◆ Lire le moins possible le texte écrit
- ◆ Message bien précis
- ◆ Aborder le sujet avec un pouvoir d'expert
- ◆ Être persuasif (convaincant)
- ◆ Être convaincu soi-même avant de pouvoir convaincre les autres
- ◆ Bien connaître les habitudes du milieu et les expressions à utiliser
- ◆ Surveiller les attitudes non verbales
- ◆ Utiliser les supports pour illustrer la causerie
- ◆ Faire attention aux tics
- ◆ Fixer le temps et la durée en fonction du milieu et du public
- ◆ « Attention à l'Attention », faire attention à l'attitude de l'auditoire

RECAPITULATIF

1. Définir la causerie éducative
2. Citer les étapes d'une causerie éducative
3. Identifier les éléments à considérer pour une animation efficace en causerie

COUNSELING EN PLANIFICATION FAMILIALE

PREREQUIS :

Avant d'assister à ce cours, l'apprenant doit avoir lu et/ou assimilé le contenu des chapitres suivants :

- Concept de la santé sexuelle et de la reproduction
- Concept de la planification familiale
- Généralité sur la contraception
- Counseling (cf Support pédagogique de PF/GL2019)

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à emmener les apprenants à connaître les éléments d'une séance de counseling.

ENONCES DE RESULTATS

1. Décrire correctement le counseling
2. Expliquer les 03 phases du counseling
3. Déterminer 05 qualités d'un bon conseillé
4. Expliquer les 04 étapes du counseling selon l'approche REDI.

I. DESCRIPTION DU COUNSELING

1.1. Définition du counseling

Le counseling se définit comme étant un entretien conseil, une tête à tête qui a lieu dans un endroit calme au cours duquel une personne aide une autre personne à trouver et choisir une solution à son problème. Le counseling a pour objectif d'établir puis de maintenir un dialogue basé sur la confiance.

1.2. Buts du counseling

Le counseling est une partie vitale de la planification familiale, qui aide les clients à :

- Arriver à un choix éclairé concernant leurs options en matière de reproduction;
- Choisir une méthode de contraception qui leur convient;
- Utiliser la méthode en toute sécurité et de manière efficace.
- Enlever la peur et la frayeur
- Faire dissiper les doutes
- Faire rejeter les conceptions erronées
- Augmenter les connaissances
- Motiver le client et faciliter une prise de décision
- Modifier le comportement.

1.3. Principes de base nécessaires au counseling

Le counseling doit se concentrer sur les besoins individuels de chaque client en assurant :

➤ Au niveau du client

- Le droit au caractère privé et confidentiel notamment préserver l'estime de soi et la confiance en soi du client en toutes circonstances
- La liberté de choisir la méthode contraceptive
- La liberté de s'exprimer
- Le consentement éclairé
- Les droits du client
- Le renforcement des capacités du client

➤ **Au niveau du prestataire**

- La maîtrise du sujet
- Le fait de tirer les leçons du passé mais aussi demeurer positif, constructif, optimiste, tourné vers l'avenir.
- L'éducation par l'exemple, être un modèle.

II. PHASES DUCOUNSELING

2.1. Counseling initial

Il se fait lors de la réception du client. Pendant cette phase toutes les méthodes sont décrites et l'on aide le client à choisir celle qui est la plus appropriée.

2.2. Counseling spécifique à la méthode

Il se fait avant et immédiatement après la prestation de service. On donne des instructions au client pour qu'il sache utiliser la méthode et l'on discute des effets secondaires communs.

2.3. Counseling de suivi

Il se fait lorsque le client revient pour la deuxième ou les consultations suivantes. On discute de l'utilisation de la méthode, on voit si elle est satisfaisante et si des problèmes sont survenus.

III. QUALITES MORALES NECESSAIRES POUR UN BON CONSEILLER

Le prestataire doit être un bon conseiller qui :

- Comprend et respecte les droits du client
- Gagne la confiance du client
- Comprend les avantages et les limitations de toutes les méthodes contraceptives
- Comprend les facteurs culturels et émotionnels qui influencent le choix d'une méthode
- Encourage le client à poser des questions
- Montre du respect et l'amabilité envers le client par son approche sans jugement
- Présente l'information sans parti-pris, qui indique le respect des sentiments du client
- Ecoute activement les préoccupations du client
- Comprend l'effet de la communication verbale
- Reconnaît les cas où il/elle n'est pas capable d'aider le client suffisamment et le réfère vers quelqu'un qui peut le faire
- Sait reformuler
- Sait observer : beaucoup d'information peuvent être obtenue à partir de l'observation (apparence physique et attitude du client)
- Sait analyser et interpréter
- Sait poser des questions ouvertes
- Suggère des alternatives
- Sait récapituler
- A de l'empathie.

IV. ETAPES DU COUNSELING

4.1. Etape du « BERCER »

B = Bienvenue	- Se présenter - Trouver un endroit privé qui respecte la confidentialité - S'asseoir près de la femme - Expliquer le caractère confidentiel - Voir si elle est en mesure de parler de PF, sinon la revoir le plutôt possible ou l'orienter.
E = Entretien	- Voir si le moment est approprié - Demander: ✓ à la femme ce qu'elle ressent ✓ si elle veut la présence d'un tiers /conjoint ✓ ses projets en procréation ✓ si elle utilisait une méthode de contraception ✓ renseignements / âge, état matrimonial, nombre de grossesses..... ✓ ses Connaissances sur les méthodes.
R= Renseignements	Donner des informations sur la PF (+++) à savoir : - Risque de grossesse dans les 2 semaines après l'avortement ou 3 semaines après l'accouchement - Existence de méthodes sûres en post abortum et post partum immédiat - Où / quand recevoir des services de PF - Autres: ✓ Caractéristiques de toutes les méthodes (supports++) ✓ Mode d'utilisation ✓ Arrêt ou changement de méthode
C = Choix de la méthode	Aider la cliente à choisir la méthode qui répond au mieux à ses besoins - Ne pas choisir à sa place - Vérifier s'il n'existe pas de contre-indications cliniques - Fournir la méthode
E = Explications	Mode d'utilisation de la méthode - Effets secondaires normaux, signes d'alarme - Demander de répéter - Répondre aux questions - Informer le client sur le réapprovisionnement, les visites de suivi
R = Rendez-vous/Référence	Donner un Rendez-vous ou Référer vers un centre appropriée pour le suivi si besoin - Évaluer la santé et la satisfaction - Traiter d'éventuels effets secondaires - Apporter un soutien et des encouragements pour l'aider à changer ou arrêter la méthode - Reprendre le Counseling en PF - Répondre aux questions et préoccupations - Évaluer les autres besoins en Santé de la Reproduction

4.2. Etape du REDI

L'acronyme REDI renvoie à « Etablissement de rapports, exploration, prise de décision et mise en application de la décision » (en anglais : Rapport-building, Exploration, Decision-making, and Implementing the decision).

R (Rapport-building) = Etablissement de rapports	- Saluer poliment le client - Se présenter (déterminer la catégorie à laquelle appartient le client – nouveau, client satisfait en visite de contrôle, client insatisfait en visite de contrôle) - Garantir la confidentialité et l'intimité - Expliquer la nécessité de discuter des problèmes sensibles et personnels
E = Exploration	- Examiner en détail les raisons de la visite du client. (Cette information fournit des indications sur les besoins en counseling du client et permet de bien cadrer la session.) ○ (A) Pour les nouveaux clients - Explorer ✓ les intentions du client en matière de SR, ✓ sa situation personnelle actuelle et ses expériences antérieures ✓ les antécédents et intentions du client en matière de procréation ✓ le contexte social du client, sa situation personnelle et ses relations ✓ les problèmes de sexualité ✓ les antécédents du client en ce qui concerne les IST/VIH - Expliquer le risque d'IST/VIH encouru ainsi que la double protection, et aider le client à percevoir son risque d'IST/VIH

	- Focaliser la discussion sur la (les) méthode(s) pertinentes pour le client: ✓ Examiner avec le client sa méthode préférée (s'il en a une) ou toute option pertinente de PF s'il n'en a pas une; ✓ lui donner de l'information, en fonction de ses besoins, et corriger les opinions fausses - Contrôler l'absence de grossesse et explorer les facteurs relatifs aux saignements mensuels, à toute grossesse ou maladie récentes ○ (B) Pour les clients en visite de contrôle • Evaluer le degré de satisfaction du client en ce qui concerne la méthode en cours d'utilisation • Vérifier que la méthode est utilisée correctement • Demander au client s'il y a des changements dans sa vie • (intentions en matière de procréation, risque d'IST/VIH et statut sérologique, etc.) • (Pour les clients insatisfaits uniquement). Examiner en détail avec le client les raisons de l'insatisfaction et les problèmes ; examiner les problèmes, leurs causes et les solutions possibles, y compris l'option de changer de méthode, ainsi que d'autres options pertinentes (Si le client décide de changer de méthode, passer à la phase 3, étapes 2-5.).
D (Decision-making) = Prise de décision	• Identifier les décisions que le client doit prendre ou confirmer. (Pour les clients satisfaits, vérifier que le client n'a pas besoin d'autres services. Sinon, aller à la phase 4, étape 5) • Explorer les options pertinentes pour chaque décision • Aider le client à évaluer les avantages, les inconvénients ainsi que les conséquences de chaque option (Fournir l'information nécessaire à cet effet, en fonction de ses besoins) • Encourager le client à prendre lui-même sa décision.
I (Implementing the decision) = Mise en application de la décision	• Aider le client à élaborer un plan concret et précis pour mettre en application sa (ses) décision(s) (obtention et utilisation de la méthode de PF choisie, réduction du risque d'IST/VIH, double protection, etc.) • Aider le client à acquérir les aptitudes nécessaires pour l'utilisation de la (des) méthode(s) choisie (s) et du préservatif. • Identifier les obstacles que le client pourrait rencontrer dans la mise en application de sa décision • Elaborer des stratégies pour surmonter ces obstacles • Elaborer un plan de suivi et/ou référer en fonction de ses besoins.

RECAPITULATIF

- 1- Qu'est-ce que le counseling
- 2- Quels sont les buts du counseling
- 3- Décrire les phases du counseling
- 4- Décrire les 4 étapes du REDI
- 5- Quels sont les qualités morales nécessaires pour un bon counseling

CONSULTATION EN PLANIFICATION FAMILIALE

PREREQUIS :

Avant d'assister à ce cours, l'apprenant doit avoir lu et/ou assimilé le contenu des chapitres suivants :

- Anatomie de l'appareil génito-urinaire féminin et du sein
- Démarche clinique en gynécologie,
- Prévention des infections
- Critères médicaux d'éligibilité de chaque méthode contraceptive, (cf Support pédagogique de PF/GL 2019)
- Consultation d'une cliente en planification Familiale

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre à connaître les éléments d'une consultation en planification Familiale

ENONCES DE RESULTATS

1. Décrire la consultation de Planification Familiale
2. Décrire les 06 étapes de la consultation de Planification Familiale
3. Enumérer toutes les étapes de l'examen général/physique et gynécologique
4. Décrire selon les normes les éléments de l'examen des seins chez une cliente.

I. DESCRIPTION DE LA CONSULTATION EN PLANIFICATION FAMILIALE

1.1 Définition de la consultation en planification familiale

C'est le processus par lequel un prestataire de services de planification familiale interagit avec un client pour l'aider à choisir et utiliser une méthode contraceptive ou pour trouver une solution à un problème de santé de la reproduction.

1.2. Buts de la consultation d'une cliente en PF

La consultation d'une cliente en planification familiale a principalement pour buts de:

- Identifier les contres indications médicales;
- Identifier les contre-indications demandant une prise de précaution à l'emploi d'une méthode particulière;
- Identifier les problèmes particuliers demandant un bilan supplémentaire, un traitement ou un suivi régulier;
- Dépister les IST, les cas d'infertilité/infécondité pour une prise en charge adéquate;
- S'assurer que la cliente n'est pas enceinte.

II. LES DIFFERENTES ETAPES DE LA CONSULTATION D'UNE CLIENTE EN PF

2.1. Accueil

- ◆ Souhaiter la bienvenue
- ◆ Offrir un siège
- ◆ Se présenter
- ◆ Demander le motif de la visite
- ◆ Rassurer la cliente
- ◆ Insister sur le caractère confidentiel de l'entretien

2.2 Interrogatoire

➤ L'identité du client

- ◆ Nom et Prénoms
- ◆ Age
- ◆ Niveau d'éducation
- ◆ Profession /occupation
- ◆ Domicile/ Adresse
- ◆ Situation matrimoniale et socio-économique

➤ Les antécédents

Antécédents personnels				Autres antécédents		
ATCD Médicaux	ATCD Chirurgicaux	ATCD gynécologiques	ATCD obstétricaux	ATCD Familiaux	ATCD Collatéraux	ATCD et options en PF
*HTA *Ictère *Céphalée fréquente *Diabète *Cardio - pathie	*interventions chirurgicales ayant intéressé les organes génitaux.	*Age aux premières règles (ménarches) *D.D.R *Durée du cycle *Durée des règles *Dysménorrhées *Saignement vaginaux *Myomes *Leucorrhées pathologiques *IST - Comportement sexuel.	*Gestité *Parité *Mode d'accouchement *Suites de couches	Cancer du sein (côté maternel de la cliente) Hémoglobinopathies (Drépanocytose)	ATCD, Notion d'IST Comportement sexuel profession	Méthodes antérieurement utilisées Méthodes souhaitées Options : Espacer ou Limiter les naissances

2.2. Examen général

L'examen général comprend la prise des constantes :

- ◆ Poids
- ◆ Tension artérielle
- ◆ Température et le pouls

2.3. Examen physique

➤ Etat général

- ◆ Vérifier l'état des conjonctives
- ◆ Examiner la région cervicale à la recherche ganglion
- ◆ Inspecter l'abdomen à la recherche de cicatrices et d'autres anomalies
- ◆ Palper l'abdomen à la recherche de d'organomégalie ou d'autres anomalies.
- ◆ Inspecter les membres inférieurs à la recherche de varices
- ◆ Palper les extrémités des membres à la recherche d'œdèmes

➤ Examen des seins

- ◆ Inspecter les seins
- ◆ Apprendre à la cliente à examiner elle-même ses seins
- ◆ Palper les seins à la recherche d'une anomalie (nodule ou kyste).

L'examen des seins se fait méthodiquement quadrant par quadrant.

Le prestataire inspecte les seins, la femme en position assise, les bras le long du corps puis les bras progressivement soulevés au-dessus de la tête et progressivement rabaissés. Cette inspection recherche la symétrie des seins, leur mobilité et apprécie l'état de la peau des seins.

La palpation du sein se fait en position couchée, le bras du sein examiné replié sur la tête. Le prestataire divise de façon imagée le sein en 4 quadrants passant par le mamelon. Les mains bien à plat, il palpe le sein en passant d'un quadrant à l'autre en écrasant le sein contre la grille costale. Cette palpation recherche la présence d'un nodule.

La palpation de la région axillaire à la recherche de ganglions.

La recherche d'un écoulement du sein (sang, pus, lait...) en exprimant le mamelon.

2.4. Examen gynécologique

- ◆ Expliquer à la cliente la procédure de l'examen
- ◆ Préparer le matériel
- ◆ Demander à la cliente de vider sa vessie
- ◆ Installer la cliente
- ◆ Faire l'inspection des organes génitaux externes
- ◆ Faire l'examen au spéculum : Inspecter le col et les parois vaginales à la recherche de lésions et de pertes.
- ◆ Faire le toucher vaginal combiné au palper abdominal pour apprécier le col de l'utérus, sa taille et ses annexes.

2.5. Prise de décision

- ◆ Expliquer les résultats de l'interrogatoire / l'anamnèse de l'examen général, physique et gynécologique à la cliente
- ◆ Procéder à l'analyse et à l'interprétation des données recueillies
- ◆ Discuter avec la cliente des méthodes adaptées à sa situation
- ◆ Aider la cliente à prendre une décision
- ◆ Aider la cliente à la mise en application de la décision.

RECAPITULATIF

1. Qu'est-ce que la consultation de Planification Familiale?
2. Citer les buts de la consultation de Planification Familiale
3. Quelles sont les deux premières étapes de la consultation?
4. Quels sont les paramètres cliniques à rechercher lors de l'examen général, physique et gynécologique?
5. Etablir le rapport entre les données de la consultation en PF et la prise de décision
6. Quel est le but de l'examen des seins chez une cliente?

METHODES D'AUTO OBSERVATION

PREREQUIS :

L'apprenant doit avoir au préalable lu et/ou assimilé le contenu des chapitres relatifs aux cours suivants :

- Physiologie de l'appareil génital, le cycle menstruel
- Maîtriser la prise de la température, interprétation de la courbe de température,
- Méthodes d'auto observation.

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à emmener les apprenants à connaître les méthodes d'auto observation.

ENONCES DE RESULTATS

1. Donner la définition selon le cours des méthodes d'auto observation selon le cours.
2. Enoncer les principes de base commun aux différentes méthodes
3. Citer les différentes méthodes d'auto-observation
4. Décrire pour chaque méthode 05 avantages et 05 limites
5. Décrire le mécanisme d'action de chaque méthode.
6. Décrire le mode d'utilisation de chaque méthode.

I. DEFINITION

Les méthodes d'auto observation ou méthodes basées sur la connaissance de la fécondité visent à éviter la grossesse grâce à l'observation des signes et symptômes survenant naturellement dans les phases de fertilité du cycle menstruel.

N.B. : Les couples s'abstiennent de rapports sexuels vaginaux non protégés pendant la phase du cycle menstruel où la femme est fertile.

- Les méthodes de connaissance de la fécondité demandent la coopération du partenaire.
- Les couples doivent être déterminés à s'abstenir de relations sexuelles ou à utiliser une autre méthode lors des jours féconds.
- La femme doit connaître les changements de son corps durant son cycle menstruel ou doit suivre les jours, selon le mode d'emploi de la méthode spécifique.
- Pas d'effets secondaires ni de risques pour la santé.

II. PRINCIPES DE BASE COMMUN AUX CINQ METHODES

Elles font appel aux moyens qui permettent de repérer la date de l'ovulation, soit par une étude statistique des dates, soit par la température basale ou par l'aspect de la glaire cervicale.

Toutes ces méthodes reposent sur le principe de base disant que :

- ♦ Il n'y a en principe qu'une ovulation par cycle et que cette ovulation a lieu en général 14 jours avant les prochaines règles.
- ♦ La durée de vie des spermatozoïdes est de 72 heures (03 jours), dans les voies génitales hautes de la femme peuvent survivre parfois jusqu'à 06 jours.
- ♦ L'ovule a une durée de vie de 24 heures (01 jour) après l'ovulation.

III. DESCRIPTION DES DIFFERENTES METHODES D'AUTO OBSERVATION ET LEURS MODES D'ACTION

3.1. Méthode de calendrier ou méthode d'Ogino Knauss

3.1.1. Description

Elle permet d'identifier la période fertile en se basant sur la durée des cycles précédents (au moins 6 à 8 cycles).

Le calcul de la période fertile est basé sur 3 constats :

- En moyenne, l'ovulation se produit 14 jours avant le début des prochaines règles.
- Les spermatozoïdes gardent leur capacité de fécondation pendant 3 jours (mais parfois jusqu'à 6 jours).
- L'ovule ne conserve la capacité d'être fécondé que pendant 24 heures après l'ovulation.

A partir de ces constats, on utilise la formule de 11 et de 18 pour calculer la période fertile : $11 = 14$ moins la durée de survie des spermatozoïdes qui est de 3 jours, ($14 - 3 = 11$)
 $18 = 14$ plus le temps maximum de survie des spermatozoïdes (3j) + la durée de survie de l'ovule (1j)
 $18 = 14 + 3 + 1$.

3.1.2. Instructions

- ♦ En utilisant un calendrier ordinaire, enregistrer la durée de chaque cycle menstruel.
- ♦ Le 1er jour du saignement est le jour 1 de chaque cycle et le jour avant le début du prochain cycle est le dernier jour du cycle précédent.
- ♦ Le 1^{er} jour où la femme a des chances d'être fécondée est calculé en soustrayant 18 de la durée du cycle le plus court.
- ♦ Le dernier jour est déterminé en soustrayant 11 de la durée du cycle le plus long. Les 2 chiffres qui résultent de ce calcul représentent le début de la phase féconde et le début de la phase post ovulatoire.

Exemple :

Le cycle le plus court d'une cliente a été de 25 jours et son cycle le plus long est de 30 jours, en faisant le calcul de : $25 - 18 = 7$ et $30 - 11 = 19$.

De ce fait, la période du 7^{ème} au 19^{ème} jour du cycle représente la période féconde.

3.1.3. Avantages et limites

Avantages	Limites
- Sans coût - Pas de modification de la physiologie de la femme - Possibilité d'associer d'autres méthodes de barrière - Nécessité d'une mise à jour des calculs chaque mois en utilisant toujours les 6 cycles les plus récents.	- Risque d'erreur élevé - Nécessité d'une volonté du couple - Nécessité d'un certain niveau d'instruction - Frustration du couple (contrainte) - Taux d'échec élevé - Efficacité 95%

3.2. METHODE DE LA TEMPERATURE BASALE DU CORPS (TBC)

3.2.1. Description

- Normalement, la température basale du corps s'élève de 0,2 à 0,4 degré Celsius après l'ovulation et reste élevée jusqu'au début des prochaines règles.
- La femme doit prendre sa température chaque matin, immédiatement au réveil et avant de se lever du lit et à jeûn
- La température peut être prise par voie rectale ou vaginale pendant 3 mn ou par voie buccale pendant 5mn.
- La température est enregistrée chaque jour sur la fiche spéciale de température basale.
- Relier chaque point représentant la température prise tous les jours de sorte qu'on ait une ligne qui relie **le 1er jour du cycle au 2^e, 3^e, etc...**
- Aussitôt survenue l'ovulation, la **température s'élève de 0,2 à 0,4** degré Celsius et reste au-dessus de la température de la période pré-ovulatoire.
- Pour la majorité des femmes, la TBC subit une baisse soudaine, environ 24 heures avant le début de la montée thermique.
- Une baisse de la température veut dire que l'ovulation se fera probablement dans les prochaines 24heures.
- Rappeler à la cliente que la température ne s'élève qu'après l'ovulation. De ce fait, les utilisatrices de cette méthode doivent s'abstenir des rapports sexuels pendant la première partie du cycle.
- La période fertile prend fin le 3e jour de la montée thermique. la période non fertile va du 4^e jour après la montée thermique jusqu'aux prochaines règles.

3.2.2. Facteurs influençant la température basale du corps (TBC)

- Un simple rhume ou une infection.
- Irrégularité des heures de sommeil.
- Cauchemars.
- Autres facteurs tels que les voyages, les changements de nourriture.etc...

3.2.3. Avantages et limites

Avantages	Limites
- Pas de contre-indications - Pas d'effets secondaires - Possibilité de contracter une grossesse - Responsabilité partagée entre les deux partenaires ce qui peut conduire à de meilleurs liens. - Acceptable pour certains qui rejettent les méthodes artificielles.	- Peu efficace - Nécessité une longue éducation - Difficultés conjugales liées à la continence - Crainte d'une grossesse non désirée.

3.3. METHODE DE LA GLAIRE CERVICALE OU METHODE DE BILLINGS (MGC)

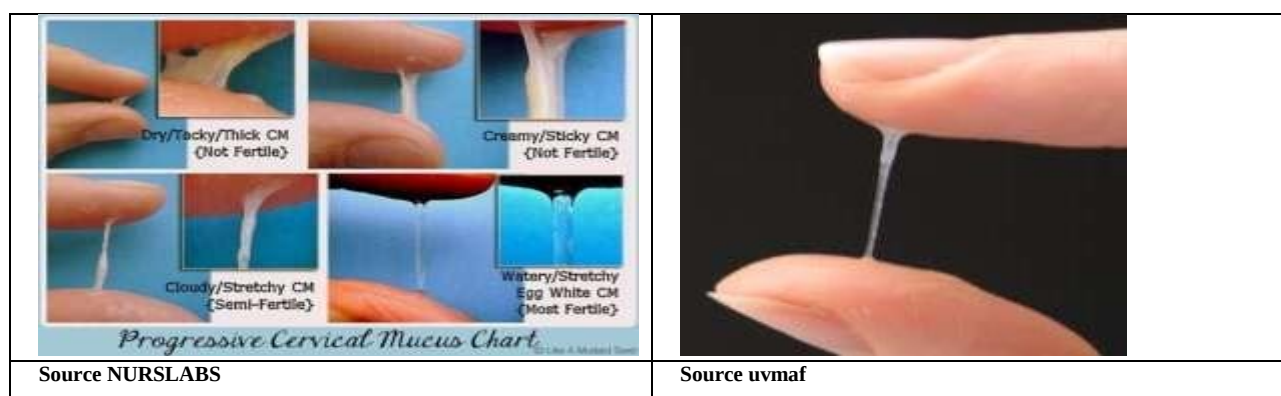
3.3.1. Description

Cette méthode est basée sur l'auto-observation par la femme des changements cycliques de sa glaire cervicale.

- Il est recommandé que la femme apprenne à reconnaître les changements de sa glaire pendant plusieurs cycles.
- Juste après les règles, la femme a généralement une sécheresse vaginale (phase d'infécondité primaire) appelée « **jours secs** » par le Dr BILLINGS. Puis apparaît un mucus peu abondant, trouble, épaisse presque collant. A l'approche de l'ovulation, ce mucus devient une sorte de glaire abondante, transparente, filante avec un aspect de blanc d'œuf cru.
- Cette glaire a pour rôle essentiel de transporter les spermatozoïdes du vagin aux trompes en passant par le col de l'utérus.
- Sous l'influence de la progestérone, la glaire devient épaisse ou disparaît totalement, laissant de nouveau place à une sécheresse vaginale. (Période d'infécondité secondaire).
- A chaque fois qu'elle va à la toilette, la femme doit noter la présence et la consistance de la glaire au niveau de la vulve.

- Comparer le degré d'humidité chaque jour.
 - Noter si la glaire peut être collectée par les doigts.
 - Noter la consistance et la filance de la glaire
 - Enregistrer tous les jours sur un tableau les changements intervenus.
- Aussitôt que la femme note une sensation humide ou la présence de glaire, elle doit savoir que c'est le début de sa période fertile qui continuera jusqu'au 4^e jour après le pic de la glaire.
 - La femme doit s'abstenir des rapports sexuels durant toute la première partie du cycle jusqu'au 4^e jour après le pic de la glaire cervicale.

La méthode nécessite d'examiner la glaire avec ses doigts:



Source NURSLABS

Source uvmaf

- Plusieurs facteurs peuvent affecter la glaire cervicale. En cas de doute, il est recommandé d'utiliser une méthode d'appoint.

3.3.2. Les changements de la glaire cervicale pendant le cycle menstruel normal

PERIODE DU CYCLE	QUANTITE	CONSISTANCE	COULEUR	ELASTICITE
Après les règles	Modérée	Epaisse	Trouble (jaune)	1 cm
A l'approche de l'ovulation.	Augmentée	Un peu épaisse, glissante, opaque, peu abondante et non filante	Blanche, mitigée, trouble et claire	1 à 1 cm et demi
A l'ovulation	abondante	Fine, gluante, filante et translucide	Claire (blanc d'œuf frais)	6 à 8 cm
Après l'ovulation	Diminuée	Fine	Mélangée	4 à 6 cm
A l'approche des règles	Minimale	Epaisse (collante)	Trouble	1 à 1 cm et demi

3.3.3. Facteurs pouvant modifier l'interprétation de la glaire cervicale

- ◆ Infections vaginales
- ◆ Utilisation des douches vaginales
- ◆ Prise de certains médicaments (par ex. les antibiotiques)
- ◆ Rapports sexuels.

NB : Le pic ovulatoire représente le dernier jour de glaire fertile est caractéristique dans le cycle menstruel. Sa présence est en corrélation avec l'ovulation :

- Il ne peut être identifié que rétrospectivement
- Il représente le dernier jour d'une glaire fertile
- Il marque la période optimale pour la femme qui désire un enfant
- Il survient généralement dans les 24 heures de l'ovulation.

3.3.4. Avantages et limites

Avantages	Limites
- Méthode simple - Applicable à toute femme - Dépistage de l'anovulation - Connaissance du corps par l'auto-observation.	- Taux d'échec élevé - Risque de confusion avec les autres sécrétions dues aux infections - Contrainte sociale - Education longue et demande un encadrement de spécialiste.

3.4. METHODE SYMPTO-THERMIQUE

C'est la combinaison des méthodes de TBC et MGC qui accentue probablement l'efficacité des méthodes d'auto observation puisque les jours inféconds seront déterminés de manière plus certaine.

3.5. METHODE DES JOURS FIXES (MJF)

3.5.1. Description

➤ Définition

La méthode des jours fixes ou méthode du collier est une méthode naturelle, simple, abordable, efficace basée sur une connaissance de la fertilité selon laquelle les utilisateurs évitent les rapports sexuels sans protection du 8^{ème} au 19^{ème} jour du cycle. Pour pratiquer la Méthode des Jours Fixes (MJF) on se sert d'un Collier du Cycle™. C'est une chaîne de perles dont les couleurs sont codées (12 blanches, 19 marron et 1 rouge et 1 marron foncé ou noir) pour aider une femme :

- à suivre les jours de son cycle
- à savoir quand elle est féconde
- à surveiller la durée de son cycle

➤ Mécanisme d'action

Cette méthode agit en empêchant la rencontre des gamètes mâles et femelles grâce à l'abstinence au rapport non protégé pendant la période féconde de la cliente.

➤ Avantages et inconvénients de la MJF

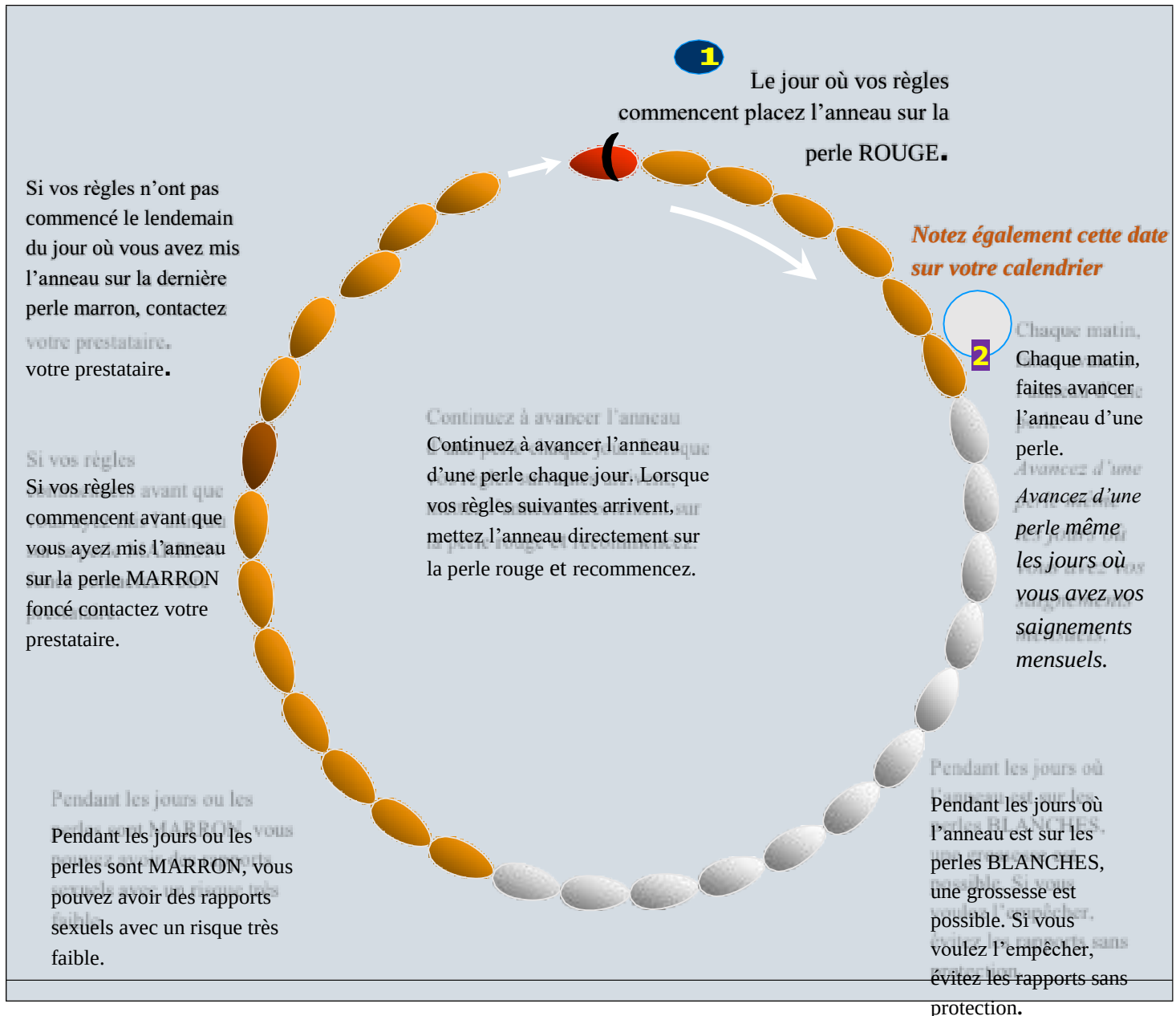
Avantages	Inconvénients
- Efficace à 95%, - N'entraîne pas d'effets secondaires, - Ne nécessite pas de prise de médicaments ou d'acte chirurgical, - Renforce la communication dans le couple, - Ne coûte pas cher. - Permet d'être en règle avec les normes culturelles et religieuses	- Ne protège pas contre les IST-VIH/SIDA, - Est contraignante (oubli de pousser l'anneau), - Exige la collaboration du partenaire doit, - Ne peut pas être utilisé quand le cycle est inférieur à 26 jours ou supérieur à 32 jours.

3.5.2. Critères d'éligibilité

- Les femmes ayant des cycles de 26 à 32 jours
- Les couples qui peuvent éviter les rapports sexuels non protégés du 8^{ème} au 19^{ème} jour du cycle,
- Les couples qui ne courent pas de risque accru de contracter une IST.

3.5.3. Mode d'utilisation

- Positionner l'anneau noir sur la perle rouge le premier jour du cycle, représenté par le premier jour des règles,
- Déplacer quotidiennement l'anneau dans le sens indiqué de la flèche blanche.
- Eviter les rapports non protégés, lorsque l'on se situe au niveau des perles blanches (**du 8ème au 19ème jour**),
- Se repositionner sur la perle rouge dès l'apparition des règles
- Marquer sur un calendrier contenu dans la notice, les premiers jours des règles pour se rappeler en cas d'oubli
- Utiliser un autocollant pour se rappeler qu'il faut déplacer l'anneau quotidiennement.



Source : OMS, Collier de perles

3.5.4. SUIVI DE L'UTILISATRICE

La périodicité des visites est la suivante: 3mois, 6mois puis tous les ans.

En cas de problèmes, revenir à tout moment.

Faire une évaluation à chaque contact.

- Si la méthode convient toujours à la femme :
 - Vérifier que son cycle menstruel le plus récent a duré de 26 à 32 jours,
 - Vérifier si elle est enceinte (se baser sur les check-lists),
- Si la méthode convient toujours au couple,
 - Déterminer si le couple veut toujours utiliser la méthode et peut éviter d'avoir des rapports sexuels sans protection les jours de perles blanches,
 - Déterminer si le couple peut utiliser la méthode correctement.

1.6.2. CRITERES MEDICAUX D'ELIGIBILITE DES MAO

CARACTERISTIQUES /ETATS	SYM	CAL	EXPLICATIONS
Période de la vie : a) Après les 1 ^{ères} règles b) Péri-ménopause	P P	P P	Les irrégularités menstruelles sont courantes après les premières règles et lors de la péri-ménopause et peuvent compliquer l'utilisation des méthodes
Allaitement au sein a) < 6 semaines après l'accouchement b) ≥ 6 semaines c) Après le retour des règles	D P P	D D P	Les méthodes naturelles peuvent être moins efficaces en période d'allaitement Il sera difficile de prévoir la période de fécondité en utilisant la méthode de la glaire cervicale.
Post-partum (chez les femmes qui n'allaitent pas) a) < 4 semaines b) ≥ 4 semaines	D A	D D	< 4 semaines : chez les femmes qui n'allaitent pas, avant quatre semaines fonction ovarienne peu suffisante pour la mise en place d'une MN. La femme peut utiliser les méthodes basées sur le calendrier dès le moment où elle a eu trois menstruations depuis l'accouchement et que ses cycles sont redevenus réguliers.
Post-abortionum	P	D	La femme peut utiliser une méthode du calendrier lorsqu'elle a eu au moins une menstruation après l'avortement. Si, avant cette grossesse, ses cycles menstruels étaient le plus souvent de 26 à 32 jours, elle peut utiliser la méthode des Jours Fixes®. Avant cela, il convient de lui proposer des méthodes adaptées au post-abortionum.
Saignements vaginaux irrégulier	D	D	
Ecoulement vaginal	D	A	Il sera difficile de prévoir la période de fécondité en utilisant la méthode de la glaire cervicale. Conseiller et aider la cliente à choisir une autre méthode.
Emploi de médicaments ayant une incidence sur la régularité du cycle, les hormones et/ou les signes de fécondité	P/D	P/D	
Pathologies entraînant une élévation température a) Maladies chroniques b) Maladies aiguës	de la P D	A A	

Sym = Méthodes basées sur les symptômes Cal = Méthodes basées sur le calendrier

A=Accepter

P = Prudence D =Différer

Pour la contraception, les MAO conviennent aux :	Pour la contraception, les MAO ne conviennent pas aux :
- Femmes en âge de procréer - Femmes de toutes parités - Couples qui pour des raisons philosophiques ou religieuses ne veulent pas utiliser d'autres méthodes - Femmes dans l'incapacité d'utiliser d'autres méthodes - Couples prêts à s'abstenir de rapports sexuels pendant plus d'une semaine lors de chaque cycle - Couples capables et désireux d'assurer, de noter, d'interpréter des signes de fécondité	- Femmes dont l'âge, la parité ou les problèmes de santé présenteraient un risque en cas de grossesse - Femmes dont les cycles menstruels réguliers ne sont pas rétablis (allaitement, post-avortement immédiat) - Femmes avec des cycles menstruels irréguliers (méthode de calendrier seulement) - Femmes dont le partenaire ne sera pas coopérant (continence pendant certaines périodes du cycle) - Femmes qui ne trouvent guère plaisant de toucher leurs parties génitales - Femmes qui ont plus d'un partenaire sexuel. - Couples qui sont sûrs de ne plus vouloir d'enfants
	NB : Pour la conception : les MAO conviennent aux couples désireux d'avoir une grossesse.

Méthode	Nombre moyen de jours d'abstinence ou d'emploi d'une autre méthode
Méthode des Jours Fixes	12
Méthode Symptothermique	17
Méthode d'ovulation (Glaire cervicale)	18

RECAPITULATIF

- 1- Définir les méthodes d'auto observation
- 2- Enoncer les principes de base commun aux différentes méthodes
- 3- Citer les différentes méthodes d'auto observation
- 4- Décrire pour chaque méthode les avantages et les limites
- 5- Décrire le mécanisme d'action de chaque méthode
- 6- Décrire le mode d'utilisation de chaque méthode

LE COÏT INTERROMPU

PREREQUIS : Avant d'assister à ce cours, l'apprenant doit avoir lu le contenu du chapitre relatif au coït interrompu (cf Support pédagogique de PF/GL 2019)

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître la méthode du coït interrompu.

ENONCES DE RESULTATS

1. Décrire le coït interrompu
2. Citer 04 avantages et 03 inconvénients du coït interrompu
3. Expliquer tous les conseils appropriés à donner à un couple qui utilise le coït interrompu.

I- DESCRIPTION DU COIT INTERROMPU

1.1. Définition

Appelé aussi méthode de retrait, est une méthode traditionnelle de planification familiale où l'homme retire entièrement son pénis du vagin avant l'éjaculation.

1.2. Indications

Le coït interrompu convient aux :

- ♦ Hommes qui souhaitent participer activement à la planification familiale
- ♦ Couples qui, pour des raisons religieuses ou philosophiques, ne veulent pas utiliser d'autres méthodes.
- ♦ Couples qui ont besoin d'une méthode d'appoint.
- ♦ Couples, femme ou homme qui ont des rapports sexuels peu fréquents.

II- AVANTAGES ET INCONVENIENTS

AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Efficacité immédiate - Gratuit - Pas besoin de disposition particulière, ni de produits chimiques - Pas d'effets secondaires sur la santé - Participation masculine à la planification familiale - Possibilité de relation plus étroite pour le couple.	- Pas de protection contre les IST y compris le VIH- SIDA et le VHB - Possibilité de diminution de l'efficacité à cause des spermatozoïdes d'une éjaculation récente - Possibilité de diminution du plaisir sexuel - Ne convient pas aux hommes qui ont une éjaculation précoce - Collaboration des deux partenaires souhaités.

III. CONSEILS A DONNER A UN COUPLE UTILISANT LE COIT INTERROMPU

- ♦ Expliquer au couple que la méthode du retrait
 - Demande la collaboration mutuelle des deux partenaires
 - Demande une bonne communication, et un engagement de chacun des partenaires
 - N'est pas indiquée aux hommes qui connaissent une éjaculation précoce ou qui ont du mal à retirer le pénis du vagin avant l'éjaculation.

RECAPITULATIF

2. Qu'est-ce que le coït interrompu?
3. Citer quatre avantages et trois inconvénients du coït interrompu
4. Expliquer les conseils appropriés à donner à un couple qui utilise le coït interrompu.

METHODE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL ET DE L'AMENORRHEE (MAMA)

PREREQUIS

L'apprenant doit avoir au préalable lu et/ou assimilé le contenu des chapitres relatifs suivants :

- Physiologie de l'appareil génital, le cycle menstruel
- Anatomie - physiologie du sein- physiologie de la lactation
- Allaitement et pathologies mammaires (cf Support pédagogique de PF/GL2019)
- MAMA.

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à emmener les apprenants à connaître les éléments de prescription de la MAMA

ENONCES DE RESULTATS

1. Décrire la MAMA selon le cours
2. Enumérer 05 avantages et 03 limites de la MAMA
3. Citer les 03 conditions nécessaires pour la réussite de la MAMA
4. Identifier les critères d'éligibilité à la MAMA
5. Expliquer les éléments du suivi d'une utilisatrice de la MAMA.

I- DESCRIPTION

1.1. Définition

La MAMA ou aménorrhée lactation elle est **l'utilisation de l'allaitement exclusif** comme méthode de contraception pendant **les six premiers mois du post partum**.

Elle utilise l'infécondité temporaire au moment de l'allaitement maternel en se basant sur l'effet physiologique de la succion pour supprimer l'ovulation.

1.2 Mécanisme d'action

L'allaitement exclusif et intense stimule la production de la prolactine par l'hypophyse et la maintient à un taux très élevé dans le sang maternel.

Ce qui conduit à une modification de la sécrétion des hormones naturelles avec pour conséquence le blocage de l'ovulation.

Il convient de préciser que plus le taux de prolactine est élevé, plus fort est l'effet contraceptif de la MAMA.

Ce taux de prolactine est fonction du nombre, de la qualité, de la fréquence des tétées et de la durée de l'allaitement.

II- AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Avantages pour l'enfant	Avantages pour la mère	Inconvénients
- Fournit à l'enfant l'alimentation la plus saine - Protège l'enfant contre la diarrhée parfois mortelle - Aide à établir un rapport étroit entre la mère et l'enfant - Immunise de façon passive (transfert d'anticorps protecteur maternel) - Favorise un bon développement psychomoteur chez l'enfant.	- Amoinçrit les saignements post-partum - Empêche efficacement la grossesse pendant au plus 6 mois - Encourage les meilleures modalités d'allaitement (promotion de l'AE) - N'interfère pas avec le rapport sexuel - Efficace immédiatement - N'entraîne aucun effet secondaire imputable aux hormones - Peut être employée immédiatement après l'accouchement - Ne coûte rien - N'exige pas de supervision médicale.	- Efficace uniquement avant le retour de la menstruation ou pendant 6 mois - Peut-être contraignant pour la mère - Ne protège pas contre les, ITG, IST/ VIH- SIDA, VHB - Dépend de l'utilisatrice : demande qu'on suive les instructions concernant les pratiques de l'allaitement - Peut avoir un risque de transmission du VIH à l'enfant par le lait si la mère est séropositive.

III- CONDITIONS D'EFFICACITE DE LA MAMA

Le taux d'efficacité est de 98% si la méthode est bien utilisée et si les 03 conditions suivantes sont réunies :

- Allaitement exclusif : (Pas d'apport alimentaire complémentaire au bébé (allaitement au biberon). Tétées fréquentes, au moins 6 à 8 tétées par 24heures.
- Femmes aménorrhéiques.
- Période post partum <6 mois ou âge du bébé <6mois

IV- CRITERES D'ELIGIBILITE MEDICAUX

Eléments à rechercher	Réponse	CAT/ Action	Justification
1- retour de couches (règles)	Si oui	Conseiller une autre méthode et aider la cliente dans le choix Encourager la mère à poursuivre l'allaitement	La menstruation signifie le retour de l'ovulation et de la fécondité Une grossesse est donc possible
2- Bébé $\geq$ 6mois ou apport alimentaire complémentaire	Si oui	Aider la cliente à choisir une autre méthode	L'introduction d'autres aliments à l'alimentation du bébé diminue la fréquence des tétées et de ce fait l'efficacité de la méthode
3- Intervalle entre les tétées > 4heures le jour >6heures la nuit	Si oui	Aider la cliente à choisir une autre méthode	Si l'allaitement est moins fréquent les ovaires reprennent leur fonctionnement normal

NB : Afin de protéger la santé du nourrisson, l'allaitement au sein est déconseillé pour les femmes qui utilisent des médicaments tels que les anti métabolites, la bromocriptine (traitement des tumeurs de la glande hypophyse ainsi que dans la maladie de Parkinson, présent dans le parlodel...), certains anticoagulants, les corticostéroïdes (à fortes doses), la ciclosporine (largement employée en transplantation ; en dermatologie), l'ergotamine(migraines²,comme utérotonique, vasoconstricteur ou hémostatique), le lithium, les médicaments psychotropes, les médicaments radioactifs et la réserpine. (antihypertenseur).

V- INSTRUCTIONS ET SUIVI DES CLIENTES

5.1. Instructions aux clientes

Démarrer la MAMA en mettant le nouveau-né au sein dès la naissance.
Allaiter aussi bien le jour que la nuit.
Allaiter le bébé sur demande en lui donnant les deux seins.
Allaiter le bébé au sein de façon fréquente et prolongée aussi souvent qu'il le désire.
Faire vider complètement le premier sein avant de donner l'autre pendant les tétées.
Ne pas laissez passer plus de 4 heures entre deux tétées dans la journée,
Allaiter le bébé au moins 1 fois pendant la nuit (pas plus de 6 heures entre deux tétées).
Exprimer le sein, extraire le lait et le donner à l'enfant à la cuillère, en cas d'absence de la mère,
Ne pas donner des aliments complémentaires au bébé ni l'eau sauf sous indication médicale.
Expliquer à la cliente qu'elle aura besoin d'une méthode contraceptive si elle voit à nouveau ses menstrues, si elle n'allaite plus complètement ou lorsque son bébé a 6 mois.
Conseiller à la mère de consultez la clinique avant de commencer une autre méthode contraceptive.
Utiliser des condoms en plus de la méthode MAMA il elle et son partenaire sont à risque élevé de contracter des IST, y compris le virus du sida,
Expliquer à la mère qu'elle a besoin d'un approvisionnement temporaire de condoms lubrifiants ou d'une autre méthode de contraception à domicile qu'elle peut utiliser lorsqu'elle arrête d'allaiter complètement (ou presque complètement) son bébé.
Retourner au service de planification familiale si elle a besoin d'aide pour une méthode de contraception qui la convient.

5.2. Suivi des clientes

Elle peut se présenter au centre de PF à tout moment au besoin et surtout avant la fin du sixième mois du post partum pour le choix d'une autre méthode si elle le désire.

Il faut prendre en charge les problèmes liés à l'utilisation de la méthode et les cas spécifiques suivants (Cf cours d'obstétrique):

- ◆ Engorgement mammaire
- ◆ Crevasses
- ◆ Gerçures
- ◆ Abscesses du sein.

Pour la qualité du suivi, trois questions sont à poser à la mère :

- ◆ Avez-vous eu votre retour de couche ?
- ◆ Avez-vous ajouté d'autres aliments ou liquides à l'alimentation de l'enfant ?
- ◆ Passez- vous de longues périodes sans tétée, soit de jour soit de nuit?
- ◆ Est-ce que votre bébé a 6 mois ou plus?

Si la cliente répond OUI à l'une de ces questions, la possibilité d'une grossesse est accrue. Pour assurer sa protection, conseiller une méthode d'appoint de planification familiale et dire à la mère de continuer l'allaitement maternel pour la santé de l'enfant.

RECAPITULATIF

1. Quelle est la différence entre l'allaitement et la MAMA
2. Quelles sont les conditions d'efficacité de la MAMA
3. Expliquer le mécanisme contraceptif de l'Allaitement Maternel.
4. Enumérer les avantages et les limites de la M A MA.
5. Expliquer les conditions nécessaires pour la réussite de la M A MA.

PREREQUIS : Avant d'assister à ce cours, l'apprenant doit avoir lu et assimilé le contenu des chapitres suivants :

- Critères d'éligibilité définis par l'OMS
- Anatomie et physiologie de la reproduction
- Méthodes de barrières (cf Support pédagogique de PF/GL2019)

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître les méthodes de barrière.

ENONCES DE RESULTATS

1. Décrire : les méthodes de barrière, condom, femidom
2. Citer 05 avantages et 05 limites de chaque méthode de barrière.
3. Expliquer le mode d'emploi de chaque méthode de barrière.
4. Identifier les critères d'éligibilité de chaque méthode de barrière.
5. Décrire la conduite à tenir en cas de rupture de préservatif.

I. DESCRIPTION DE LA METHODE DE BARRIERE

1.1. Définition de la méthode de barrière

C'est un dispositif contraceptif empêchant les spermatozoïdes vivants de s'introduire dans le canal cervical en particulier dans la glaire cervicale.

1.2. Différents types de méthodes barrières

Les méthodes de barrières abordées sont :

- Barrières mécanique ou physique : **préservatifs féminin et masculin**
- Barrières chimiques : (généralement **NONOXYNOL9**)

II. PRESERVATIFS MASCULIN/CONDOM OU CAPOTE

2.1. Description

➤ Définition

C'est un dispositif en vinyle ou en latex de forme cylindrique mis sur le pénis en érection avant les rapports afin d'éviter la pénétration du sperme dans les voies génitales. Ils peuvent être utilisés avec un spermicide pour une protection supplémentaire.

➤ Mécanisme d'action

- Il recueille le sperme lors de l'éjaculation;
- Il empêche le spermatozoïde d'accéder aux voies génitales hautes de la femme;
- Il empêche le passage des microorganismes d'un partenaire à un autre (IST y compris le VIH et le VHB).

➤ Indications

- Méthode choisie pour des raisons personnelles;
- Dans l'attente des règles pour la prise de la première pilule ou l'insertion d'un DIU;
- Lorsqu'une autre forme de contraception n'est pas possible pour des raisons médicales;
- Lorsqu'une femme a oublié de prendre sa pilule pendant deux jours de suite;
- Couple ou l'un des partenaires a plus d'un partenaire sexuel;
- Homme qui souhaite participer à la planification familiale;
- Couples qui n'ont pas de rapports sexuels fréquents.

2.2. Avantages et limites

Avantages Contraceptifs	Avantages sanitaires	Limites
- Efficace 98-99% - Efficace Immédiatement - N'affecte pas l'allaitement - Peut être utilisé comme appoint à d'autres méthodes - Est largement Disponible - coûte moins cher (à court terme) - Encourage la Participation masculine à la PF.	- Pas de risque de santé lié à la méthode - Pas d'effets secondaires Systémiques - Aucune prescription ou aucun bilan médical Nécessaire - Protection contre les ITG et autres IST (condoms en latex et plastique uniquement) - Erection et le temps d'éjaculation Prolongés - Prévention du cancer du col	- Efficacité modérée (2-12 grossesses pour 100 femmes pendant la première année d'utilisation) - Efficacité en tant que contraceptif dépend de la volonté à suivre les instructions. - Dépend de l'utilisateur (demande motivation continue et utilisation lors de chaque rapport sexuel) - Possibilité d'allergies au latex - Possibilité de diminution la sensibilité du pénis, - Interférence avec les rapports sexuels - Difficulté de gestion des condoms utilisés - conditions de stockage adéquates. - Disponibilité et réapprovisionnement des produits avant le rapport sexuel

2.3. Instructions au client

- Utilisez un condom à chaque fois que vous avez des rapports sexuels
- Utilisez un spermicide avec le condom pour un maximum d'efficacité et de protection.
- N'utilisez pas les dents, un couteau, des ciseaux ou autre ustensile tranchant ou pointu pour ouvrir le paquet.
- Enroulez le condom sur le pénis en érection avant de la pénétration vaginale car le sperme pré-éjaculatoire contient des spermatozoïdes actifs.
- Laissez environ 1 à 2 cm au bout pour le liquide éjaculé si le condom n'a pas un bout élargi (réservoir),
- Retirez le pénis avant de perdre l'érection en tenant la base (anneau) du condom ; cela évite que le condom ne glisse et ne répande le sperme.
- Utilisez un condom pour chaque rapport sexuel.
- Jetez les condoms utilisés à la poubelle, ou enterrez-les.
- Gardez un approvisionnement de condoms disponibles. Ne les laissez pas dans un endroit chaud car ils vont s'endommager et peuvent avoir une fuite pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas un condom si le paquet est ouvert ou si le condom semble abîmé ou écaillé.
- N'utilisez pas d'huile minérale, d'huile de cuisine, d'huile pour bébé ou de vaseline comme lubrifiants du condom. Ils peuvent endommager les condoms en l'espace de quelques secondes. S'il faut une lubrification, utilisez les gels pharmaceutiques.

Démonstration de l'utilisation de préservatif masculin

(Voir fiche technique)

APPRENTISSAGE POUR LES COMPETENCES D'UTILISATION DU PRESERVATIF MASCULIN (PORT ET RETRAIT)

ETAPES/TACHES	ACCOMPLI	
TACHES AVANT DEMONSTRATION	OUI	NON
1- Accueillir le client avec respect et amabilité et lui offrir de s'asseoir		
2- Expliquer au client que : - les condoms ne doivent pas être entreposés dans des endroits chauds ou humides tels qu'un porte-monnaie - le condom ne devrait pas être utilisé si l'emballage est déchiré ou semble endommagé ou écaillé - le client devrait vérifier la date de péremption - le client ne devrait pas utiliser de l'huile de cuisine, huile pour bébé, la vaseline pour lubrifier le préservatif - le condom doit être placé sur le pénis en érection et avant que le pénis ne pénètre dans le vagin - si le condom se déchire ou fuit pendant les rapports sexuels, il devrait le remplacer immédiatement - chaque condom ne doit être utilisé qu'une seule fois - chaque préservatif féminin doit être jeté immédiatement après chaque utilisation - le client devrait avoir un approvisionnement disponible		
TACHES PENDANT LA DEMONSTRATION	OUI	NON
1. Expliquer au client que vous allez démontrer comment utiliser le préservatif avec un pénis en bois		
2. Expliquer qu'il devrait faire attention en ouvrant l'emballage du préservatif de façon à ne pas le déchirer. Lui dire de ne pas utiliser de ciseaux, les dents ou d'autres objets tranchants pour ouvrir l'emballage		
3. Expliquer qu'il ne devrait pas dérouler le préservatif avant de le mettre		
4. Expliquer que s'il n'est pas circoncis, il faudra qu'il tire le prépuce du pénis vers l'arrière		
5. A l'aide du modèle, démontrer comment pincer le bout du préservatif tout en le mettant sur le bout du pénis		
6. Démontrer comment continuer à pincer le bout du préservatif tout en le déroulant jusqu'à ce qu'il couvre entièrement le pénis		
7. Expliquer qu'après l'éjaculation, et avant que le pénis ne se ramollisse, il devrait tenir le bord du préservatif tout en retirant le pénis du vagin		
8. Démontrer comment enlever le préservatif sans verser le liquide (sperme) qui est dedans		
9. Expliquer qu'il devrait l'envelopper (dans du papier si disponible) et ensuite le jeter dans une poubelle ou dans un trou (latrines)		
TACHES APRES DEMONSTRATION		
1. Lui dire de se laver les mains après avoir jeté le préservatif dans la poubelle		
2. Expliquer que les déchets contenant le préservatif devraient être brûlés ou enterrés		
3. Permettre au client de répéter les instructions et de s'exercer à mettre le préservatif sur le modèle pour s'assurer qu'il a compris		
4. Demander au client s'il a des questions ou des préoccupations		
5. Fournir des préservatifs au client		
6. Rassurer le client qu'il peut revenir à la clinique n'importe quand pour obtenir des conseils, des soins médicaux, ou pour s'approvisionner en préservatifs		

III.PRESERVATIFS FEMININ / FEMIDON

3.1. Description

➤ Définition

C'est un dispositif en plastique ou en latex de forme cylindrique comportant un anneau à chaque extrémité, placé dans le vagin avant les rapports afin d'éviter la pénétration du sperme dans les voies génitales.

➤ Mode d'action (voir condom)

➤ Indications (voir condom)

3.2. Avantages et limites

Avantages	Limites
Idem masculin - Est contrôlé par la femme - Est plus résistant - Peut être porté des heures avant les rapports sexuels	- Efficacité modérée - Efficacité en tant que contraceptif dépend de la volonté à suivre les instructions. - Utilisation dépend de la motivation continue de l'utilisateur lors de chaque rapport sexuel) - Difficulté de gestion des préservatifs féminins utilisés - Les conditions de stockage adéquates doivent être disponibles chez le client. - Les produits doivent être facilement disponibles avant le rapport sexuel. - Le réapprovisionnement doit être disponible. - Préjugés liés à la morphologie. - Coût élevé.

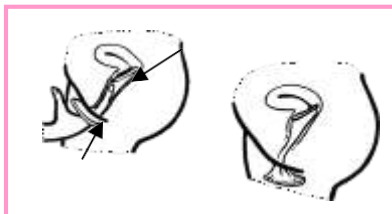
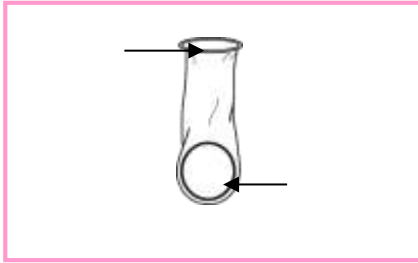
APPRENTISSAGE POUR LES COMPETENCES D'UTILISATION DU PRESERVATIF FEMININ (PORT ET RETRAIT)

APES/TACHES	ACCOMPLI	
TACHES AVANT DEMONSTRATION	OUI	NON
1. Accueillir la cliente avec respect et amabilité et lui offrir de s'asseoir		
2. Expliquer à la cliente que : • Les préservatifs féminins ne doivent pas être entreposés dans des endroits chauds ou humide tels qu'un porte-monnaie • Le préservatif féminin ne devrait pas être utilisé si l'emballage est déchiré ou semble endommagé ou écaillé • La cliente devrait vérifier la date de péremption • La cliente ne devrait pas utiliser de l'huile de cuisine, huile pour bébé, la vaseline pour lubrifier le préservatif • Le préservatif féminin doit être placé avant tout contact sexuel • Si le préservatif féminin se déchire ou fuit pendant les rapports sexuels, elle devrait le remplacer immédiatement • Chaque préservatif féminin ne doit être utilisé qu'une seule fois • Chaque préservatif féminin doit être jeté immédiatement après chaque utilisation		
DEMONSTRATION	OUI	NON
1. Se laver les mains		
Adopter une position adéquate (couchée sur le dos, accroupie ou debout avec une jambe surélevée sur une chaise)		

Repérer le point d'ouverture en passant un doigt		
Frotter le préservatif entre les doigts pour étendre le lubrifiant		
Ouvrir l'emballage sans abîmer le préservatif		
Plier l'anneau intérieur avec le pouce et l'index et former un « 8 »		
Ecarter les lèvres du vagin avec l'autre main		
Insérer l'anneau plié dans le vagin		
Pousser l'anneau le plus loin possible jusqu'au fond du vagin		
S'assurer que l'anneau intérieur est fixé et que l'anneau extérieur recouvre la vulve		
Guider et insérer le pénis à l'intérieur du préservatif		
Mettre un lubrifiant sur le pénis ou à l'intérieur du préservatif si on observe une gêne pendant le rapport		
Retirer le préservatif après l'éjaculation, serrer et enrouler l'anneau pour éviter que la semence s'écoule		
Mettre le préservatif utilisé dans son emballage et le jeter à la poubelle ou dans un trou (latrine) ne jamais jeter le préservatif dans les toilettes		
APRÈS LA DEMONSTRATION	OUI	NON
laver les mains après avoir jeté		
expliquer que les déchets contenant le préservatif féminin devraient être brûlés ou enterrés		
Permettre à la cliente de répéter les instructions et de s'exercer à mettre le préservatif féminin sur le modèle pour s'assurer qu'elles ont compris		
Offrir des préservatifs féminins aux clientes		
Rassurer la cliente et lui dire qu'elle peut revenir à la clinique à n'importe quel moment pour obtenir des conseils, des soins médicaux, ou pour s'approvisionner en préservatifs féminins		

3.3. Procédure de pose et retrait

- Procédure de pose et de retrait (Voir fiche technique)



3.4. Conduite à tenir en cas de rupture du préservatif

Situation	Conduite à tenir
Si rupture avant éjaculation	- Arrêter le coït - Changer de préservatif
Si rupture du préservatif pendant ou après éjaculation avec usage de spermicide	- Eviter les toilettes intimes chez la femme avant 6 H
Si rupture du préservatif pendant ou après éjaculation sans usage de spermicide.	- Prescrire une contraception orale d'urgence Dans les 72 h : - Poser un D.I.U Dans les 5 jours suivant les rapports sexuels - Appliquer le protocole de prise en charge des Accidents à l'Exposition au Sang (AES) dans les 48H pour la prévention du VIH.

A RETENIR

- Il peut être utilisé en même temps que d'autres méthodes de planification familiale pour prévenir les infections sexuellement transmissibles, y compris l'infection à VIH.
- Il est important de l'utiliser correctement à chaque rapport sexuel.
- Il faut veiller à ce que le pénis entre dans l'anneau du préservatif et y reste pendant le rapport sexuel.
- Les deux partenaires doivent être d'accord de l'utiliser.
- Il est possible d'avoir recours à la contraception d'urgence si le préservatif glisse ou n'est pas utilisé correctement.

IV. METHODES DE BARRIERE CHIMIQUES

4.1. Description

4.1.1. Définition

Les méthodes de barrière chimiques sont des produits chimiques (généralement NONOXYNOL 9) qui inactivent ou tuent les spermatozoïdes.

4.1.2. Variétés:

- Mousse, (EMBO, DELFENE)
- Comprimés (NEOSAMPOON, CONCEPTROL)
- Crème (KOROMEX)
- Ovule
- Film

4.1.3. Mécanismes d'action

- Désagrège la membrane cellulaire des spermatozoïdes, ce qui diminue leur mouvement (motilité) et leur capacité à fertiliser l'ovule.

4.2. Avantages et Limites

Avantages	Limites
- Efficace immédiatement (mousses et crèmes) - N'affectent pas l'allaitement - Peuvent être utilisés comme appoint à d'autres méthodes - Pas de risques de santé liés à la méthode - Aucun effet secondaire systémique - Facile à utiliser - Augmente la lubrification pendant le rapport sexuel - Pas besoin de prescription ou de supervision médicale	- Modérément efficace (3-21 grossesses pour 100 femmes pendant la première année d'utilisation) - Dépend de l'utilisatrice - Attendre 10 à 15 minutes après l'application avant d'avoir le rapport sexuel - Chaque application est efficace que pendant 1 à 2 heures - Les produits doivent être facilement disponibles avant le rapport sexuel - Le réapprovisionnement doit être disponible - Attendre 6-8h avant de faire sa toilette intime.

4.3. Instructions aux utilisatrices

L'applicateur doit être lavé à l'eau tiède et au savon.
La boîte doit être secouée vigoureusement avant l'utilisation afin qu'il ait plein de Bulles pour constituer une barrière et le spermicide sera mélangé à la mousse.
Une boîte supplémentaire pour la mousse doit être toujours laissée à portée de mains.
Le comprimé doit être introduit profondément dans le vagin à la base du col 10 mn avant les rapports sexuels et renouvelé à chaque rapport.
Attendre 6 à 8h avant de faire la toilette intime.
La mousse ne nécessite aucune attente ; les rapports peuvent avoir lieu immédiatement.

4.4. Critères d'éligibilité des méthodes de barrière

➤ Méthodes de barrière mécanique

Méthodes sans restriction médicale particulière sauf allergies au latex.

En cas d'allergie utiliser des préservatifs sans latex.

Ex : préservatif/condom, cape cervicale, diaphragme, éponge.

➤ Méthodes de barrière chimiques

ETAT	SPERMICIDE	EXPLICATIONS
Risque élevé de VIH	4	L'utilisation répétée et à forte dose du spermicide nonoxynol-9 est associée à un risque accru de lésions génitales, lesquelles peuvent accroître le risque de contracter l'infection à VIH
Infection à VIH asymptomatique ou légère (stade de l'OMS 1 ou 2)	3	L'utilisation de spermicides peut provoquer des ruptures de la muqueuse cervicale, entraînant parfois une excrétion virale accrue et la transmission du VIH aux partenaires sexuels non infectés.
Infection à VIH sévère ou à un stade avancé (stade de l'OMS 3 ou 4)	3	L'utilisation de spermicides peut provoquer des ruptures de la muqueuse cervicale, entraînant parfois une excrétion virale accrue et la transmission du VIH aux partenaires sexuels non infectés.

RECAPITULATIF

1. Quelles sont les caractéristiques de chaque méthode?
2. Enumérer les 05 avantages et les 05 limites de chaque méthode de barrière.
3. Expliquer le mode d'action de chaque méthode de barrière.
4. Expliquer le mode d'emploi de chaque méthode de barrière.
5. Expliquer les critères d'éligibilité des méthodes de barrière.
6. Décrire la conduite à tenir en cas de rupture de préservatif.

CONTRACEPTIFS HORMONAUX COMBINES (CHC)

PREREQUIS : L'apprenant doit avoir au préalable lu et ou assimilé le contenu des chapitres suivants :

- Contraceptifs oraux combinés
- Critères d'éligibilité définis par l'OMS. (cf Support pédagogique de PF/GL2019)

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître les conditions de prescription des contraceptifs hormonaux combinés (CHC).

ENONCES DE RESULTATS

A la fin du cours, les apprenants seront capables de :

1. Décrire correctement les contraceptifs hormonaux combinés (CHC).
2. Expliquer correctement les procédures d'utilisation
3. Identifier les clientes répondant aux critères de recevabilité pour chaque méthode.
4. Expliquer la CAT à tenir devant les effets secondaires
5. Décrire tous les éléments de suivi d'une cliente sous CHC

I. DESCRIPTION DES CONTRACEPTIFS HORMONAUX COMBINES (CHC).

1.1 DEFINITIONS

Les Contraceptifs Hormonaux Combinés (CHC)
Les Contraceptifs Hormonaux Combinés (CHC) désignent des produits contraceptifs contenant un œstrogène associé à un progestatif. Les CHC abordés sont : les Contraceptifs Oraux Combinés (COC), le patch combiné, l'anneau combiné Intra vaginal (AIV) et les CHC injectables
Les contraceptifs oraux combinés (COC)
Les contraceptifs oraux combinés (COC) sont une association d'œstrogène et de progestérone donnant une pilule œstroprogestative ou contraceptifs oraux combinés.
Les contraceptifs hormonaux combinés injectables (CHC injectables)
Les contraceptifs hormonaux combinés injectables (CHC injectables) sont une association d'œstrogène et de progestérone donnant un produit œstroprogestative injectable.
Le patch combiné
Le patch contraceptif œstroprogestatif est aussi appelé patch contraceptif combiné ou timbre transdermique est un dispositif à coller soi-même sur la peau qui diffuse pendant une semaine l'ETHINYLESTRADIOL ainsi qu'un progestatif (NORELGESTROMINE) pour prévenir une grossesse. Il libère directement ses deux hormones dans les vaisseaux sanguins par l'intermédiaire de la peau. Ex : Evra = 150 µg de 17-DEACETYL NORGESTIMATE (NORELGESTROMINE), plus : 20 µg d'ETHINYLESTRADIOL.
Un anneau intra vaginal
Un anneau intra vaginal combiné aussi appelé contraceptif vaginal œstroprogestatif ou contraceptif transdermique est un dispositif souple, mou qui libère continuellement 150 mcg de progestatif (Etonorgestrel) et 20 mcg d'œstrogène (Ethinyl Estradiol) qui sont absorbées par l'épithélium vaginal et transporté directement dans les vaisseaux sanguins pour prévenir la grossesse.

1.2. CARACTERISTIQUES DES CONTRACEPTIFS HORMONAUX COMBINES (CHC).

1.2.1. Contraceptifs oraux combinés (COC)

En fonction du dosage en œstrogène (EE)	Les COC mini dosés contenant 15 à 40 mcg EE Exemple : ▪ TRIELLA (35 mcg) ▪ MICROGYNON, ADEPAL, CONFIANCE (30 mcgEE) ▪ MELIANE (20 mcgEE)
	Les COC normo-dosés contenant 50 mcg EE Ex : STEDIRIL (50 mcg EE)
	Les COC fortement dosés supérieur à 50 mcg EE Ex : NORQUENTIEL
Selon les phases	- <i>Les monophasiques</i> : toutes les 21 pilules actives contiennent la même quantité d'œstrogène et de progestérone. - <i>Les bi-phasiques</i> : les 21 pilules actives contiennent 02 combinaisons différentes d'œstrogène et de progestérone - <i>Les tri-phasiques</i> : les 21 pilules actives contiennent 03 combinaisons différentes d'œstrogène et de progestérone.
Selon le type progestérone	Les pilules de 1ère génération contiennent comme progestatif de la NORETHISTERONE. Ex: TRIELLA
	Les pilules de 2ème génération contiennent du LEVONORGESTREL ou du NORGESTREL Ex : MICROGYNON, ADEPAL, CONFIANCE (LEVONORGESTREL), STEDIRIL (NORGESTREL)
	Les pilules de 3ème génération contiennent comme progestatif du DESOGESTREL, du GESTODENE ou du NORGESTIMATE Ex : MELIANE (GESTODENE)
	La pilule de 4ème génération contiennent de la DROSPIRENONE, de la CHLORMADINONE, du DIENOGEST ou du NOMEGESTROL.

1.2.2. Contraceptifs Injectables Combinés (CIC)

Deux formulations de CIC sont abordées dans ce chapitre :

- Acétate de MÉDROXYPROGESTÉRONNE (25 MG) ET CYPIONATE D'ESTRADIOL (5 MG) vendu sous les noms de marques:
 - CYCLOFEM,
 - CICLOFEMINA,
 - CYCLO-PROVERA,
 - FEMINENA...
- ENANTHATE DE NORETHISTÉRONNE (50 MG) et de VALÉRIANATE d'ESTRADIOL (5mg) vendu sous les noms de marques:
 - MESIGYNA
 - NORIGYNON.

1.3. MODE D'ACTION (CHC)

ACTION	COC	CIC	PATCH COMBINE	ANNEAU COMBINE
Bloque de l'ovulation par l'inhibition de la sécrétion de LH et de la FSH.	X	X	X	X
Modifie de l'endomètre qui est altéré et n'est pas propice à l'implantation de l'œuf.	X	X	X	X
Modifie la glaire cervicale qui devient épaisse, rare, hostile, diminuant la capacité des spermatozoïdes à la pénétrer	X	X	X	X
Diminue le transport des spermatozoïdes dans les trompes de Fallope.	X	X	X	X

1.4. AVANTAGES

ETAT /CARACTERISTIQUES		COC	CIC	ANNEAU COMBINE	PATCH COMBINE
Efficacité		98-99%	98-99%	99,7	99,7
Efficacité immédiate		X	X	X	X
Réversibilité		X	X	X	X
Sure		X	X	X	X
N'interfère pas dans les rapports Sexuels		X	X	X	X
Diminue	Les douleurs Menstruelles	X	X	X	X
	Le flux menstruel	X	X	X	X
Régularise le cycle menstruel		X	X	X	X
Protège Contre	l'anémie	X	X	X	X
	les infections pelviennes	X	X		X
	le cancer des seins	X	X	X	X
	M I P	X	X		
	la Grossesse Extra Utérine	X	X	X	X
	Symptômes d'endométriose	X	X	X	X
	Les kystes ovariens	X	X	X	X
Protège contre les cancers de	l'ovaire	X	X	X	X
	l'endomètre	X	X	X	X

1.5. LIMITES DES (CHC)

ETAT /CARACTERISTIQUES	COC	CIC	PATCH COMBINE	ANNEAU COMBINE
Irritation de la peau			X	
Nausées, vertiges	X	X	X	X
Seins légèrement sensibles	X	X	X	X
Maux de tête légers	X	X	X	X
Saignotements (spotting)	X	X	X	X
Possibilité d'utilisation comme CU	X			
Examen pelvien non exigé	X		X	X
Poids supérieur à 90kg				
Visible			X	
Risque de décollement			X	X
Efficacité moindre avec la prise de certains médicaments	X	X	X	X
Retard dans le retour de fécondité.	X	X	X	X
Tumeurs bénignes et malignes du foie	X	X	X	X
Besoins fréquents de réapprovisionnement	X	X	X	X
Pas de protection contre les ITG ou autres IST (HBV, VIH/SIDA)	X	X	X	X
Nécessité d'une prise quotidienne	X			
TVP ou embolie pulmonaire (Très rares)	X	X	X	X

II. PROCEDURES D'UTILISATION DES CHC

2.1. Moment d'administration des (CHC)

ETAT/CARACTERISTIQUE	COC	CIC	PATCH COMBINE	ANNEAU COMBINE
La cliente a ses menstrues				
Les 07 premiers jours du cycle menstruel représentent le moment le plus indiqué pour commencer la prise.	X	X	X	X
Après les 07 premiers jours, employer une méthode d'appoint pendant les 02 jours suivants en cas de rapport sexuel.	X	X	X	X
La cliente n'a pas ses menstrues				
A n'importe quel moment si le prestataire est certain que la cliente n'est pas enceinte. Sinon Eviter les rapports sexuels ou utiliser une méthode	X	X	X	X
barrière jusqu'aux retours des menstrues puis commencer à prendre les pilules.				
Dans le post partum (Voir chapitre contraception du post partum)				
Dans le post abortum				
Immédiatement après l'avortement ou durant les 07 premiers jours après l'avortement.	X	X	X	X
Plus tard, à n'importe quel moment si l'on est certain que la cliente n'est pas enceinte.	X			

TABLEAU COMPARATIF DESCHC

CARACTÉRISTIQUE	COC	CIC	PATCH COMBINÉ	ANNEAU COMBINÉ
FORME				
PRESENTATION	Plaquette	Flacon	Timbre	Anneau
VOIE D'UTILISATION	Orale	IM	transdermique	Transdermique
SITE D'INSERTION	Tube digestif	Bras (muscle deltoïde) Fesses	Cutanée Fesse, l'abdomen, la face extérieure de la partie supérieure du bras ou la partie supérieure du torse	Intra vaginal
MODE D'EMPLOI	1/ jour pendant 28 jours sans interruption	1 /Mois	1 /semaine pendant 3 semaines; pause de 7 jours	1 /jour pendant 21 jours; pause de 7 jours
DURÉE D'ACTION	Quotidien (24 heures)	Mensuelle (4 semaines)	Hebdomadaire	Mensuelle (4 semaines)
ADMINISTRER PAR LE PATIENT	OUI	NON	OUI	NON
EFFICACITÉ	98 - 99%	98 - 99%	99,7%	99,7%
DOSAGE	EE+Progestatif	- Acétate de Médroxyprogestérone (25 Mg) Et Cypionate D'estradiol (5 MG) - Enanthate de Norethistérone(50 MG) et de Valérianate d'Estradiol (5mg)	Norelgestromine + EE Ou Gestodène +EE	- 150 mcg Etonorgestrel - 20 Mcg EE
Adapté EUROCLINIX				

2.2. Instructions pour l'utilisation des CHC

2.2.1 COCs

- Prenez 1 pilule chaque jour, de préférence à la même heure.
- Prenez la **première** pilule entre le premier et le septième jour (le premier jour est préférable) à compter du début de votre menstruation.
- Certaines plaquettes ont 28 pilules. D'autres ont 21 pilules.
 - Lorsque la plaquette de 28 jours est vide, entamez immédiatement la nouvelle plaquette.
 - Lorsque la plaquette de 21 jours est vide, attendez une semaine (7 jours) et, ensuite, commencez à prendre la pilule de la nouvelle plaquette.
- Si vous oubliez de prendre une pilule active (hormonale) ou si débutez une plaquette avec un jour de retard ? vous devez la prendre dès que vous vous rappelez même si cela suppose que vous devez prendre 2 pilules le même jour puis continuez à prendre les pilules quotidiennement, à raison d'une chaque jour.
- Si vous oubliez de prendre 2 pilules ou plus, vous devriez prendre 2 pilules chaque jour jusqu'à ce que vous ayez rattrapé toutes les pilules. Utilisez une méthode d'appoint ou n'ayez pas de rapport sexuel pendant 7 jours. Si pas de méthode d'appoint alors, n'ayez pas de rapport sexuel jusqu'à ce que vous ayez terminé cette plaquette de pilules.
- Si pendant 2 mois ou plus, vous n'avez pas votre menstruation, vous devriez revenir à la clinique pour voir si vous n'êtes pas enceinte.
- Si la cliente **Vomit** dans les 2 heures qui suivent la prise de la pilule prendre un autre comprimé de pilule et continuer sa plaquette.
- Si la cliente vomit ou elle fait des diarrhées sévères pendant plus de 24 heures:
 - La femme devra continuer à prendre les pilules (si elle le peut) malgré l'inconfort
 - Si les vomissements ou les diarrhées sévères se poursuivent pendant 2 jours ou plus, elle devra suivre les procédures en cas d'oubli de pilule.

Consignes complémentaires de Visites initiales et de suivi COCs

- Fournir jusqu'à un an d'approvisionnement en pilules, en fonction des préférences de la femme et de l'usage prévu.
- Les programmes doivent mettre en balance le souhait de fournir à la femme le plus large accès possible à ce contraceptif et les considérations liées à l'approvisionnement en pilules et à la logistique associée.
- Le système de réapprovisionnement devra être flexible, de manière à ce que la femme puisse obtenir facilement des pilules en des quantités et à un moment qui correspondent à ses besoins.

NB : Le GELD a conclu que restreindre le nombre de cycles de pilules pouvait entraîner un arrêt non désiré de la méthode et augmenter le risque de grossesse

Instructions au cours du suivi COCs

- Toujours recommencer une nouvelle plaquette même si la femme:
 - n'a pas saigné
 - a cessé de saigner
 - ou continue de saigner.
- Ne pas s'inquiéter en cas de spotting, de nausées ou vomissements pendant **les trois premiers** mois, généralement tout rentre vite dans l'ordre.
- Vous devez vous attendre à des règles moins abondantes que d'habitude.
- Si vous allez en consultation pour toute maladie, informer votre médecin que vous êtes sous COC.

2.3. Instructions pour les clients sous CIC

- Revenez en service de PF pour une injection de CYCLOFEM ou de MESIGYNA tous les mois.
 - **Injection précoce** : lorsque l'intervalle de réinjection ne peut être respecté, l'injection de rappel peut être administré jusqu'à 7 jours plus tôt, mais cela peut perturber les schémas de saignement.
 - **Injection tardive** : lorsque l'intervalle de réinjection ne peut être respecté, l'injection de rappel peut être administré avec jusqu'à 7 jours de retard sans nécessiter de protection contraceptive supplémentaire.
- Si la cliente se présente avec plus de 7 jours de retard pour recevoir une injection de rappel de CIC, cette injection peut lui être administrée si l'on est raisonnablement certain qu'elle n'est pas enceinte. Elle devra alors s'abstenir de relations sexuelles ou utiliser une protection contraceptive d'appoint pendant les 7 jours qui suivent. Elle peut aussi utiliser à une contraception d'urgence, le cas échéant.
- Si la cliente n'a pas eu ses menstruations pendant 2 mois ou plus, elle doit venir à la clinique pour voir si elle est enceinte.

2.2.2. Instructions pour les clients du PATCH combiné

Ce contraceptif s'utilise à raison de 1 PATCH par semaine.
Une fois mis en place, il fonctionne pendant une semaine .
Puis, il faut le renouveler chaque semaine, pendant 3 semaines .
Après 03 semaines, on observe 01 semaine d'arrêt , sans PATCH, durant laquelle surviennent les règles.
Il est recommandé de vérifier le patch chaque jour. S'il est décollé : ○ le remettre aussitôt en place s'il colle encore (sans ajouter d'adhésif); ○ mettre en place un nouveau patch s'il ne colle plus; ○ une réaction cutanée étant possible, il est préférable de changer de site d'application à chaque changement de patch.
Pour éviter les oublis, le changement de patch peut être rappelé : ○ par une vignette (fournie avec les patches) collée sur l'agenda ou un calendrier; ○ par une alarme hebdomadaire (portable).
En cas de décollement ou retard d'application du patch : - Décollement partiel ou total de moins de 24 heures ou retard d'application de moins de 48 heures: • pas de risque de grossesse; • recoller ou remettre aussitôt un nouveau patch.' - Au-delà, il existe un risque de grossesse : se référer aux indications de la notice: ○ en l'absence de rapport sexuel non protégé les 5 jours précédents, protéger les rapports par une méthode barrière (préservatif) durant 7 jours; ○ en cas de rapport sexuel non protégé les 5 jours précédents, utiliser une contraception d'urgence et protéger les rapports par une méthode barrière (préservatif) jusqu'au début des règles suivantes, dans la limite de 14 jours; ○ si les règles ne surviennent pas lors de la prochaine semaine sans patch, la femme devra consulter pour vérifier l'absence d'une grossesse.

2.2.3. Instructions pour les clients de l'ANNEAU combiné

- ◆ Insérer l'anneau pendant 3 semaines
- ◆ Insérer un nouvel anneau à la 4^{ème} semaine.

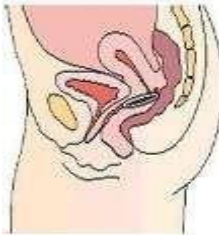
Situation clinique	Conduite à tenir
Si vous oubliez de retirer l'anneau pendant la 4 ^{ème} semaine	aucune action spéciale n'est nécessaire
Si vous laissez l'anneau en dehors du vagin pendant plus de 3 heures pendant la 1 ^{ère} ou la 2 ^{ème} semaine	- Remettre l'anneau dès que possible - Utiliser une méthode d'appoint pendant les 7 prochains jours.
Si vous laissez l'anneau en dehors du vagin pendant plus de 3 heures durant la 3 ^{ème}	- Arrêter le cycle actuel et jeter l'anneau - Insérer un nouvel anneau immédiatement et le garder en place pendant 3 semaines, commençant ainsi un nouveau cycle - Utiliser une méthode d'appoint pendant les 7 jours suivants.
Si vous attendez plus de 7 jours avant d'insérer un nouvel anneau ou a gardé l'anneau en place pendant plus de 4 semaines.	- Insérer un nouvel anneau, dès que possible et commencer un nouveau cycle de 4 semaines - Utiliser une méthode d'appoint pendant les 7 premiers jours de l'utilisation de l'anneau - De plus, si un nouvel anneau a été inséré avec 3 jours de retard ou et en cas de rapports sexuels non protégés les 5 derniers jours, envisager la contraception d'urgence.

Insertion de l'ANNEAU combiné

- Choisir la position qui est la plus confortable (debout avec une jambe surélevée, s'accroupir ou se coucher sur le dos).
- Presser ensemble les côtés opposés de l'anneau et insérer doucement l'anneau plié dans le vagin.

NB : La position exacte dans le vagin n'est pas importante, mais il faut l'insérer profondément. Les muscles du vagin gardent l'anneau en place.

- Garder l'AIV en place tout le temps, **chaque jour et chaque nuit pendant 3 semaines.**
- **Retirer l'anneau** à la fin de la 3^{ème} semaine et le jeter dans un récipient à déchets.
- L'AIV doit être inséré dans le vagin.
- La position exacte dans le vagin n'est pas importante, mais il faut l'insérer profondément.
- Les muscles du vagin gardent l'anneau en place.

ETAPE INSERTION		
Etape 1 : Déballer l'anneau vaginal	Etape 2 : Pincer l'anneau	Etape 3 : Choisir une position confortable
Ôtez l'anneau vaginal du sachet. Il s'agit d'un anneau souple de 5,4 cm de diamètre. 	Pincez l'anneau vaginal entre vos doigts, pour faciliter sa mise en place. 	Choisissez une position confortable pour insérer l'anneau. 
Etape 4 : Insérer l'anneau comme un tampon	Etape 5 : Pousser l'anneau au fond du vagin	Etape 6 : Laissez l'anneau en place trois semaines
Insérez l'anneau dans le vagin, comme si c'était un tampon avec une main, en écartant les lèvres à l'aide de l'autre main si nécessaire.	Poussez l'anneau dans le fond du vagin. Sa position n'a pas d'importance en soi. Ce qui importe, c'est qu'il tienne, et que vous ne le sentiez pas. 	Laissez l'anneau en place trois semaines. Vous l'enlèverez le même jour de la semaine où il a été inséré, ce qui permettra de déclencher les règles. 
Source DOSSIMO		

Retrait ANNEAU combiné

- ◆ Retirer l'anneau à la 4^{ème} semaine (Ne pas insérer l'anneau pendant la 4^{ème} semaine).
- ◆ Pour retirer l'anneau, insérer l'index à l'intérieur, en position de crochet ou attraper l'anneau entre l'index et le majeur.

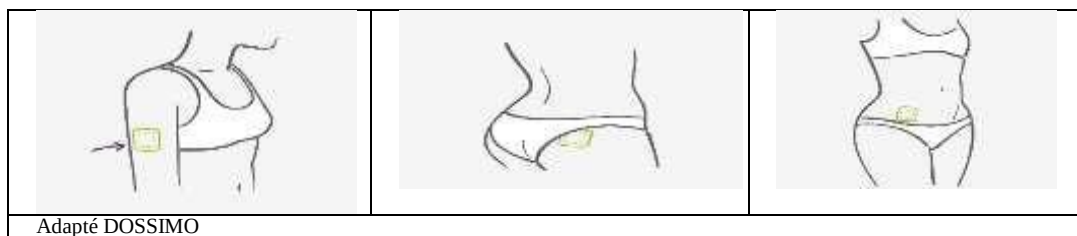
NB : Bien qu'il ne soit pas nécessaire, l'anneau peut être retiré pour des rapports sexuels, pour se nettoyer ou autres raisons mais pas de plus 3 heures en dehors du vagin

Si l'anneau glisse, elle doit le rincer dans de l'eau propre et le réinsérer immédiatement.

PATCH combiné

1	Se laver les mains
2	Soulevez la moitié de la garniture protectrice transparente.
3	Évitez de toucher avec vos doigts, la surface adhésive du timbre.
4	Placez le timbre sur la peau et enlevez l'autre moitié de la garniture.
5	Appliquer le PATCH sur le site choisi (la fesse, l'abdomen, la face extérieure de la partie supérieure du bras ou la partie supérieure du torse) mais pas sur les seins .
6	Appuyez fermement sur le timbre avec la paume de la main pendant 10 secondes, en s'assurant que les bords adhèrent bien à la peau.
7	Laisser le PATCH en place pendant le travail, les exercices, le bain, la nage...
8	S'assurer chaque jour que le timbre est bien collé.
9	Ce PATCH se remplace tous les 7 jours pendant 21 jours sur 28.
10	Remplacer le patch chaque semaine pendant 3 semaines consécutives (Appliquer chaque nouveau patch le même jour de chaque semaine).
11	Lors du remplacement, retirer et immédiatement remplacer par un nouveau à un jour fixe de la semaine (jour de changement) aux 8 ^{ème} et 15 ^{ème} jours du cycle
12	Reprendre un nouveau cycle à la fin de la quatrième semaine
13	En cas de décollement ou d'oubli, il faut remettre un nouveau patch dans les 24 heures.
14	Il est conseillé d'éviter d'exposer la région du timbre à des sources de chaleur telles qu'un sauna ou un bain tourbillon, qui pourraient théoriquement augmenter la libération d'œstrogènes dans le corps.
15	Pour retirer le timbre usagé, soulever un coin et le décoller rapidement.

NB : Le nouveau patch ne doit pas être appliqué au même endroit de la peau pour éviter l'irritation



NB : Le PATCH doit être appliqué sur une peau propre, sèche, saine, intacte, sans pilosité et à un endroit où il ne subira aucune friction due à des vêtements serrés (la fesse, l'abdomen, la face extérieure de la partie supérieure du bras ou la partie supérieure du torse). Chaque nouveau dispositif transdermique doit être placé sur la peau à **un endroit différent du précédent**, afin d'éviter toute irritation potentielle.

III. CRITERES MEDICAUXD'ELIGIBILITE

Caractéristiques	Conditions	COC	CIC	PATCH	ANNEAU
Age	Adolescente	1		1	1
	Femme ≥ 40 ans	2	1	1	1
Gestité	Nullipare	1	1	1	1
Cancer	cancer de l'endomètre ou de l'ovaire	1	1	1	1
	Cancer du col de l'utérus	2	2	2	2
	Cancer du sein	4	4	4	4
	antécédents familiaux de cancer du sein	1	1	1	1
Affections utérines	fibromes utérins	1	1	1	1
	Endométriose	1	1	1	1
	MIP	1	1	1	1
Mode de saignement	règles irrégulières	1	1	1	1
	abondantes ou prolongées	1	1	1	1
	Saignement vaginal non expliqué	2	2	2	2
	Anémie	1	1	1	1
Infection	IST	1	1	1	1
	Post partum : Les femmes qui n'allaitent pas au sein > 42 jours	1	1	1	1
Post-partum	Allaitement au sein : < 6 semaines post- partum	4	4	4	4
	Allaitement au sein entre 6 semaines et 6 Mois	3	3	3	3
	Pas d'allaitement au sein < 21 jours (s'il n'y a pas de facteurs de risque	3	3	3	3
	Allaitement ≥ 6 mois post-partum	2	2	2	2
Post abortum	immédiatement ou dans les 7 jours	1	1	1	1
Affections vasculaires	Varices	1	1	1	1
	Hypertension (antécédents ou tension de 140–159/90–99)	3	3	3	3
	thrombophlébite superficielle	2	2	2	2
	Diabète sans complications	2	2	2	2
	Hypertension ($\geq 160/\geq 100$);	4	4	4	4
	Migraines avec aura	4	4	4	4
	Cardiopathie ou AVC ischémique	4	4	4	4
	Diabète avec complications vasculaires	4	4	4	4
	Thrombose veineuse profonde (antécédents ou aiguë)	4	4	4	4
	Embolie pulmonaire (antécédents ou aiguë)	4	4	4	4
	Migraine sans aura (âgée de plus de 35 ans)	3	3	3	3
	Migraine fréquente			3	
	Trouble de la coagulation	4	4	4	4
Mode de vie	Tabagisme : ≥ 15 cigarettes/jour et ≥ 35 Ans	3	3	3	3
	Oublis fréquents de la prise quotidienne		3	3	3
Affections intestinales	Maladie symptomatique de la vésicule biliaire	3	3	3	3
Interaction médicamenteuse	RIFAMPICINE, RIFABUTINE, RITONAVIR, ANTICOVULSIVANTS	3	3	3	3
Affection du foie	hépatite (porteuse chronique).	1	1	1	1
	Hépatite aiguë; Grave maladie du foie et la plupart des tumeurs du foie	4	4	4	4

IV. EFFETS SECONDAIRES ET CONDUITE A TENIR

4.1. Effets secondaires

ETAT/CARACTERISTIQUE	COC	CIC	PATCH COMBINE	ANNEAU COMBINE
Saignotements (spotting)	X	X	X	X
Saignements plus légers et moins de jours de Saignements				X
Saignements irréguliers				X
Saignements peu fréquents				X
Saignements prolongés				X
Aménorrhées	X	X	X	X
Nausées – vomissements	X	X	X	X
Hypertension artérielle	X	X		
Prise de poids	X	X		
Maux de tête	X	X	X	X
Etourdissement	X	X		
Sensibilité des seins et douleur des seins			X	
Douleurs abdominales			X	
Troubles dans la libido	X	X		
Acné	X	X		
Saut d’humeur	X	X		
Irritation de la peau ou éruption cutanée			X	
Irritations, rougeurs ou inflammations du vagin (vaginites)				X
Pertes vaginales blanchâtres				X

4.2. Signes avertisseurs

ETAT/CARACTERISTIQUE	COC	CIC	PATCH COMBINE	ANNEAU COMBINE
Douleurs à la poitrine ou Essoufflement	X	X	X	X
Maux de tête prononcés, vision trouble(HTA)	X	X	X	X
Douleurs dans les jambes (thrombophlébites)	X	X	X	X
Absence de saignement pendant la semaine sans pilule OU PATCH OU ANNEAU	X	X	X	X

4.3. Interférence médicamenteuse

MEDICAMENTS UTILISES OU COURAMMENT PRESCRITS	EFFETS ADVERSES	COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
<u>ANALGESIQUES :</u> Acétaminophen (Tylénol, Paracétamol et autres)	Diminution possible dans l'effet soulageur de la douleur (excrétion accrue du médicament)	Suivre la réponse du soulagement de la douleur.
<u>ANTIBIOTIQUE</u> *GRISEOFULVINE ET RIFAMPICINE Aucun effet clinique ou de précaution d'emploi n'a été établi pour la pénicilline, la tétracycline, la céphalosporine et d'autres antibiotiques utilisés couramment. Les méthodes hormonales peuvent être utilisées et aucune méthode d'appoint n'est généralement nécessaire avec ces antibiotiques. (traitement de longues durée)	Effet contraceptif diminué avec les COC et les CIC, surtout avec des COC à faible dose 30-35 ug d'estradiol d'ethinyl (EE)	Aider la cliente à choisir une autre méthode ou à utiliser une pilule avec plus d'œstrogènes (50 ug EE) ou une méthode d'appoint (par exemple, les condoms).
<u>ANTIDEPRESSEURS</u> (Elavil, Norpramin, Tofranil et autres)	Effet accru possible des antidépresseurs	Utiliser avec précaution. De faibles doses sont probablement sans danger.
<u>ANTIHYPERTENSEURS</u> METHYLDOPA (ALDOCLOR, ALDOMET et autres)	Effet possible de diminution des antihypertenseurs	Utiliser les COC et les CIC avec précaution, suivre TA.
<u>ANTIEPILEPTIQUES</u> Barbituriques (Phénobarbitol et autres) Carbamazépine (Tegretol) Phénytoïne (Dilantin) Primidone (Mysoline)	Effet contraceptif diminué avec les COC et les CIC, surtout avec les COC à plus faible dose Effet accru possible de la phénytoïne	Aider la cliente à choisir une autre méthode ou à utiliser une pilule à plus forte dose (50 ug EE) ou une méthode d'appoint (par exemple, les condoms).
<u>B-BLOQUANTS</u> (Corgard, Inderal, Lopressor, Tenormin)	Effet accru possible des B- bloquants	Suivre l'état cardiovasculaire
<u>BRONCHODILATATEURS</u> Théophylline (Bronkotabs, Marax, Primat ne, QuibronTedra, Théodur et autres)	Effet accru de théophylline	Suivre les symptômes d'overdose de la théophylline et référer
<u>HYPOGLYCEMIQUES</u> DIABINESE, ORINASE, TOLBUTAMIDE, TOLINASE)	Diminution possible de l'effet hypoglycémique	Suivre glucose sanguin comme chez n'importe quelle patiente diabétique.
<u>TRANQUILLISANTS</u> Benzodiazépine (Ativan, Librium, Serax, Tranxène, Valium, Xanax et autres)	Effets augmentés ou diminués possibles des tranquillisants, y compris problèmes psychomoteurs.	Utiliser avec précaution. Les posologies prescrites couramment n'entraîneront probablement pas d'effets significatifs.

Vu que la griséofulvine n'est généralement diffusée que pendant un court laps de temps

(2 à 4 semaines), les femmes qui la prennent pour des infections fongiques peuvent continuer à utiliser les COC et les CIC. Elles devraient utiliser une méthode d'appoint lors de la prise de la griséofulvine et jusqu'au début de la prochaine menstruation après avoir arrêté l'antibiotique.

V. CALENDRIER DE SUIVI DESCHC

5.1. Calendrier de suivi COCs

Visite	Quantité	CAT
Visite initiale	1 plaquette	Rendez-vous dans 25 jours.
1^{ère} visite de contrôle (25 jours après la visite initiale)	1 à 3 plaquettes	- Faire expliquer par la cliente, comment elle prend ses pilules.(sur les horaires de prise) - Rechercher par l'interrogatoire, d'éventuels signes tels que : céphalées intenses, troubles visuels, douleurs dans la poitrine, douleurs abdominales, douleurs sévères dans les jambes. - Vérifier la survenue d'éventuels effets secondaires. Savoir que certains de ces effets secondaires sont passagers (ne durent pas après 3 mois), mais devant la persistance de certains, référer.
2^{ème} visite de contrôle	3 à 6 Plaquettes	Si aucun problème
Prochaines visites de suivi	6 plaquettes et plus	- Tous les 3 à 5mois. - Rechercher les effets secondaires par l'interrogatoire. - Effectuer un examen clinique complet. - Traiter les éventuels problèmes;

5.2. Calendrier de suivi PATCH combiné : Un suivi médical régulier au moins une fois par an.

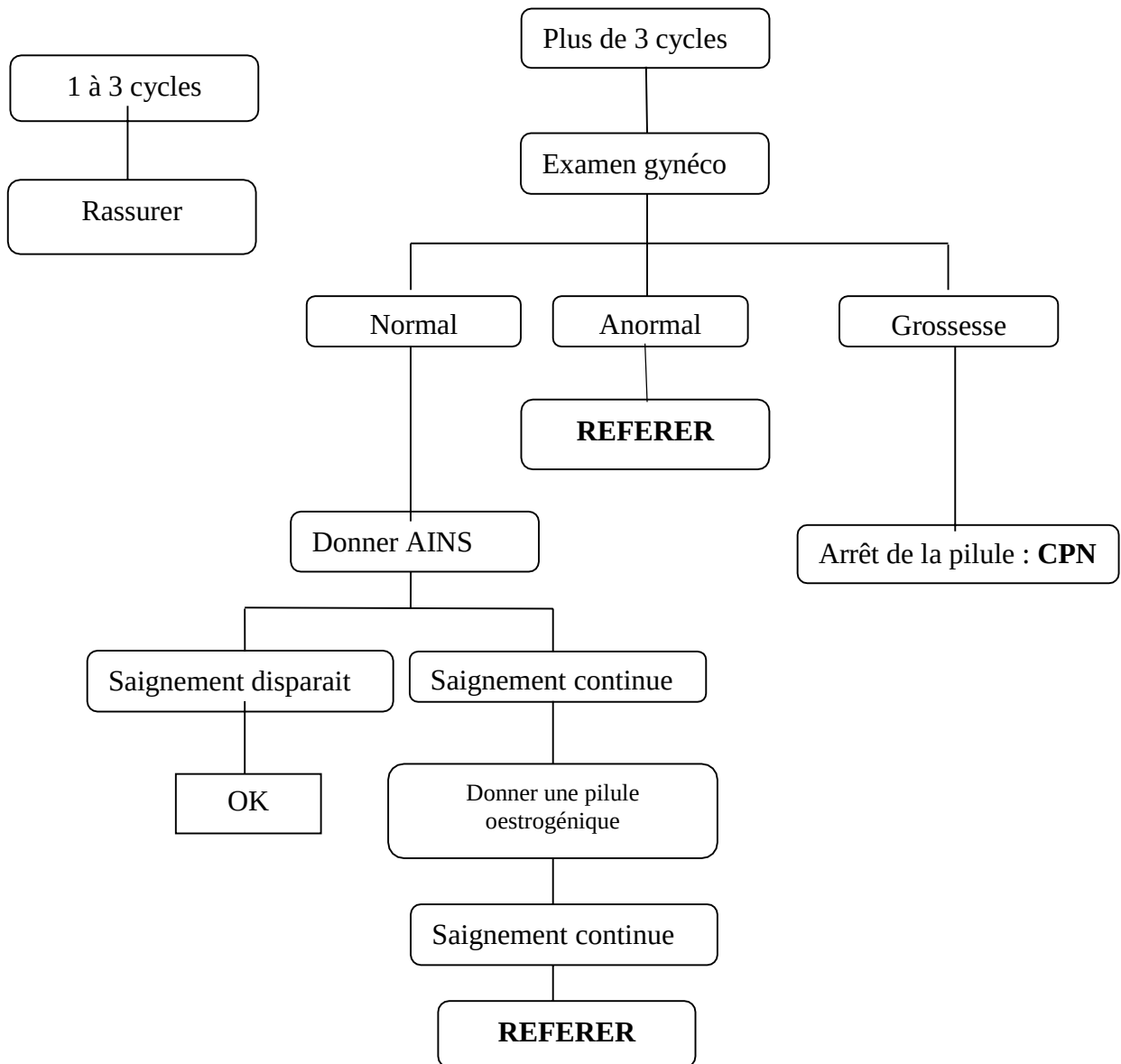
5.3. Calendrier de suivi ANNEAU combiné : Une visite annuelle de suivi est recommandée après la mise en route d'anneau.

5.4. Calendrier de suivi CIC

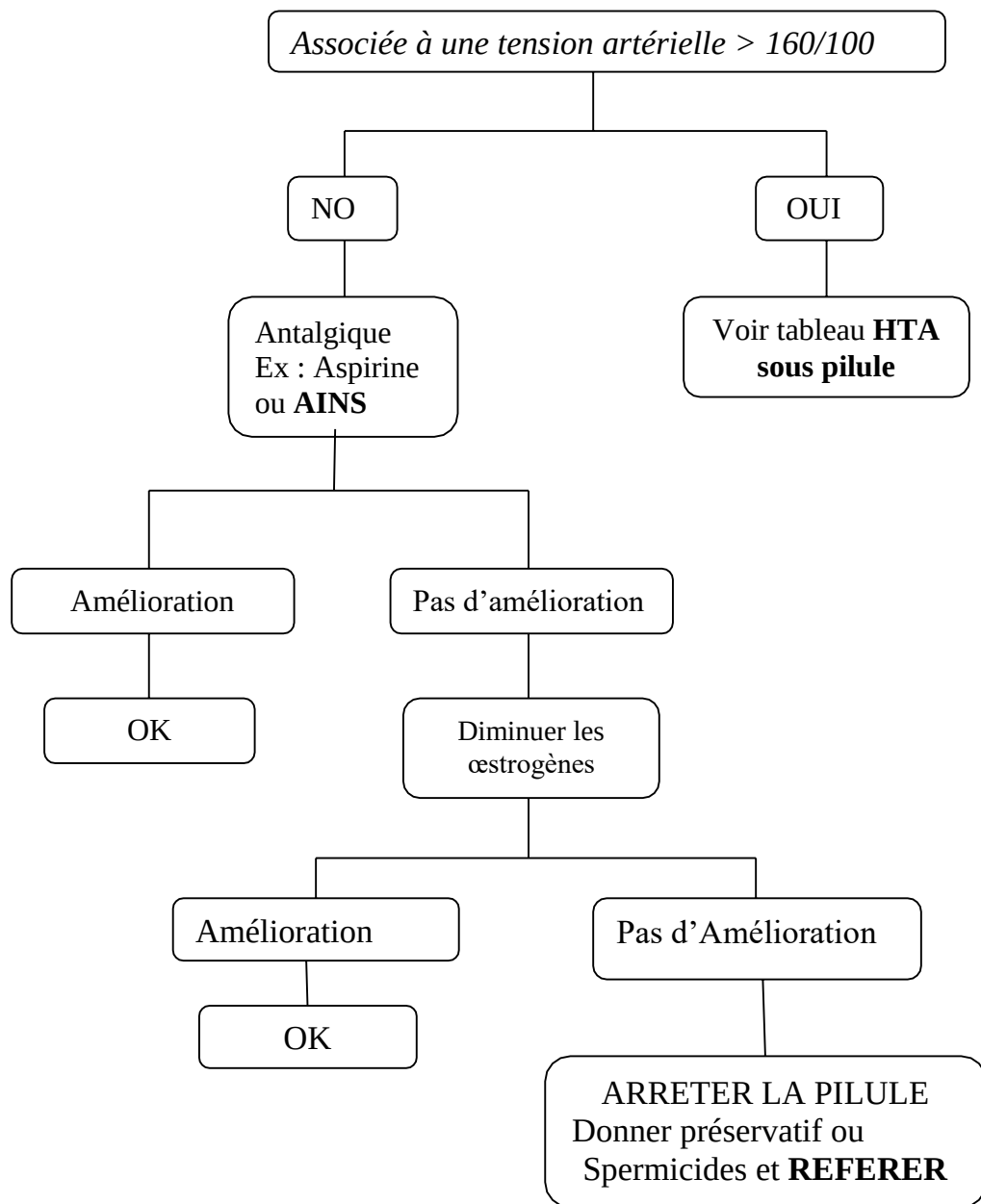
Intervalle de réinjection : Des injections de rappel de CIC devront être administrées toutes les quatre semaines.

CAT DEVANT LES EFFETS SECONDAIRES (ARBRES DECISIONNELS)

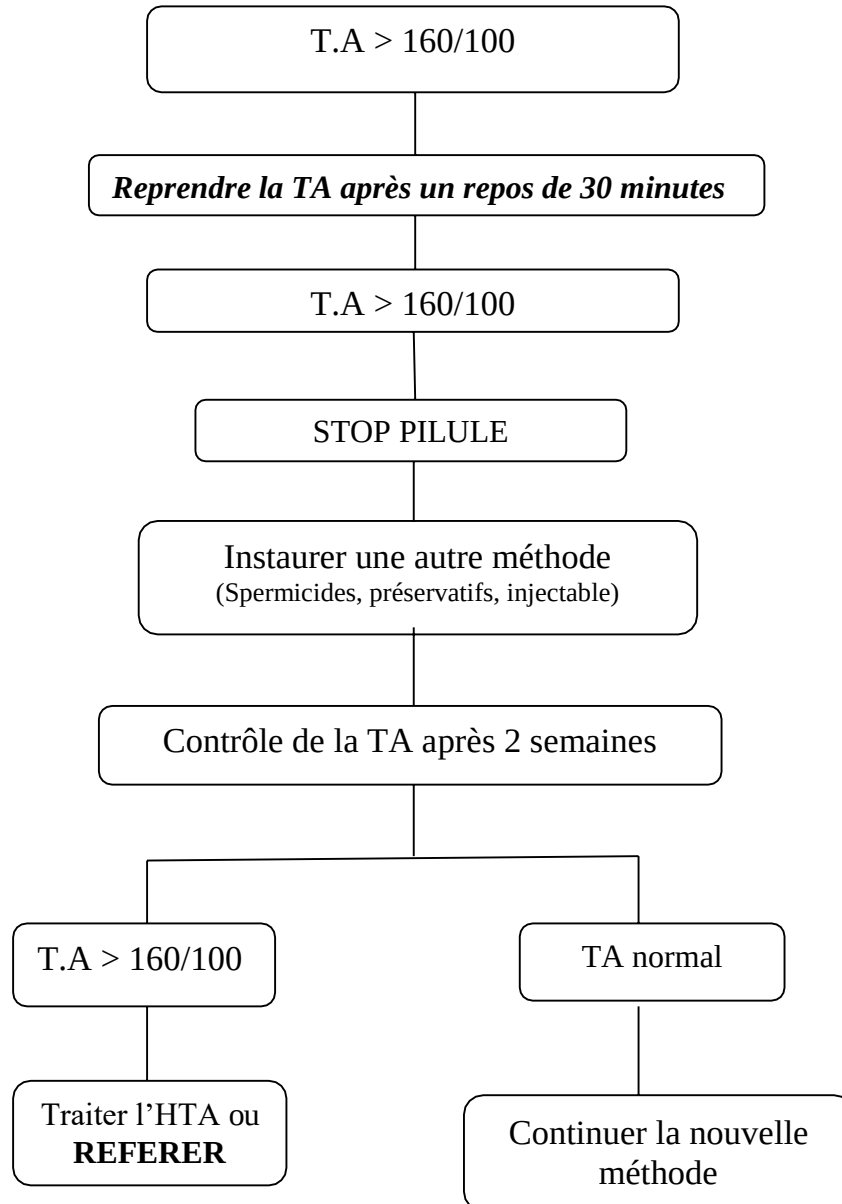
CONDUITE A TENIR DEVANT PERTES DE SANG (SPOTTING) SOUS PILULE



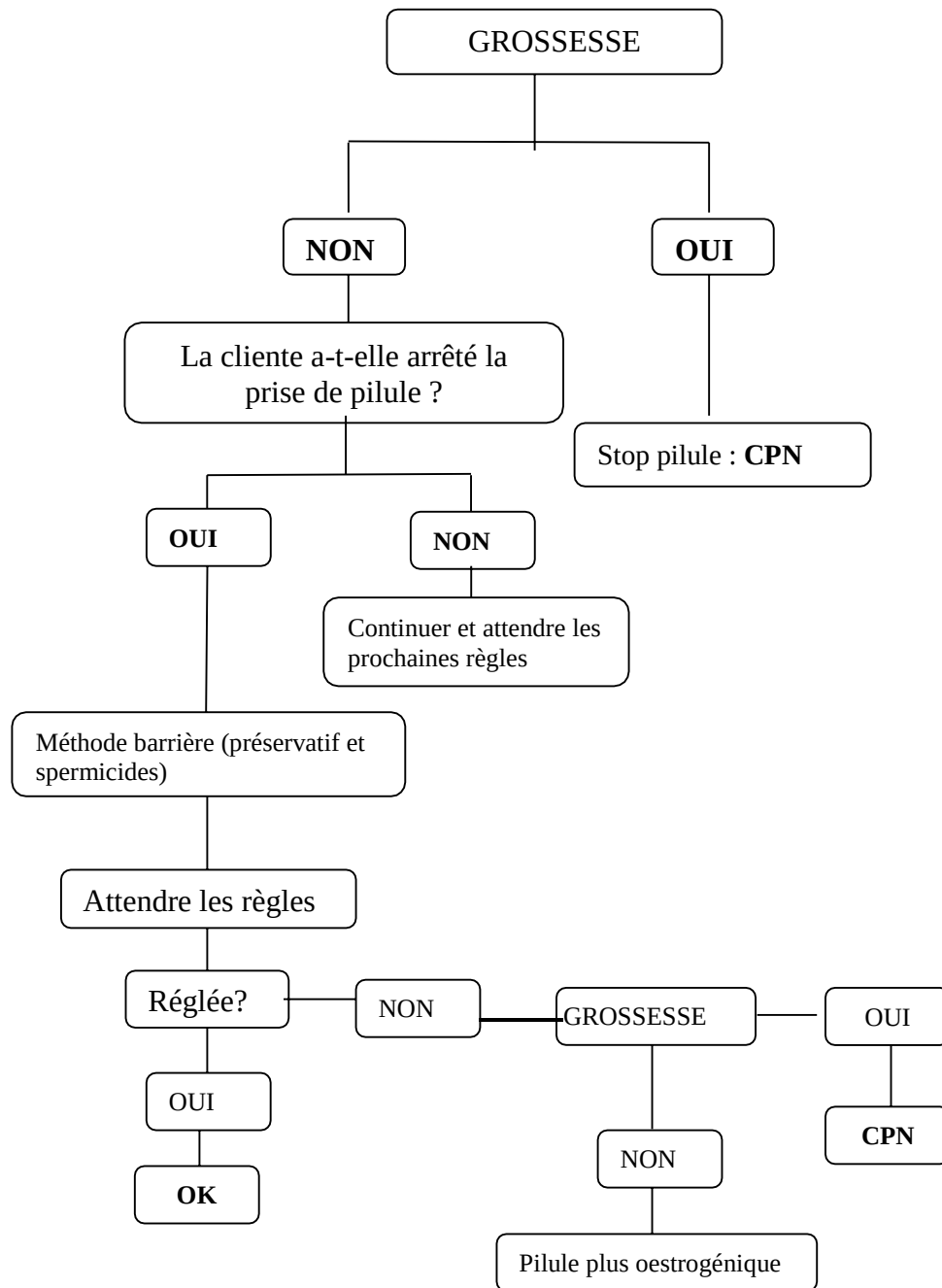
**CONDUITE A TENIR DEVANT MIGRAINE PERSISTANTE
SOUS PILULE**



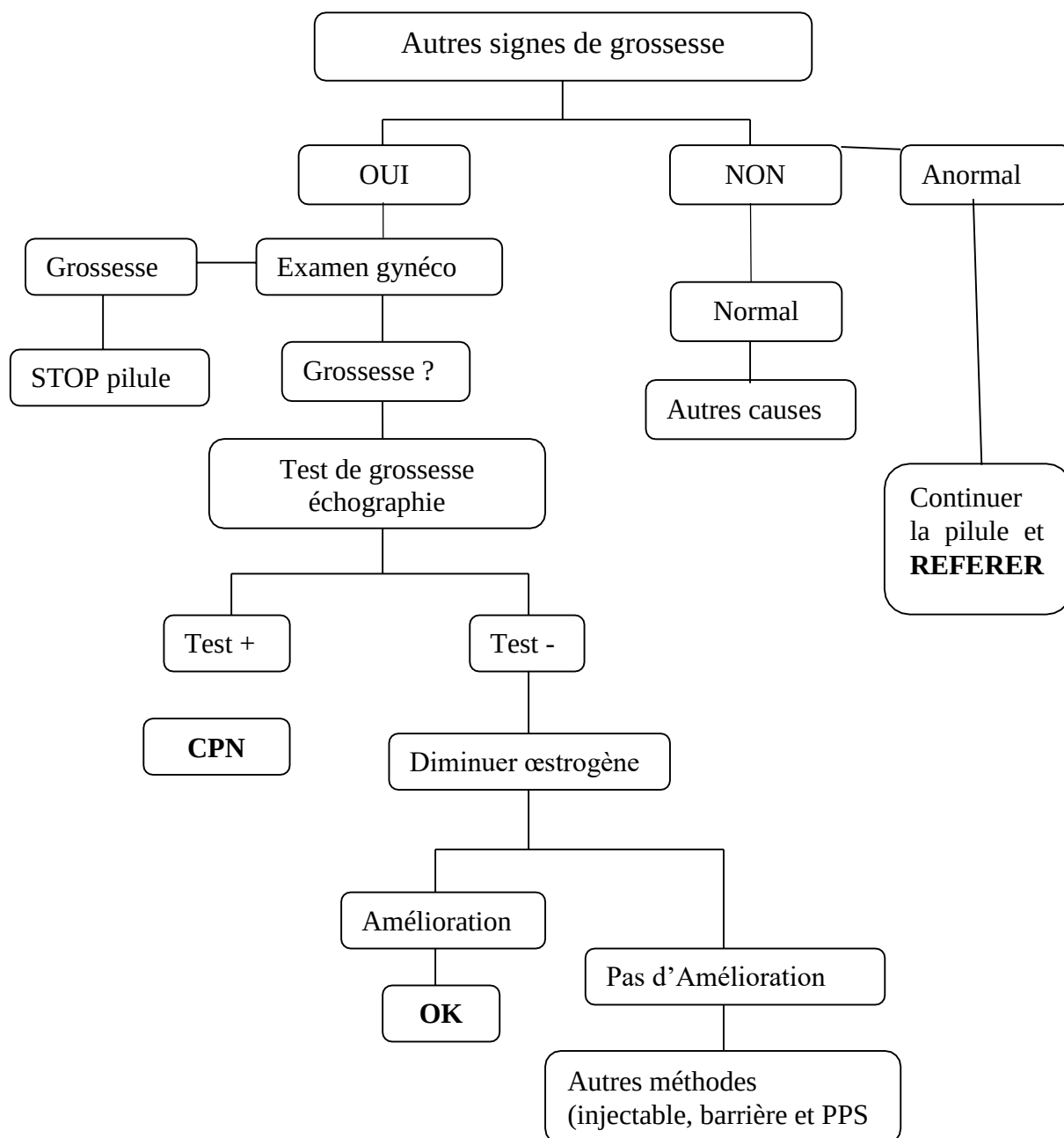
**CONDUITE A TENIR DEVANT HYPERTENSION ARTERIELLE SOUS
PILULE**



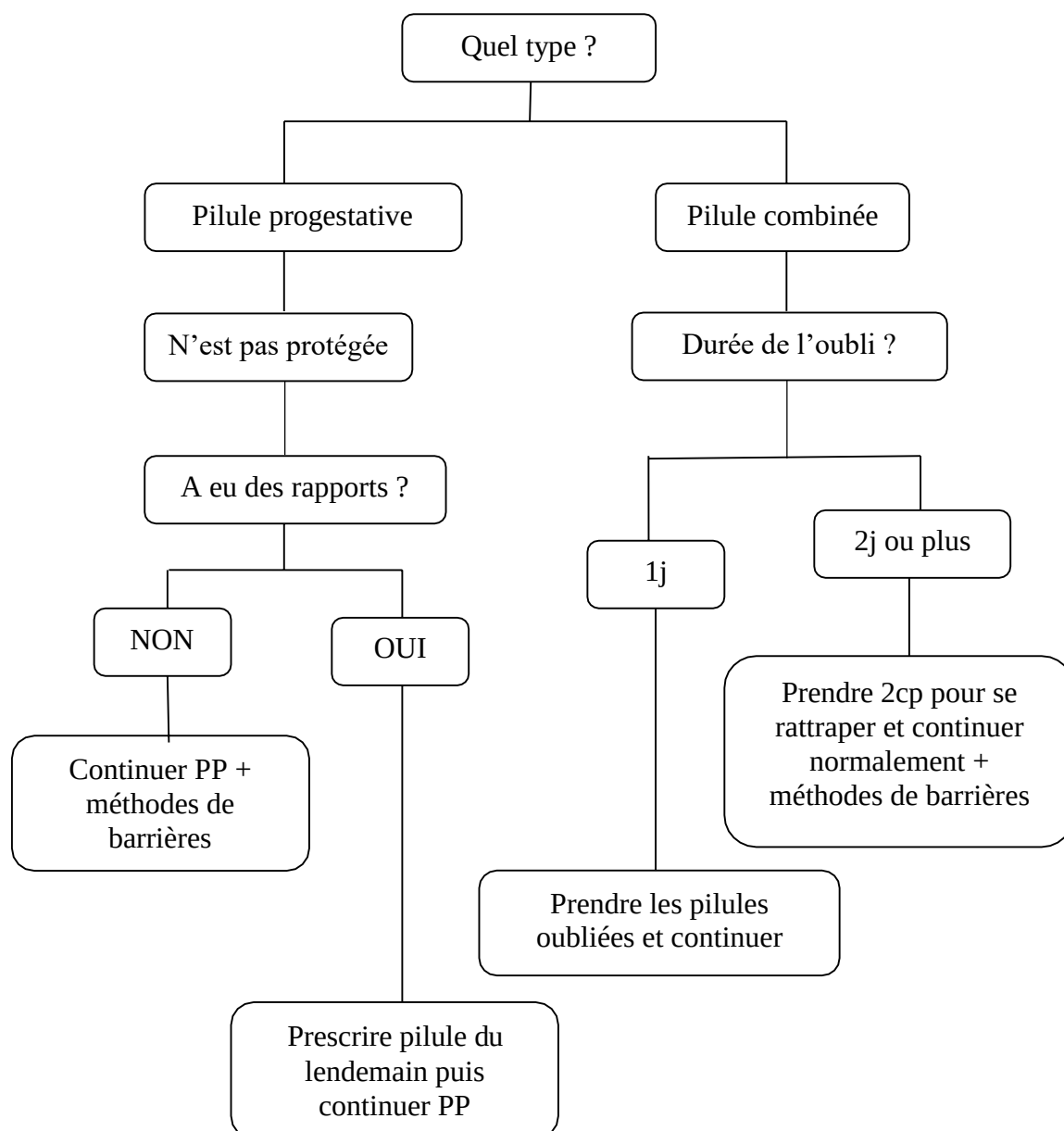
CONDUITE A TENIR DEVANT AMENORHEE SOUS PILULE



CONDUITE A TENIR DEVANT NAUSEES PERSISTANTES APRES LA 3ème PLAQUETTE, OU SURVENANT APRES LA 3ème PLAQUETTE



CONDUITE A TENIR DEVANT OUBLI DE PILULE



RECAPITULATIF

1. Définir: COC, Patch combiné, anneau vaginal combiné, contraceptif injectable combiné.
2. Décrire les caractéristiques de chaque type de CHC.
3. Expliquer les procédures d'utilisation, de suivi et indiquer quand revenir au centre.
4. Enumérer les interférences médicamenteuses des CHC
5. Sélectionner les clientes répondant aux critères de recevabilité pour chaque méthode.
6. Expliquer comment faire devant chaque effet secondaire
7. Reconnaître les clientes qui doivent consulter pour complication liées aux CHC.

CONTRACEPTIFS HORMONAUX PROGESTATIFS (CHP)

PREREQUIS : L'apprenant doit avoir au préalable lu et/ou assimilé le contenu des chapitres suivants :

- Contraceptifs hormonaux combinés
- Critères d'éligibilité définis par l'OMS. (cf Support pédagogique de PF/GL2019)

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître les conditions de prescription des contraceptifs hormonaux progestatifs (CHP).

ENONCES DE RESULTATS

A la fin du cours les apprenants seront capables de :

1. Décrire correctement les contraceptifs hormonaux progestatifs (CHP).
2. Identifier les clientes répondant aux critères de recevabilité pour chaque CHP.
3. Expliquer correctement les procédures l'utilisation,
4. Décrire la conduite à tenir devant les effets secondaires.

I. DESCRIPTION DES CONTRACEPTIFS HORMONAUX PROGESTATIFS (CHP).

1.1. Définitions

DEFINITIONS CHP
Les Contraceptifs Hormonaux Progestatifs (CHP) désignent des produits contraceptifs qui diffusent uniquement une hormone progestative. Les CHP abordés sont : les Contraceptifs Oraux Progestatifs (COP), les CIP injectables et les implants sous cutanée.
CONTRACEPTIF ORAUX PROGESTATIF (COP)
Ce sont des pilules progestatives qui renferment de très petites quantités d'une seule hormone progestative. Les COP encore appelés minipilules ou micro pilules, elles sont en prise continue (en général toutes les pilules d'une plaquette sont actives)
CONTRACEPTIFS INJECTABLES PROGESTATIFS
Les contraceptifs injectables progestatifs sont des produits contraceptifs qui contiennent chacun un progestatif analogue à la progestérone administrée par voie parentérale pour éviter la survenue d'une grossesse.
IMPLANT SOUS CUTANEE
Ce sont des capsules fines, souples contenant du Levonorgestrel (hormone synthétique) que l'on place à la face interne du bras 6 à 8 cm du pli du coude.

1.2. Caractéristiques des CHP

TABLEAU COMPARATIF DES CONTRACEPTIFS ORAUX PROGESTATIFS

NOM COMMERCIAL	OVRETTE	MICROLUT
PRESENTATION		
HORMONE	NORGESTREL	LEVONORGESTREL
DOSAGE	0,075 µg	0,03 µg
NOMBRE DE COMPRIMES	28	35
DUREE D'ACTION	24 H	24 H
ADMINISTRER PAR LA PATIENTE	OUI	OUI

TABLEAU COMPARATIF DES CONTRACEPTIFS INJECTABLES PROGESTATIFS

CARACTÉRISTIQUES	DEPO-PROVERA	SAYANA® Press	NORISTÉRAT
Présentation			
DCI	Acétate de Médroxyprogestérone Retard (AMPR)	Acétate de Médroxyprogestérone Retard (AMPR)	Enantate de noréthistérone (NET-EN)
Mg/dose	150 mg	104 mg / 0,65ml	200 mg
Emballage	Fiole et seringue	Seringue Uniject préremplie	Fiole et seringue
Type d'injection	Intramusculaire	Sous-cutanée	Intramusculaire
Où administrer l'injection?	- Bras (muscle deltoïde) - Fesses	- Cuisse antérieure (face antérieure) - Abdomen - Arrière du bras	- Bras (muscle deltoïde) - Fesses
Irritation de la peau	Peu probable.	Un peu irritée	Peu probable
Durée d'action	3 mois	3 mois	2 mois
Administrer par le patient	NON	OUI	NON
Efficacité	99,7%	99,7%	99%

TABLEAU COMPARATIF DES IMPLANTS SOUS-CUTANEE

NOM COMMERCIAL	IMPLANON NXT	SINO-IMPLANT II	JADELLE	NORPLANT
Présentation	Dispositif d'insertion stérile, jetable, Préchargé	Trocart jetable stérile	Trocart jetable stérile	
				
Type de progestérone	Etonorgestrel (ETO)	Levonorgestrel (LNG)	Levonorgestrel (LNG)	Levonorgestrel (LNG)
Dosage	68 mg	75 mg x 2 =150 mg	75 mg x 2 =150 mg	216 mg
Nombre de bâtonnet	01	02	02	06
Dimension	2 mm x 40 mm	2,4mm x 34 mm	2,5 mm x 43 mm	2,4mm x 34 mm
Durée d'action	3 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Administrer par le patient	NON	NON	NO N	NON
Efficacité pratique	99,99%	99%	99 %	
Adapté www. Choisisrcontraception				

1.3. Mode d'action CHP

ACTION	COP	CIP	IMPLANT
Epaissit la glaire cervicale empêchant la pénétration des Spermatozoïdes	X	X	X
Change l'endomètre rendant la nidation plus difficile	X	X	X
Diminue le transport des spermatozoïdes dans les trompes de Fallope	X	X	X
Bloque partiellement l'ovulation	X	X	X

1.4. Avantages CHP

AVANTAGES	COP	CIP	IMPLANT SOUS CUTANEE
Avantages contraceptifs			
Efficace immédiatement (24 heures)	X	X	X
Très efficace 99,99%			X
N'interfère pas avec les rapports sexuels	X	X	X
N'affecte pas l'allaitement au sein lorsque les contraceptifs oraux progestatifs COP sont donnés à 6 semaines du post-partum	X	X	X
Peut être arrêtée à n'importe quel moment sans l'aide d'un prestataire	X	X	X
Est sous le contrôle de la femme	X	X	
Peu d'effets secondaires	X	X	X
Réversible	X	x	
Peut être utilisé par une femme qui allaite	X	X	
Utilisé par les agents de santé communautaire (SAYANA® Press)		X	
Pré-rempli avec la bonne dose (SAYANA® Press)		X	
Utilisation discrète		X	
Ne contient pas d'œstrogène	X	X	X
Facile d'utilisation			X
Protection de plus ou moins longue durée		X	X
Avantages sanitaires			
Diminue les crampes menstruelles	X	X	X
Diminue les saignements menstruels	X	X	X
Réduit le risque d'anémie	X	X	X
Protège contre le cancer de l'endomètre	X	X	X
Diminue le risque de survenue des maladies bénignes du Sein	X	X	X
Protège contre certaines causes des MIP	X	X	X
Maladies bénignes des seins	X		X
Prévient les grossesses extra utérines	X		X
Les clientes pourraient préférer la plus petite aiguille (SAYANA® Press)		X	
Amoindrit les crises drépanocytaires		X	
Pas d'ennui métabolique			X
Peut être inséré immédiatement après accouchement.			X

1.5. Limites des CHP

ETAT /CARACTERISTIQUE	COP	CIP	IMPLANT SOUS CUTANEE
Respect rigoureux dans la prise des COP	X		
Troubles du cycle (Spotting et aménorrhée etc...)	X	X	X
Efficacité amoindrie avec la prise concomitante des médicaments antituberculeux et convulsivants.	X	X	X
Risque de grossesse très élevé si retard de prise ou oubli (les effets protecteurs des PP sont fortement diminués si elles sont prises avec plus de 3 heures de retard)	X		
Efficacité par rapport au coût, dépend de la durée d'utilisation			X
Nécessite un personnel qualifié			X
Ne protège pas contre les IST/VIH	X	X	X
Peut être visible (Petite bosse sous la peau)			X
Risque d'infection au site d'insertion au début.			X
Peut entraîner quelques effets secondaires (Spotting, aménorrhée ...)			X
Retrait peut être difficile (insertion inadéquate, manque d'habileté)			X
Respecter la PI		X	X
L'efficacité peut être diminuée avec la prise d'autres médicaments.			X
Son action ne peut être arrêtée immédiatement		X	
Retard dans le retour à la fécondité		X	
Prise de poids éventuelle		X	

II. CRITERES MEDICAUX D'ELIGIBILITE DES CHP

Catégorie OMS	Conditions/caractéristiques	COP	CIP	IMPLANT
Catégorie 1	Femmes qui ont ou n'ont pas eu d'enfants	X	X	X
	Femmes de tous les âges	X	X	X
	Adolescentes et femmes de plus de 40 ans	X	X	X
	Tabagisme	X	X	X
	Infection par le VIH ou IST ou le SIDA, y compris celles qui suivent un traitement antirétroviral	X	X	X
	Règles prolongées abondantes	X	X	X
	Hypertension légère (<159/99 mm Hg)	X	X	X
	Diabète sans complication vasculaire	X	X	X
	Antécédent de TVP	X	X	X
	AMPR : obésité avec IMC >30 kg/m2 chez les femmes moins de 18 ans	X	X	X
	NET-EN : femme utilisant certains types d'ARV (inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse ou inhibiteur de la protéase boostée par RITANOVIR)	X	X	
	NET-EN : femmes prenant des anticonvulsifs précis (PHENYTOINE, CARBAMAZEPINE, BARBITURIQUES, PRIMIDONE, TOPIRANOLE OU OSCARBAZEPINE).	X	X	X

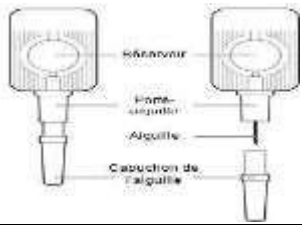
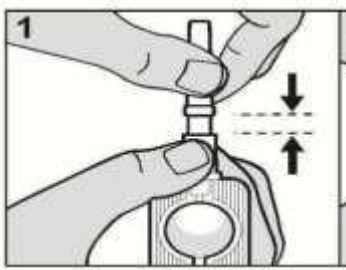
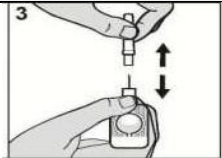
Catégorie OMS	Conditions/caractéristiques	COP	CIP	IMPLANT
Catégorie 2	Diabète avec complication vasculaire	X	X	X
	Migraines sans aura	X	X	X
	Migraines avec aura	X	X	X
	Initiation de la méthode	X	X	X
	Hyperlipidémies connues	X	X	X
	Cancer du col de l'utérus	X	X	X
	Règles irrégulières	X	X	X
	Traitement ARV	X	X	X
	TA élevée : 140/90mmHg)	X	X	X
	TVP/EP et traitement par anticoagulant.	X	X	X
Catégorie 3	Allaitement au sein avant 6 semaines PP	X	X	X
	TVP/EP (caillot sanguin aigu dans les veines profondes des jambes ou des poumons)	X	X	X
	Saignement vaginal inexplicable,	X	X	X
	Grave hypertension ($\geq 160/\geq 100$ mm Hg),	X	X	X
	Hépatopathie grave	X	X	X
	La plupart des tumeurs hépatiques.	X	X	X
	Diabète avec complications.	X	X	X
Catégorie 4	Cancer du sein en cours	X	X	X

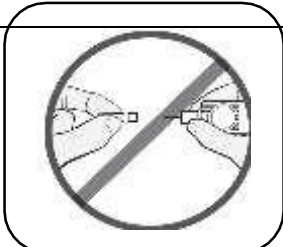
III- PROCEDURES D'UTILISATION DES CHP

3.1. Moment d'administration

ETAT/CARACTERISTIQUE	COP	CIP	IMPLANTS
La cliente a ses menstrues			
Les 05 premiers jours du cycle menstruel représentent le moment le plus indiqué pour commencer la prise.	X		
Après les 05 premiers jours, employer une méthode d'appoint pendant les 02 jours suivants en cas de rapport sexuel.	X		
Les 07 premiers jours du cycle menstruel représentent le moment le plus indiqué pour commencer la prise.		X	X
Après les 07 premiers jours, employer une méthode d'appoint pendant les 02 jours suivants en cas de rapport sexuel.		X	X
La cliente n'a pas ses menstrues			
A n'importe quel moment si le prestataire est certain que la cliente n'est pas enceinte. Sinon éviter les rapports sexuels ou utiliser une méthode barrière jusqu'aux retours des menstrues puis commencer à prendre les pilules.	X	X	X
Dans le post partum (Voir chapitre contraception du post partum)			
Dans le post abortum			
Immédiatement après l'avortement ou durant les 05 premiers jours après l'avortement.	X	X	X
Immédiatement après l'avortement ou durant les 07 premiers jours après l'avortement.		X	X
Plus tard, à n'importe quel moment si l'on est certain que la cliente n'est pas enceinte.	X	X	X

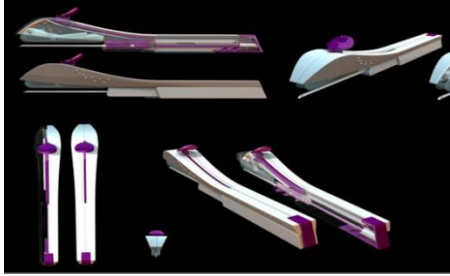
3.2. ETAPES D'ADMINISTRATION SAYANAPRESS

N°	ETAPES	TACHES
1	Laver les mains	- Se laver bien les mains après avoir préparé les fournitures/matériels et avant d'administrer l'injection avec de l'eau et du savon. - Faire sécher les mains à l'air.
2	Sélectionner un site d'injection	• Bras (partie postérieure) • abdomen (pas au nombril) • cuisse (face antérieure)
3	Nettoyer le site d'injection	Le site d'injection doit être nettoyé avec du coton imbibé d'eau propre.
4	Ouvrir le sachet 	- Vérifiez la date d'expiration inscrite sur le sachet. - Ouvrez le sachet et retirez l'Uniject. - Assurez-vous qu'il est à température ambiante. - Revoyez les composantes de l'Uniject.
5	Nettoyer le site d'injection	Le site d'injection doit être nettoyé avec du coton imbibé d'eau propre.
6	Mélanger la solution	- Tenez l'Uniject par le porte aiguille. - Secouez-le vigoureusement pendant 30 secondes. - Assurez-vous que la solution est bien mélangée et qu'il n'y a pas de cassure ou de fuites.
7		- Maintenir l'Uniject par le porte aiguille. - Orienter l'Uniject vers le haut lors de l'activation afin d'éviter des écoulements.
N°	ETAPES	TACHES
8		Enlever le capuchon de l'aiguille
9	insertion dans le bras 	- Insérez directement dans - La peau par un angle orienté vers le bas. - Un angle légèrement orienté vers le bas permet d'éviter l'injection d'air. - L'aiguille ne doit jamais être pointée vers le haut lors de l'injection. - Tenir le porte-aiguille en insérant l'aiguille. - Insérer avec un angle vers le bas. - Le porte-aiguille doit toucher la peau.
10	Insérer l'aiguille dans l'abdomen 	- Tenir le porte-aiguille en insérant l'aiguille. - Insérer avec un angle vers le bas. - Le porte-aiguille doit toucher la peau. - Eviter le nombril

11	Insérer l'aiguille sur la cuisse 	- Tenir le porte aiguille en insérant l'aiguille. - Insérer avec un angle vers le bas. - Le porte-aiguille doit toucher la peau.
12	Presser le réservoir 	- Pressez le réservoir Lentement - 5 à 7secondes. - Ne nettoyez pas ou ne massez pas le site après l'injection.
13	JETER L'UNIJECT  Mettre dans une boîte de sécurité	 Ne pas récapuchonner l'uniject
Manuel de formation SAYANA		

3.3. ETAPES D'ADMINISTRATION DIMPLANON NEXT

Liste du matériel pour la pose et le retrait de l'implant

Méthode	Matériel
IMPLANON NXT Implanon est inséré à l'aide d'un applicateur fabriqué tout spécifiquement et qui est analogue à une seringue)	
Insertion JADELLE	Trocard - Pince à disséquer – Capsules - Deux champs (01 troué et 01 non troué) – Cupule - Xylocaïne à 0,1% ou sans adrénaline- Seringue- Compresse stériles - Bétadine jaune et rouge - Sparadrap - Gants stériles.
Retrait	Pince de Kocher avec griffe et sans griffe - Lame de bistouri - Deux champs (1 troué et 1 non troué) - Cupule - Xylocaïne à 0,1% ou sans adrénaline - Seringue. Compresse stériles - Bétadine jaune et rouge – Sparadrap - Gants stériles.

3.4. DIFFERENTES ETAPES (INSERTION ETRETRAIT)

➤ Prévention des infections

Préparation

- Demandez à la cliente de se laver le bras
- Recouvrez la table d'examen
- Préparez un plateau de chirurgie propre
- Ouvrez le paquet d'instruments stériles

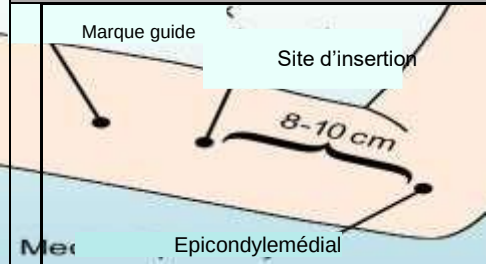
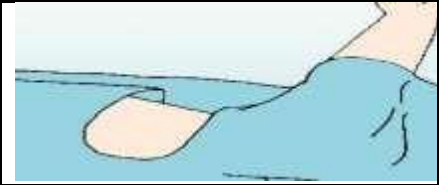
❖ Avant la pose ou le retrait

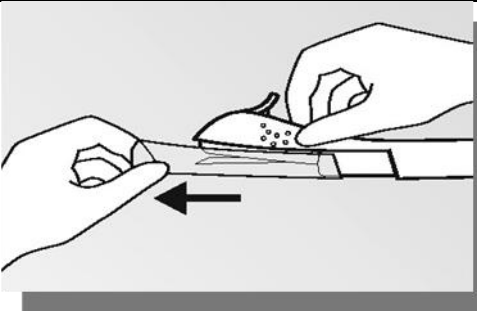
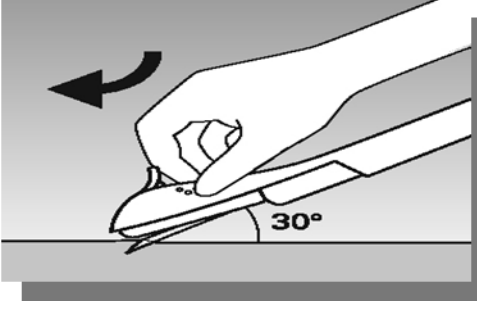
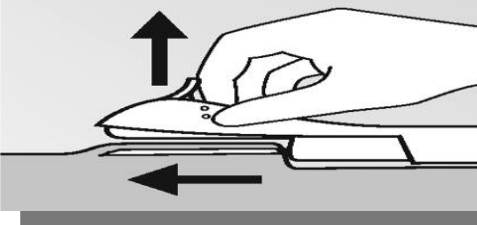
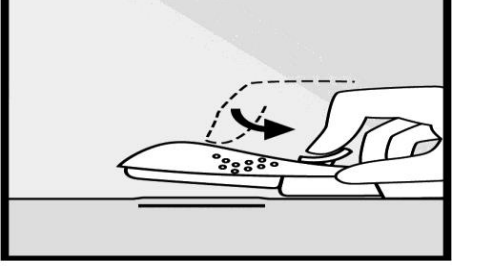
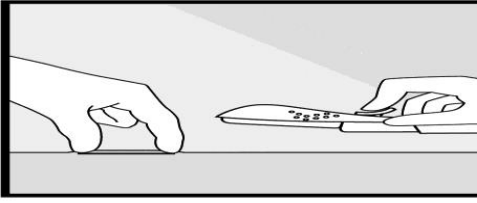
- Se laver soigneusement les mains et mettre des gants.
- Nettoyer le site de la pose ou du retrait.
- Utiliser un drap chirurgical stérile avec une ouverture au-dessus du site.
- Utiliser une nouvelle seringue et une nouvelle aiguille jetables.

❖ Après la pose ou le retrait

- Arrêter tout saignement avec une compresse et nettoyez le site d'insertion ou de retrait.
- Appliquer un bandage stérile adhésif.
- Placer les instruments pointus dans un contenant de sécurité.
- Décontaminer les instruments.
- Eliminer les objets contaminés.
- Stérilisez les instruments et les gants.
- Décontaminez toutes les surfaces.
- Lavez-vous les mains au savon.

3.5. INSERTION DOUCE D'IMPLANONNEXT

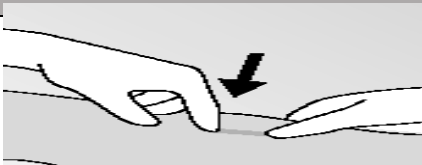
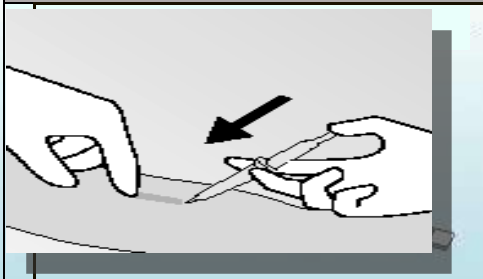
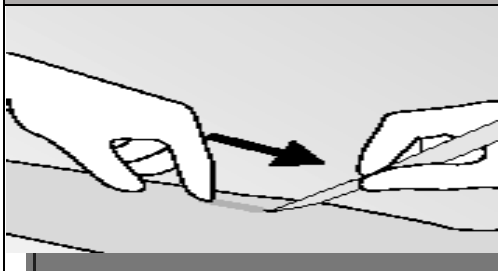
ETAPE 1	
	- Demander à la cliente de s'allonger sur le dos avec le bras non dominant plié au niveau du coude et dirigé vers l'extérieur. - L'implanon doit être posé par insertion sous-cutanée
ETAPE 2	
	- Retirez de l'emballage, l'applicateur stérile jetable qui contient l'Implanon. - En gardant le capuchon sur l'aiguille, vérifiez visuellement la présence de l'implant qui apparaît comme un corps blanc à l'intérieur du bout de l'aiguille.
ETAPE 3	
	- Marquez l'endroit de la pose avec un marqueur. - Faites 2 marques : *D'abord, marquez le point où le bâtonnet sera inséré. *Ensuite, marquez un point à quelques centimètres de la première marque. Cette seconde marque servira plus tard de guide de direction lors de la pose
ETAPE 4	
	- Nettoyez le bras de la cliente avec une solution antiseptique. - Encadrez la zone de l'insertion avec un drap stérile qui comporte une ouverture (facultatif). - Anesthésiez le site d'insertion avec un anesthésique en spray ou par injection de 2 cc de lidocaïne à 1 % immédiatement sous la peau le long du tunnel d'insertion prévu.

ETAPE 5	
	- Tenez l'applicateur juste au-dessus de l'aiguille au niveau de la surface rugueuse et enlevez la protection de l'aiguille en plastique transparent qui entoure l'aiguille contenant l'implant - Ne touchez pas la gâchette de couleur mauve jusqu'à ce que vous ayez enfoncé complètement l'aiguille sous la peau, sinon elle provoquera la rétraction de l'aiguille et relâchera l'implant de l'applicateur
ETAPE 6	
	- Etendre la peau autour du point d'insertion à l'aide du pouce et de l'index - Piquez la peau avec la pointe de l'aiguille à un angle d'environ 30° - Ne touchez pas la gâchette de couleur mauve jusqu'à ce que vous ayez enfoncé complètement l'aiguille sous la peau, sinon elle provoquera la rétraction de l'aiguille et relâchera l'implant de l'applicateur
ETAPE 7	
	- Abaissez l'applicateur dans une position horizontale - Pendant que vous soulevez la peau avec la pointe de l'aiguille glissez l'aiguille sous la peau sur toute sa longueur
ETAPE 8	
	- Pendant que vous maintenez l'applicateur dans la même position et l'aiguille enfoncée sur toute sa longueur, enfoncez légèrement la gâchette mauve en poussant vers l'arrière - Poussez la gâchette le plus loin possible vers l'arrière jusqu'à la butée - l'implant est dans sa position finale sous-dermique et l'aiguille est verrouillée dans le corps de l'applicateur. NB : Insérer l'aiguille sur toute sa longueur est crucial; ne pas le faire aura pour résultat un implant partiellement visible sortant de la peau
ETAPE 9	
	vérifier la présence de l'implant par palpation et demandez également à la femme de palper l'implant elle-même.
	- Appliquez une compresse stérile avec un bandage compressif pour minimiser les ecchymoses. La femme peut retirer le bandage compressif après 24 heures et le petit pansement au bout de 3-5 jours - Avant de renvoyer la cliente, observez-la pendant quelques minutes pour vérifier que le site d'insertion ne saigne pas. - Remplissez la carte de la patiente et donnez-la à la cliente. - Récapitulez les instructions sur la période qui suit la pose et les autres messages importants. - Éliminez comme il se doit l'applicateur et la seringue.

Signes qui doivent faire revenir (implant)

- ◆ Retard de la menstruation après plusieurs mois du cycle régulier (peut être un signe de grossesses)
- ◆ Vive douleur au bas ventre (peut être un symptôme de grossesse extra-utérine)
- ◆ Saignement abondant (deux fois plus long ou deux fois plus que la normale) ou saignement prolongé (plus de 8 jours)
- ◆ Pus ou saignement à l'endroit de l'insertion
- ◆ Expulsion d'une capsule
- ◆ Migraine (Maux de tête vasculaires), maux de têtes très prononcés et fréquents ou vision trouble.
- ◆ Contactez un prestataire de services ou une clinique si vous notez un des problèmes susmentionnés.

3.6. RETRAIT D'IMPLANON NEXT

ETAPE 1	
	• Localisez l'implant par palpation et marquez l'extrémité distale • Laver la zone et appliquer un désinfectant
ETAPE 2	
	• Injecter l'anesthésique local <u>sous</u> l'implant pour qu'il reste près de la surface de la peau.
ETAPE 3	
	• Enfoncez la pointe proximale pour fixer l'implant. Un renflement peut apparaître indiquant l'extrémité distale de l'implant • A partir de l'extrémité distale de l'implant, faire une incision longitudinale de 2 mm vers le coude
ETAPE 4	
	• Poussez doucement l'implant vers l'incision jusqu'à ce que la pointe devienne visible • Saisir l'implant avec une pince et le retirer • Appliquez une compresse stérile avec un bandage compressif pour minimiser les ecchymoses. La femme peut retirer le bandage compressif après 24 heures et le petit pansement au bout de 3-5 jours

IV. EFFETS SECONDAIRES DES CHP ET LEUR PRISE ENCHARGE

4.1. Effets secondaires des CHP

ETAT /CARACTERISTIQUE	COP	CIP	IMPLANT SOUS CUTANEE
Spotting	X	X	X
Aménorrhée	X	X	X
Forte hémorragie		X	
Métrorragies		X	X
Saignements irréguliers			X
Seins sensibles	X		X
Maux de tête	X	X	X
Etourdissements		X	X
Prise de poids : plus de 2 kg par mois		X	X
Douleur abdominale violente		X	X
Sauts d'humeur		X	X
Diminution de la libido		X	
Acnés			X
Nausées			X

4.2. Prise en charge des effets secondaires des CHP

N°	SITUATION CLINIQUE	PRISE EN CHARGE
1	Spotting ou de saignements légers	Exclure toutes les autres causes sous-jacentes de saignements gynécologiques comme la présence de polypes, de cervicite, de cancer du col utérin.
		Administrer soit : - Un contraceptif non hormonal OU 800 mg d'ibuprofène trois fois par jour pendant 5 jours OU 500 mg d'acide méfénamique trois fois par jour OU - Un contraceptif hormonal (s'il est acceptable sur le plan médical) : des contraceptifs oraux combinés (COC) (contenant de préférence de 30–35 µg d'éthinylestradiol), un comprimé par jour pendant 21 jours (à noter qu'elle est susceptible d'avoir ses règles après la fin du cycle de 21 jours de COC).
		Rassurer la cliente que les saignements ne sont pas dangereux et qu'il est inutile de retirer l'implant à ce stade
2	Saignements importants ou Prolongés	AINS (Acide méfénamique, VALDECOXIB)
		Médicaments hormonaux (Ethinyl estradiol)

VI. INSTRUCTIONS ET ELEMENTS DE SUIVI

5.1. Instructions et éléments de suivi pour l'utilisation COP

5.1.1. Instructions pour l'utilisation des COP

- Prendre une pilule chaque jour à la même heure.
- Prendre la première pilule le premier jour de la menstruation de préférence. Si la cliente commence le COP après le premier jour de ses menstrues mais après le cinquième jour, elle doit utiliser une méthode d'appoint (condom) pendant les prochaines 48heures.
- Prendre toutes les pilules de la plaquette. Commencer une nouvelle plaquette le lendemain de la prise de la dernière pilule de l'ancienne plaquette. Respecter l'ordre en suivant le sens de la flèche.
- En cas de vomissement dans les 2 heures suivant la prise de la pilule, en prendre une autre ou utilisez une méthode d'appoint si la cliente a des rapports sexuels pendant les 48 prochaines heures.
- En cas de vomissements sévères ou diarrhée pendant plus de 24 heures:
 - La femme devra continuer à prendre les pilules (si elle le peut) malgré l'inconfort.
 - Si les vomissements sévères ou la diarrhée se poursuivent pendant 2 jours au plus, elle devra suivre les procédures applicables en cas d'oubli de pilule
- En cas d'oubli de la pilule avec plus de 3 heures de retard, la prendre dès qu'elle s'en rappelle. Utiliser une méthode d'appoint si elle a des rapports sexuels dans les prochaines 48Heures.
- Si la cliente a une aménorrhée de 2 mois ou plus, elle doit revenir à la clinique pour voir si elle est enceinte.
- Ne pas arrêter pas de prendre la pilule à moins que la cliente sache qu'elle est enceinte.

5.1.2. Eléments de suivi COP

Toujours rechercher :

- ◆ Comment la prise s'effectue
- ◆ S'il y a des effets secondaires et savoir comment ils sont acceptés.
- ◆ Réexpliquer les risques de spotting et / ou d'aménorrhée et / ou de règles irrégulières
- ◆ Peser la cliente
- ◆ Prendre sa TA

5.2. Instructions et éléments de suivi pour l'utilisatrice de CIP

5.2.1. Instructions pour l'utilisatrice de CIP

- La cliente doit revenir à la clinique pour l'injection suivante.
- Si DEPO PROVERA, toutes les 12 semaines et si NORISTERAT toutes les 8 semaines, si CIC tous les mois
- Indiquer à la cliente la date exacte de la prochaine injection (noter la date sur la carte de rendez vous)
- Un retard ou une avance de 8 à 12 jours pour la prochaine injection peut être toléré
- Pour le DMPA, cela peut aller jusqu'à 2 à 4 semaines. Si le retard est supérieur à 2 semaines, utiliser des préservatifs ou un spermicide, ou éviter les rapports sexuels jusqu'à la prochaine injection.
- Informer la cliente de l'apparition éventuelle de certains effets secondaires qui ne sont pas graves et qui peuvent disparaître graduellement.
- Rassurer la cliente que l'aménorrhée qui se présente dans le cas du DMPA n'est pas grave et ne nécessite pas de traitement
- Expliquer que le retard du retour à la fécondité est temporaire (4 à 7 mois au plus) après la dernière injection et ne provoque pas une baisse de fertilité à long terme.
- Utiliser des condoms avec les injectables si l'un des partenaires est à risque
- Contacter immédiatement le centre de PF devant les signes d'alarme suivants:
 - aménorrhée après plusieurs cycles réguliers (suspicion de grossesse)
 - douleurs vives au bas ventre(GEU)
 - saignements abondants ou prolongés (supérieurs à 8 jours)
 - migraines , céphalées très prononcées et fréquentes avec troubles visuels
 - tuméfaction ou douleur au niveau du point d'injection
 - yeux anormalement jaunes.

5.2.2. Eléments de suivi des CIP

NORISTERAT :

Toutes les 8 semaines avec contrôle des constantes (TA, poids, état général).

Une fois par an, faire un examen général et clinique de la cliente.

DEPO-PROVERA / SAYANA PRESS :

Toutes les 12 semaines.

5.3. Instructions et éléments de suivi pour les clients sous implant

5.3.1. Instructions pour les clients sous implant

- ◆ Si la cliente se présente dans les 7 jours qui suivent le début de ses règles, pas besoin d'une méthode d'appoint.
- ◆ Si la cliente se trouve à plus de 7 jours après le début des règles, l'implant peut être inséré à n'importe quel moment, si la cliente n'est pas enceinte. Elle devra alors s'abstenir de relations sexuelles ou utiliser une protection contraceptive d'appoint pendant les 7 premiers jours après l'injection.
- ◆ La cliente doit garder l'endroit de l'insertion bien sec pendant 3 à 4 jours
- ◆ Une fois que l'effet de l'anesthésie cesse, le bras de la cliente peut lui faire mal pendant quelques jours. L'endroit peut également être tuméfié. C'est courant et cela disparaîtra sans traitement.
- ◆ Donner à la cliente des informations par écrit sur la carte de rappel:
 - le type d'implant
 - la date de l'insertion
 - le site d'insertion (le bras)
 - le mois et l'année où les implants doivent être retirés ou remplacés
 - l'endroit où elle peut se rendre si elle a des problèmes ou des questions à propos des implants
- La cliente peut reprendre immédiatement le travail
- La cliente doit revenir voir un prestataire pour le retrait de l'implant, si elle le souhaite ou pour le remplacer.

5.3.2. Calendrier de suivi implant

Le 1er contrôle sera fait une semaine après l'insertion pour vérifier la cicatrice.

Le 2^{ème} contrôle sera fait 3 mois après l'insertion et ensuite tous les 6 mois.

- Veillez à ce que l'endroit soit propre et sec pendant 48 heures
- Laissez le bandage serré avec la gaze en place pendant 48 heures et laissez le sparadrap en place jusqu'à ce que l'incision soit guérie (3 à 5 jours environ)
- L'endroit de l'incision sera contusionné, tuméfié ou sensible pendant quelques jours, c'est normal.
- En cas de signe d'infection (fièvre, rougeur) se présenter à la clinique)
- L'utilisatrice doit revenir au centre une semaine après l'insertion, puis 3 mois après, ensuite 1 fois tous les ans sauf en cas de problème.

RECAPITULATIF

1. Décrire les différents types de CHP
2. Appliquer les critères médicaux d'éligibilités
3. Décrire les différentes étapes de l'insertion et du retrait des capsules d'implant
4. Enumérer les éléments de suivi des utilisatrices des CHP
5. Décrire la conduite à tenir face aux effets secondaires et complications des CHP.

DISPOSITIF INTRA UTERINS (DIU)

PREREQUIS :

Avant d'assister à ce cours, l'étudiante doit avoir lu et/ou assimilé le contenu des chapitres suivants :

- Dispositifs intra-utérins
- Critères d'éligibilité définis par l'OMS
- Consultation d'une cliente en PF
- Counseling
- Contraceptifs hormonaux progestatifs (cf Support pédagogique de PF/GL2019)

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître les conditions de prescription du Dispositif Intra-Utérin.

ENONCES DE RESULTATS

1. Décrire le D.I.U selon le cours.
2. Identifier les clientes répondant aux critères de recevabilité pour le D.I.U.
3. Expliquer correctement les procédures d'utilisation du DIU
4. Décrire la C.A.T devant chaque effet secondaire et complication.

I- DESCRIPTION DU DISPOSITIF INTRA-UTERIN.

1.1. Définition

Le DIU ou stérilet est une petite armature flexible qui existe sous plusieurs formes, que l'on insère dans la cavité utérine de la femme afin d'éviter la survenue d'une grossesse.

1.2 Types de DIU :

	DIU au cuivre	DIU hormonal
PRESENTATION		
NOMS COMMERCIAUX	- TCU 380 A** (12 ans) - TCU 200 - PREGNA - MONALISA	-PROGESTASERT (Progestérone) -LEVONOVA (Levonorgestrel) - MIRENA* (Levonorgestrel) 5 ans
FORME	Tube en plastique en forme de T de trois cm	Tube en plastique en forme de T de trois cm
ACTION	Mécanique	Mécanique et hormonale
	Fil de cuivre	Réservoir de LEVONORGESTREL
DUREE D'ACTION	12 ans	5 ans
MODE D'ACTION	*Altère les spermatozoïdes *Inactive et diminue le nombre de spermatozoïde *Modifie l'endomètre	*Epaissit la glaire cervicale *Inhibition de l'ovulation *Modifie l'endomètre
ADMINISTRATION	Cavité utérine	Cavité utérine
EFFICACITE	99,7%	99,8%
ACTION CONTRACEPTIVE LOCALE	OUI	OUI
PEUT-ETRE UTILISE COMME CONTRACEPTION D'URGENCE ?	OUI	NON
PEUT ETRE UTILISE PAR DES FEMMES QUI ALLAIENT ?	OUI	OUI, mais pas dans les six premières semaines qui suivent l'accouchement
PRESTATAIRE QUALIFIE	OUI	OUI

1.3. Avantages

Etat : caractéristiques	DIU au cuivre	DIU hormonal
Avantages contraceptifs		
Efficace immédiatement	X	X
Discret	X	X
Longue durée d'action	X	X
Réversible immédiatement	X	X
Avantages non contraceptifs		
N'affecte pas l'allaitement	X	X
Peut être fourni par un personnel non médical mais formé	X	X
N'interfère pas avec les rapports sexuels	X	X
Protègent contre la grossesse ectopique	X	X
Peuvent augmenter le plaisir sexuel	X	X
Peu cher	X	X
Peut être inséré immédiatement après accouchement	X	
Aucun effet secondaire hormonal	X	
Aucune interaction médicamenteuse	X	
Peuvent protéger contre le cancer de l'endomètre	X	
Réduisent les flux menstruels et les crampes		X
Réduisent les symptômes de l'endométriose		X
Protègent contre l'anémie		X
Peuvent protéger contre les MIP.		X

1.4. Limites

- Examen gynécologique nécessaire avant insertion
- Dépistage des ITG recommandé avant l'insertion
- Vérifier la présence des fils après chaque menstruation
- L'insertion et le retrait demande un personnel formé
- Peut être expulsé ou déplacer spontanément
- Respecter la PI pendant la pose et le retrait
- Saignement et crampes plus prononcés les premiers mois
- Peut aggraver les MIP et l'infertilité chez des femmes exposés aux ITG et aux autres IST.

II. CRITERES DE RECEVABILITE

CATEGORIE	CONDITIONS
Catégorie 1	Post partum - < 48 heures y compris pose immédiate après l'expulsion du placenta - ≥ 4 semaines Fibrome utérin - Néoplasie cervicale - Cancer du sein (DIU au cuivre) - Tumeur hépatique (DIU au cuivre) - Hépatite aiguë - Thrombose veineuse (DIU au cuivre) - HTA légère, Cardiopathie ischémique, AVC (DIU au cuivre) - Diabète, tabagisme.
Catégorie 2	Nullipare – Adolescentes - Thrombose veineuse (DIU LNG) - IST/VIH - femme séropositive si elle n'a aucun symptôme de SIDA. - femme qui développe un SIDA alors qu'elle utilise déjà un DIU - femme atteinte du SIDA qui répond bien à un traitement ARV.
Catégorie 3	- Entre 48 heures et 4 semaines –Chorioamniotite - Rupture prolongée des membranes >18heures - Tumeur hépatique (DIU LNG) – Thrombopénie grave - Maladie Trophoblastique gestationnelle - SIDA - Cancer de l'ovaire.
Catégorie 4	- Infection puerpérale - Avortement septique - Hémorragie du post partum non maîtrisée - Saignements vaginaux inexpliqués - Fibrome utérin avec déformation de la cavité utérine - Maladie inflammatoire pelvienne(MIP) - Cancer du col, de l'endomètre - du sein (DIU-LNG) - Gonorrhée/chlamydia

UTILISER LE DIU AVEC PRECAUTION DANS LES SITUATIONS SUIVANTES

CONDITIONS	RECOMMANDATIONS
Menstruations douloureuses	• Informer la cliente de la possibilité de pertes de sang plus abondantes et de crampes menstruelles accrues provoquées par le DIU (Seulement pendant les premiers cycles pour les DIU libérant du cuivre)
Valvulopathie symptomatique	• Donner une prophylaxie à base d'antibiotique au moment de la première insertion
Anémie (hémoglobine < 9g/100 ml)	• Choisir le DIU seulement si c'est la meilleure méthode pour la cliente. Donner un traitement pour l'anémie et faire un suivi

III. EFFETS SECONDAIRES ET COMPLICATIONS

Effets secondaires	Complications
• Saignements mensuels prolongés • Aménorrhée • Crampes pelviennes dans les jours qui suivent la pose • Augmentation du flux menstruel • Métrorragie • Infection pelvienne (pertes vaginales) • Fil manquant.	• Perforation pendant la pose (arrêter la manœuvre) • Migration du DIU (Cas de fils perdus) • Ancrage • Risque de GEU, fausse couche, accouchement prématuré ou d'infection en cas de grossesse • Infections pelviennes graves. • Rapport sexuel douloureux.

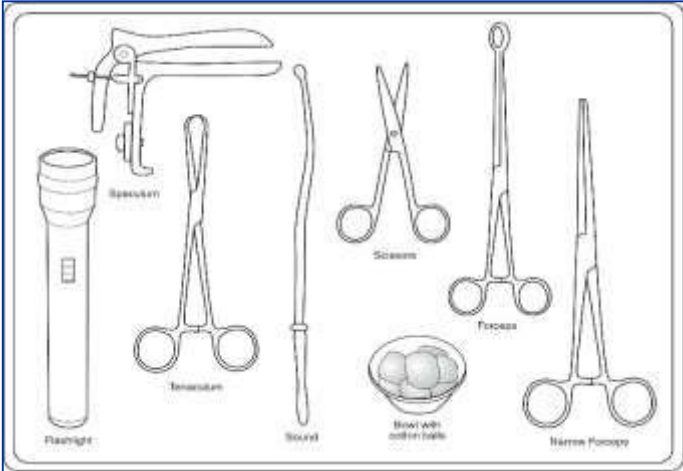
IV. PROCEDURES D'UTILISATION

4.1. Moment d'insertion

Toutes les femmes

- **Si la cliente a ses menstrues (absence de grossesse) :** Après les règles jusqu'au 21^{ème} jour du cycle menstruel
- **Si absence de rapport sexuel,** on peut le placer à n'importe quel moment
- **Dans le post partum voir chapitre DIUPP**
- **Insertion post abortum voir chapitre DIUPA**

4.2. MATERIEL D'INSERTION DUDIU

OMS 06 SEPTEMBRE2012		N°	INSTRUMENTS ET MATERIELS
		1	Surface plate pour poser les instruments
		2	DIU + Inserteur dans son emballage stérile non ouvert et non endommagé
		3	Spéculum bivalve stérile
		4	Pince à pansement stérile
		5	Pince de Pozzi ou tenaculum stérile
		6	Ciseaux tranchant stérile
		7	Hystéromètre ou sonde utérine
		8	Tampon de coton stérile
		9	Gants stériles
		10	Source de lumière
		11	Bol avec solution antiseptique
		12	Pince circulaire
		13	Solution chlorée à 0,5%
		14	Drap ou linge pour la table et la région pelvienne.

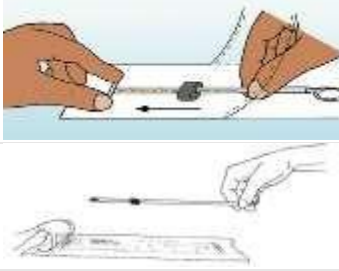
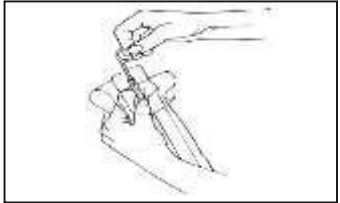
4.3. TECHNIQUE

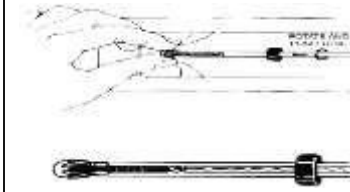
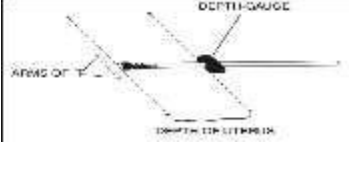
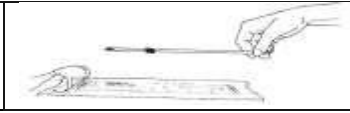
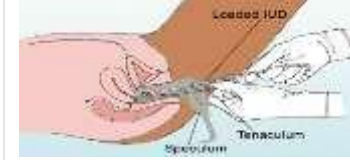
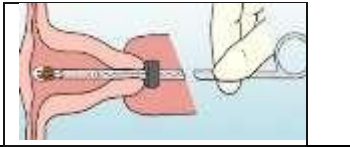
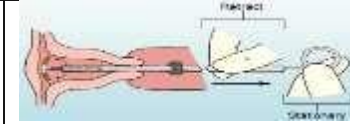
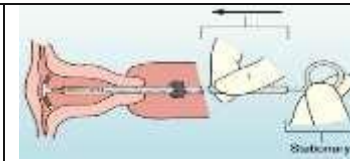
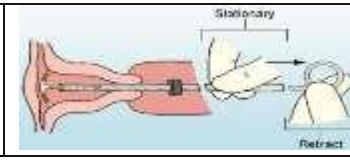
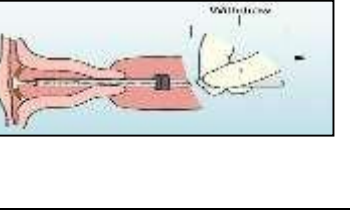
➤ PREVENTION DE L'INFECTION DURANT LA POSE

- ◆ Se laver les mains avant et après la procédure et porter des gants d'examen
- ◆ Utiliser des instruments de qualité et désinfectés
- ◆ Charger le DIU dans son emballage stérile sans toucher le DIU
- ◆ Laver le col de l'utérus avec un antiseptique
- ◆ Insérer le DIU sans toucher les valves du spéculum ou la paroi vaginale
- ◆ Ne faire passer l'hystéromètre et le DIU chargé qu'une seule fois à travers le canal cervical
- ◆ Décontaminer les instruments après la procédure
- ◆ Jeter les déchets contaminés de façon adéquate.

➤ ETAPES D'UNE INSERTIONDOUCE

1. Effectuer un examen bimanuel ainsi qu'un examen pelvien au spéculum pour:
 - vérifier l'absence de contre-indications;
 - déterminer la position de l'utérus.
2. Sonder l'utérus pour en déterminer la profondeur.
3. Charger le DIU dans l'applicateur sans le sortir de son emballage stérile.
4. Ajuster la butée cervicale en fonction de la profondeur de l'utérus.
5. Placer le DIU dans l'utérus.
6. Permettre à la femme de se reposer.

ETAPE 1	Effectuez un examen pelvien (examen bimanuel, puis examen au spéculum) Vérifiez l'absence de contre-indications : - Aucun signe ou symptôme d'infection : procédez à l'insertion - Infection soupçonnée : n'insérez pas le DIU ; diagnostiquez et traitez comme il se doit, puis réévaluez pour l'insertion - Évaluez la position de l'utérus (antéversion ou rétroversion) afin de déterminer la bonne orientation de la sonde.
ETAPE 2	Sonder l'utérus - Lavez le col de l'utérus avec une solution antiseptique. - Appliquez le tenaculum sur le col de l'utérus. - Tirez doucement sur le tenaculum pour aligner l'utérus, l'orifice du col et le canal vaginal. - Insérez la sonde utérine dans le vagin et à travers l'orifice du col. - Avancez la sonde dans la cavité utérine jusqu'à ressentir une légère résistance. - Retirez doucement la sonde et observez le niveau de mucus ou de sang pour déterminer la profondeur de l'utérus (en moyenne, 6 à 8cm).
ETAPE3	Charger le DIU au cuivre (TCU 380A)  - Chargez le DIU en repliant les bras latéraux et en les plaçant dans le tube applicateur. - Ne chargez pas le DIU plus de cinq minutes avant de l'insérer dans l'utérus. - Si les bras du DIU restent pliés pendant plus de cinq minutes, ils peuvent ne pas reprendre leur position initiale lorsque le dispositif est relâché.
ETAPE 3.1	Charger le T au cuivre  - Ajustez le contenu de l'emballage à travers l'emballage en plastique transparent. - Vérifiez que la tige verticale du T se trouve entièrement dans le tube applicateur. - Vérifiez que l'autre extrémité du tube applicateur est proche de la partie scellée de l'emballage.
ETAPE 3.2	Ouvrez partiellement l'emballage : - Placez l'emballage sur une surface dure et propre, la partie en plastique transparent vers le haut. - Ouvrez l'emballage en plastique en le tirant du côté opposé au DIU. - Continuez à tirer sur l'emballage jusqu'à ce qu'il soit à moitié ouvert, jusqu'à la butée cervicale bleue.
ETAPE 3.3	Placez le piston blanc dans le tube applicateur transparent :  - Prenez l'emballage et tenez-le avec l'ouverture dirigée vers le haut. - Pliez les deux parties de l'emballage (la partie transparente et la partie blanche) à l'opposé l'une de l'autre. - Saisissez le piston blanc par la partie circulaire et placez-le dans le tube applicateur. Poussez doucement le piston jusqu'à ce que son extrémité touche presque la queue du T.
ETAPE 3.4	Repliez les bras latéraux du T :  - Lâchez la partie blanche de l'emballage et posez ce dernier sur une surface dure et propre, partie transparente vers le haut. - Placez le pouce et l'index au niveau de l'extrémité des bras latéraux du T. - Poussez l'insert de mesure afin qu'il glisse sous le DIU. • Saisissez le tube applicateur et poussez-le contre le T ; les bras latéraux vont commencer à se replier. • Rapprochez le pouce et l'index.
ETAPE 3.5	Tirez sur le tube applicateur pour qu'il s'éloigne des bras repliés du T : - Lorsque les bras du T sont suffisamment pliés pour toucher les parois du tube applicateur, tirez sur le tube applicateur pour que son ouverture se trouve juste au-dessous des bras repliés.

ETAPE 3.6 	Poussez les bras latéraux pliés du T dans le tube applicateur : - Poussez doucement le tube applicateur et tournez-le pour qu'il recouvre l'extrémité des bras repliés du T, afin que les deux extrémités se trouvent à l'intérieur du tube. - N'essayez pas d'insérer dans le tube applicateur les bandes de cuivre des bras latéraux, car ils ne rentreront pas dans le tube.
ETAPE 3.7 Ajustez la butée cervicale bleue en fonction de la profondeur utérine mesurée par la sonde : - Déplacez la butée cervicale afin que son extrémité supérieure s'aligne avec la marque sur l'insert de mesure. - Appuyez sur la butée cervicale tout en faisant glisser le tube applicateur jusqu'à ce que l'extrémité du DIU soit alignée avec l'extrémité figurant sur le diagramme de l'insert de mesure. - Vérifiez que la distance entre l'extrémité du DIU et le bord inférieur de la butée cervicale est égale à la profondeur de l'utérus.	
ETAPE 3.8 	Alignez la butée cervicale et les bras repliés du T afin qu'ils soient dans le même plan horizontal.
ETAPE 3.9 	Retirez le DIU chargé de l'emballage en le gardant à l'horizontale.
ETAPE 4 	Insérer le DIU dans le vagin - Saisissez doucement le tenaculum (toujours en place depuis le sondage de l'utérus) et tirez légèrement dessus. - Insérez le DIU chargé sans toucher aux parois vaginales ou aux lames du spéculum.
ETAPE 5 	Avancer le DIU dans l'utérus - Avancez doucement le DIU chargé dans la cavité utérine. - Arrêtez-vous lorsque la butée cervicale rentre en contact avec l'utérus ou lorsque vous sentez une légère résistance.
ETAPE 6 	Libérer les bras du T au cuivre - Maintenez le tenaculum et le piston blanc en place tout en retirant partiellement le tube applicateur. - Cela libère les bras latéraux du T au cuivre.
ETAPE 7 	Pousser doucement le tube applicateur - Poussez doucement le tube applicateur jusqu'à ressentir une légère résistance. - Cette étape garantit un placement en profondeur dans l'utérus.
ETAPE 8 	Retirer le piston - Retirez le piston blanc tout en maintenant le tube applicateur en place.
ETAPE 9 	Retirer partiellement le tube applicateur - Retirez doucement et lentement le tube applicateur du canal cervical jusqu'à voir les fils sortir de l'orifice du col de l'utérus

ETAPE 10 	Couper les fils du DIU - Coupez les fils à 3-4 cm de l'orifice du col à l'aide de ciseaux Mayo tranchants - Si les ciseaux sont émoussés, les fils du DIU pourraient se coincer dans leurs lames - Retirez complètement le tube applicateur contenant la partie coupée des fils.
ETAPE 11 	Retirer le tenaculum (pince de POZZI) - Retirez doucement le tenaculum. - Observez le col de l'utérus à la recherche d'un saignement. - En cas de saignement, tenez un tampon sur le site à l'aide de forceps propres.
ETAPE 12 	Retirer le spéculum et décontaminer les instruments - Retirez doucement le spéculum. - Placez le tenaculum et le spéculum dans une solution de chlore à 0,5 % pendant 10 minutes, pour les décontaminer.
ETAPE 13 	Laisser la femme se reposer - Permettez à la femme de se reposer. - Démarrez les tâches à effectuer après la pose. - Donnez les instructions finales et autres messages clés.

Source OMS 06 septembre 2012

➤ PROCEDURE DE RETRAIT DUDIU

N°	PROCEDURE
1	Suivez les directives pour la prévention des infections
2	Précisez à la cliente que des crampes ou des saignements peuvent survenir.
3	Effectuez un examen bimanuel.
4	Insérez le spéculum vaginal et observez la longueur et la position des fils
5	Exercez une traction douce et lente pour ne pas casser les fils.
6	Badigeonnez le vagin et le col de l'utérus avec un antiseptique.
7	Saisissez les fils près du col de l'utérus et tirez doucement mais fermement pour retirer le DIU.
8	Jetez les déchets selon les directives.
9	Adressez la cliente à un spécialiste pour les retraits complexes.
10	Insérez un nouveau DIU immédiatement après le retrait (si désiré).

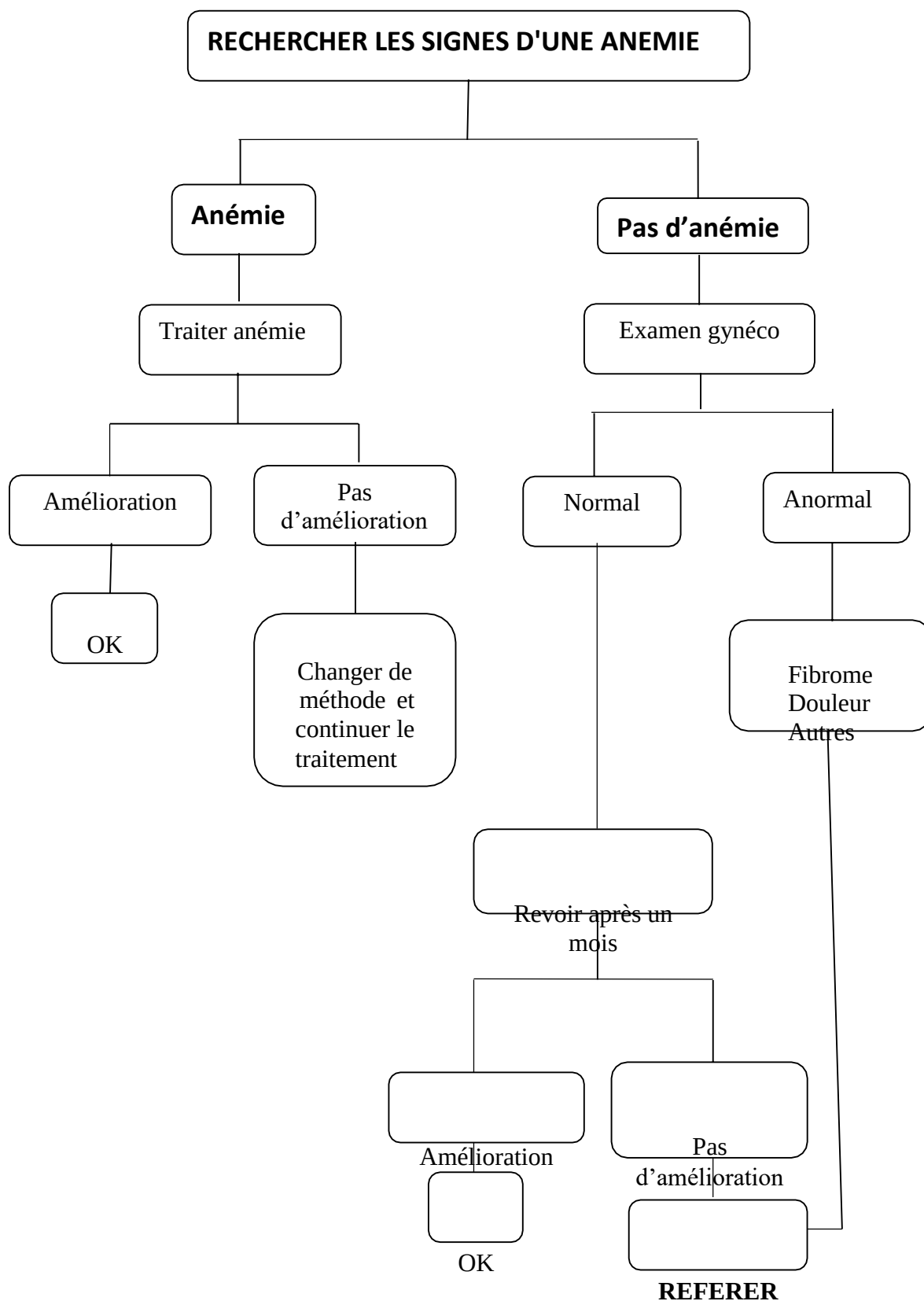
CREATION D'UN DOCUMENT DE TP /TD

4.4. SIGNESAVERTISSEURS

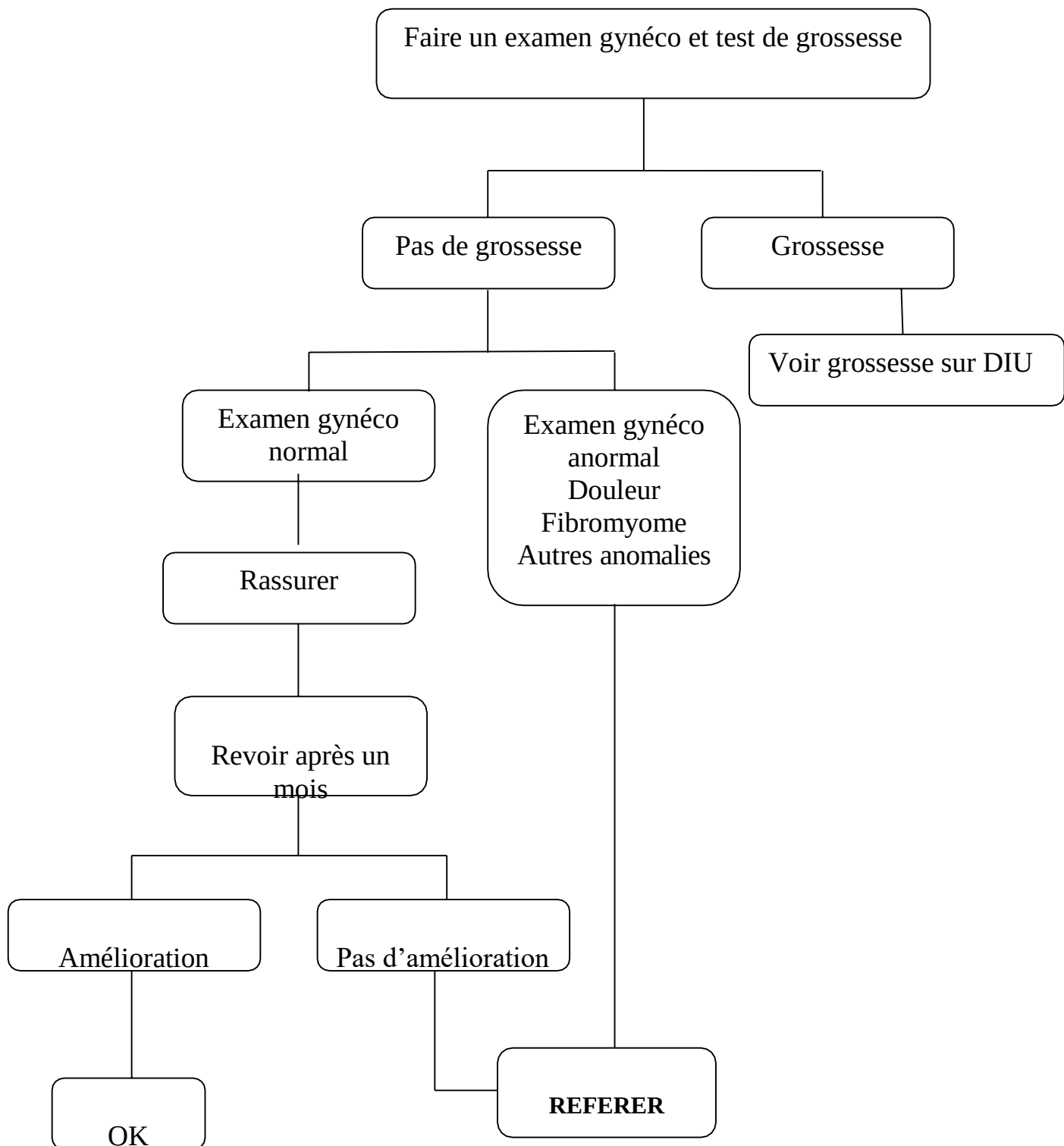
L'utilisatrice du DIU doit immédiatement contacter le service de PF si elle note un des signes suivants :

- Retard dans la menstruation avec symptômes de grossesse (nausée, seins sensibles, etc.)
- Crampes ou douleurs persistantes au bas ventre surtout avec fièvre ou frissons (ces symptômes suggèrent un risque d'infection pelvienne)
- Fils manquants ou lorsqu'on touche le bout en plastique du DIU lors de la vérification
- Si vous ou votre partenaire commencez à avoir des relations sexuelles avec plus d'un partenaire les risques d'infection sont élevés.

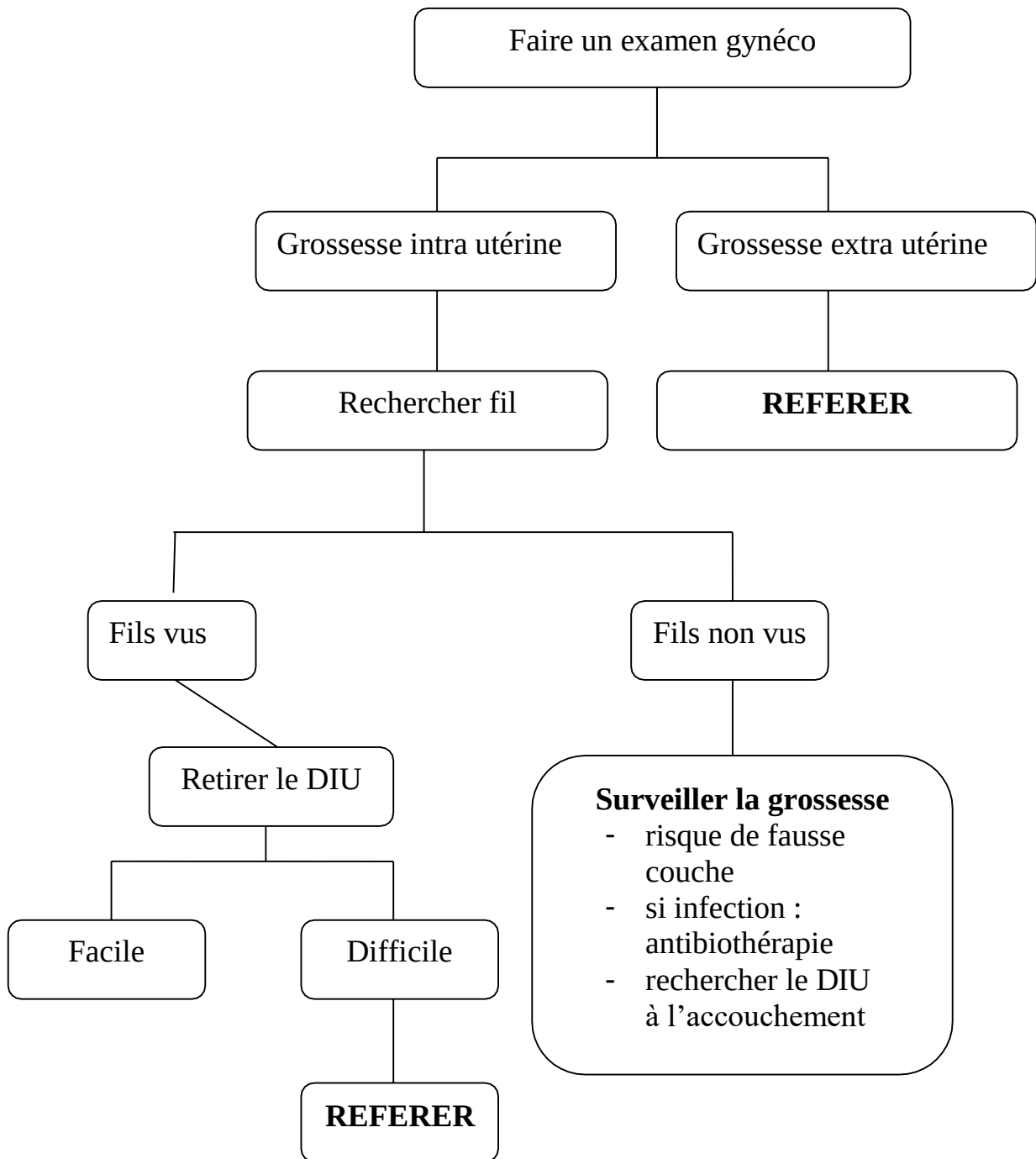
CONDUITE A TENIR DEVANT DIU ET DES MENORRAGIES (règles trop abondantes)



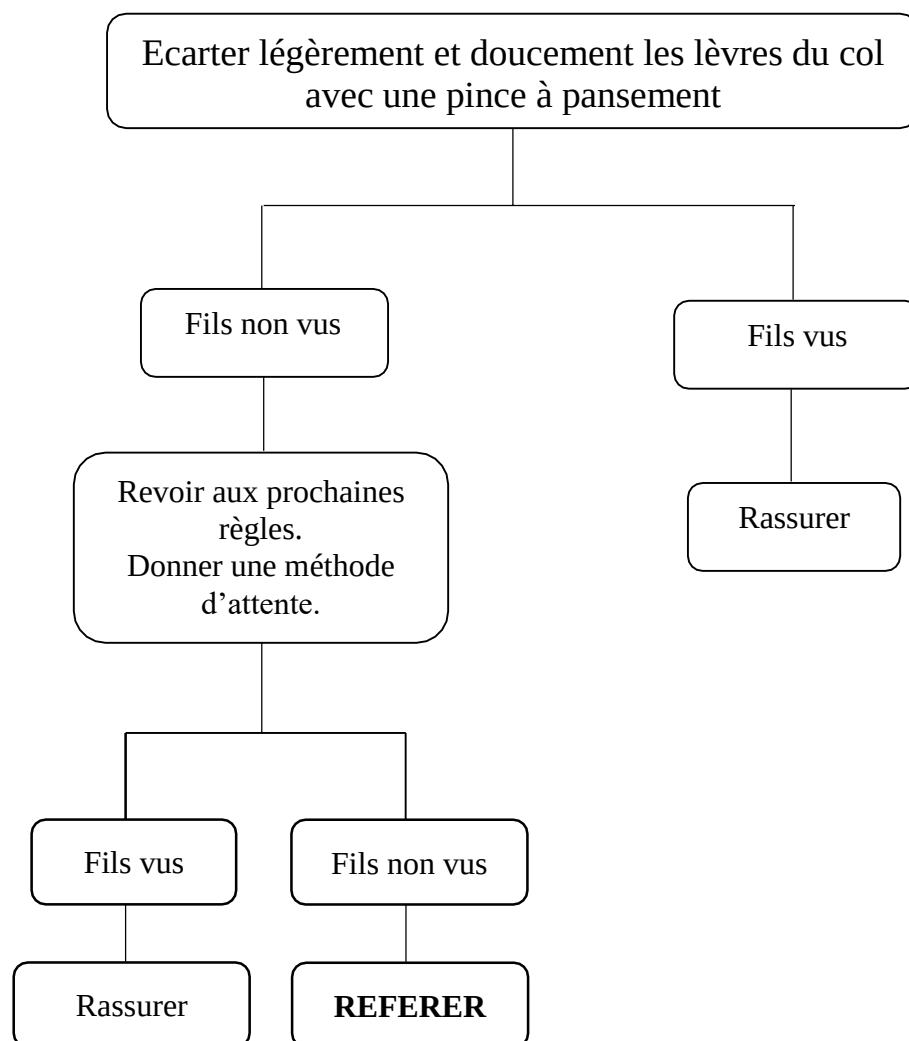
CONDUITE A TENIR DEVANT DIU ET DES METRORRAGIES (Perte de sang

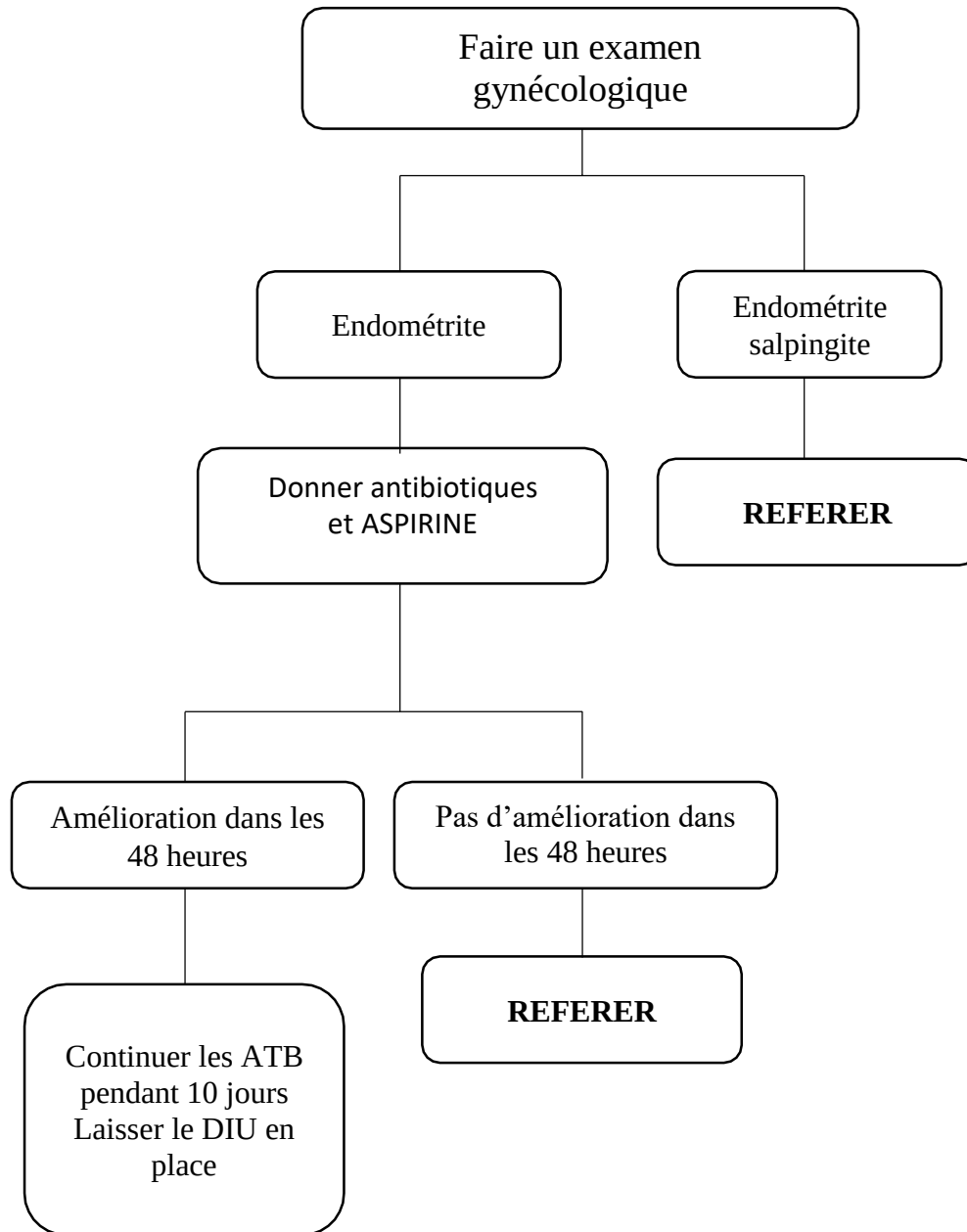


CONDUITE A TENIR DEVANT GROSSESSE SURDIU

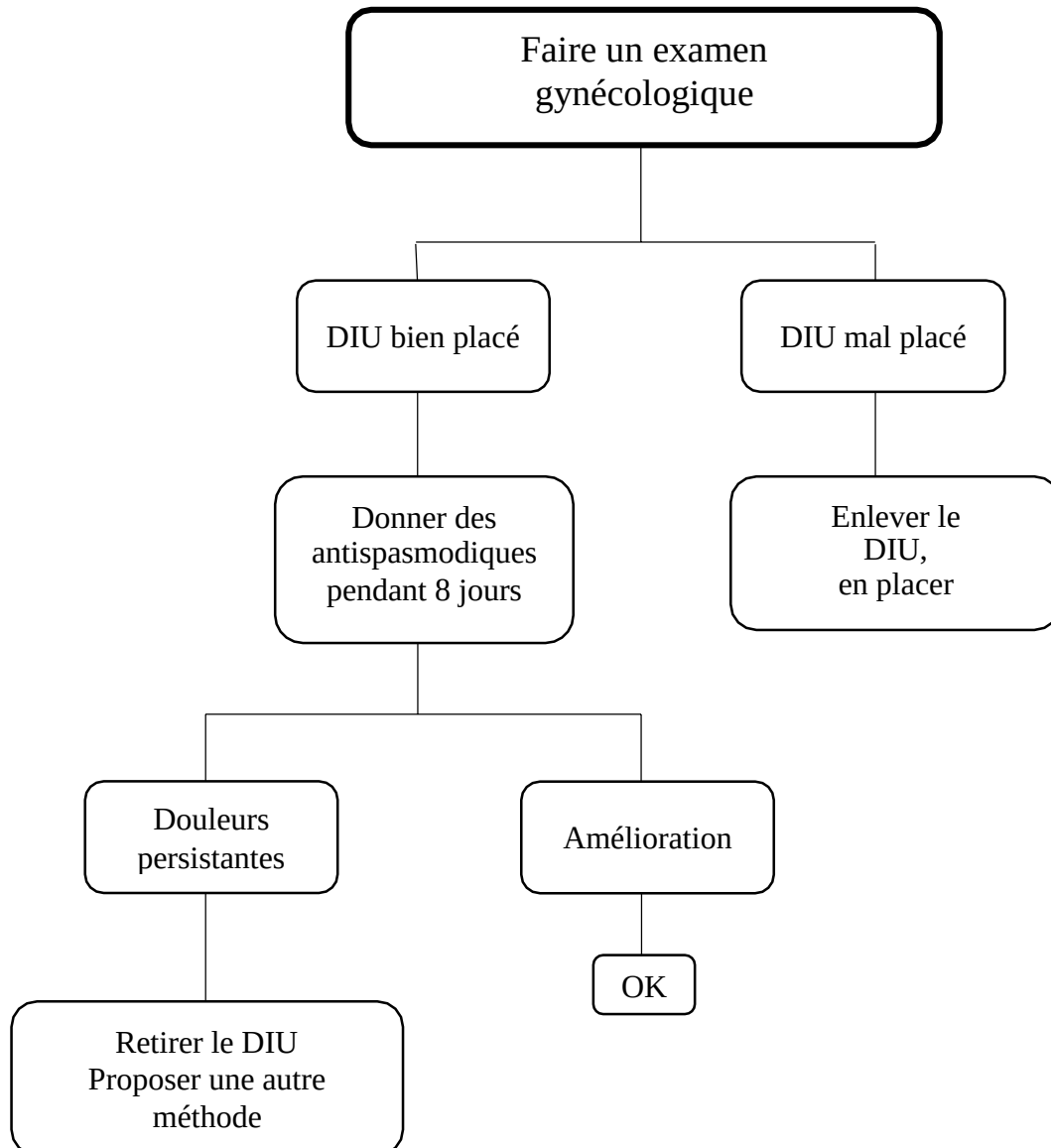


CONDUITE A TENIR DEVANT DIU ET FILS NON VUS





CONDUITE A TENIR DEVANT DOULEURS ET DIU



DISPOSITIF INTRA-UTERIN DU POST-PARTUM

PREREQUIS :

L'étudiante doit avoir préalablement pris connaissance et/ou assimilé :

- Anatomie et la physiologie de l'appareil génital féminin et masculin,
- Counseling (cf Support pédagogique de PF/GL2019)
- DIU
- DIUPP

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître les éléments de prescription du DIUPP

ENONCES DE RESULTATS

1. Décrire correctement le DIUPP
2. Décrire l'importance de la contraception dans le post partum
3. Expliquer les avantages et les limites du DIUPP
4. Enumérer les instructions à donner aux couples accepteurs de la C.C.V.
5. Enoncer les éléments du suivi en cas de CCV

Introduction

Depuis plus de 30 ans, les femmes utilisent le dispositif intra-utérin (DIU) dans le monde entier comme leur principale méthode de contraception. Il est, en fait, la méthode réversible la plus communément utilisée chez les femmes mariées en âge de procréer dans le monde entier. Des résultats d'études récentes confirment que le DIU est une méthode de contraception sûre et extrêmement efficace dont l'utilisation est appropriée pour la plupart des femmes en période post partum.

1. Mécanisme d'action

Le mécanisme d'action est le même aussi bien pendant la période post partum que la période d'intervalle.

2. Avantages et Limites de l'insertion du DIUPP

Avantages	Inconvénients
- Sécurité - Accès aux services - Coût - Efficacité - Moment et efficacité du service :	- ne protège pas contre les IST y compris le VIH. - modifie les menstrues - Après l'insertion les fils ne peuvent être visibles immédiatement - Des saignotements - Des crampes menstruelles

NB : Ces différents effets secondaires ne sont pas d'habitude dangereux pour la femme et s'estompent souvent un à trois mois après l'insertion du DIU. Les femmes devraient être informées de ces effets secondaires avant l'insertion du DIU. Des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent amoindrir les symptômes et un bon counseling peut permettre d'encourager la poursuite de la méthode.

3. Moment d'insertion du DIU dans le PP

Un DIU peut être inséré en toute sécurité immédiatement après l'accouchement (48 premières heures) ou pendant un accouchement par césarienne. Il n'est pas recommandé d'insérer le DIU au cours de la période située entre 48 heures et quatre semaines du post partum en raison d'un risque accru de complications ('infection , expulsion, perforation).

Les différents moments sont :

- **post placentaire** : C'est l'insertion dans les 10 minutes qui suivent l'expulsion du placenta après un accouchement par voie basse
- **per césarienne** : C'est l'insertion réalisée au cours d'un accouchement par césarienne, après le retrait du placenta et avant la fermeture de l'incision utérine
- **post partum immédiate** : C'est l'insertion réalisée après la période post placentaire, mais dans les 48 heures après l'accouchement
- **intervalle** : C'est l'insertion du DIU entre 4 semaines et un an après l'accouchement.

4. Pratiques de prévention des infections et le DIUPP

Tableau 6.1. Etapes du traitement des instruments et d'autres objets utilisés dans les services de DIUPP

Instruments/ objet	Décontamination	Nettoyage	Désinfection de haut niveau	Stérilisation
	Est la première étape de manipulation d'instruments souillés ; réduit le risque de transmission du VHB et du VIH	Élimine tout le sang, tous les liquides corporels visibles et la poussière.	Méthode de traitement final recommandée ; détruit tous les virus, les bactéries, les parasites, les champignons et certains endospores.	Méthode alternative de traitement final ; détruit tous les microorganismes, y compris les endospores.
La partie supérieure de la table d'examen et d'autres grandes surfaces	Essuyez en utilisant une solution de chlore de 0,5%.	Lavez avec du savon et de l'eau s'il reste des matières organiques après la décontamination.	Pas nécessaire.	Pas nécessaire.
Les instruments utilisés pour l'insertion ou le retrait du DIU (ex. le spéculum, le forceps placentaire/ ring forceps, écarteur/ spéculum)	Plongez dans une solution de chlore de 0,5% pendant 10 minutes avant de nettoyer. Rincez ou lavez immédiatement.	A l'aide d'une brosse, lavez avec du savon et de l'eau. Rincez avec de l'eau propre. S'ils seront stérilisés, séchez à l'air ou essuyez-les à sec et emballez.	Passer à la vapeur ou faites bouillir pendant 20 minutes. Désinfection chimique de haut niveau par immersion pendant 20 minutes (solution chlorée à 0,1 %). Rincez bien avec de l'eau bouillie et laissez sécher à l'air avant d'utiliser ou de conserver.	Chauffer à sec pendant une heure après avoir atteint 170 °C (340 °F), ou utilisez un autoclave à 121 °C (250 °F) et 106 kPa (15 lbs/ in2) pendant 20 minutes (30 minutes si les instruments sont emballés).
Récipients de conservation des instruments	Plongez dans une solution de chlore de 0,5% pendant 10 minutes avant de nettoyer. Rincez ou lavez immédiatement.	Lavez avec du savon et de l'eau. Rincez avec de l'eau propre, séchez à l'air ou essuyez à sec.	Faites bouillir le récipient et recouvrez pendant 20 minutes. Si le récipient est trop grand : Remplissez-le d'une solution de chlore à 0,1% et plongez-le pendant 20 minutes. Rincez avec de l'eau qui a été bouillie pendant 20 minutes et laissez sécher à l'air avant d'utiliser.	Chauffer à sec pendant une heure après avoir atteint 170 °C (340 °F), ou utilisez un autoclave à 121 °C (250 °F) et 106 kPa (15 lbs/ in2) pendant 20 minutes (30 minutes si les instruments sont emballés).

5. Technique de pose du DIU PP

a. Première confirmation/préparation de l'utilisatrice potentielle du DIUPP^{[1][SEP]}

Avant que la femme ne reçoive un DIU, le prestataire doit confirmer son choix avec elle avant l'accouchement, après l'accouchement et si possible juste avant la procédure. d'accouchement,.

La première confirmation est très importante si la femme avait choisi le DIU avant le travail (ex. : en CPN) car elle permet de s'assurer qu'elle n'a pas changé d'avis et donne au personnel de la salle d'accouchement suffisamment de temps pour se préparer à la procédure. Confirmer le choix de la contraception de la femme est une question de respect et aussi une opportunité pour la femme de poser des questions qu'elle peut encore avoir et pour le prestataire de lui donner des conseils, au besoin.

La seconde confirmation se produit après la deuxième évaluation, qui suit la naissance, juste avant l'insertion du DIU. Le prestataire explique qu'il est sur le point d'insérer le DIU, explique brièvement la procédure et s'assure que la femme est prête (c'est-à-dire, confirme qu'elle veut encore un DIU).

b. Première évaluation

Le prestataire devra évaluer les conditions cliniques de la cliente afin de vérifier que cette dernière est apte à recevoir le DIU.

c. Deuxième évaluation

Une deuxième évaluation devrait avoir lieu immédiatement avant l'insertion. Le but de cette deuxième évaluation est de s'assurer que le processus du travail et de l'accouchement n'a pas entraîné une quelconque situation clinique pour laquelle il serait déconseillé d'insérer le DIU. La deuxième évaluation doit procéder à une investigation afin de préciser les critères d'éligibilité médicale relatifs aux services de DIU qui peuvent être regroupés comme suit :

✓ Catégorie 1 :

- Insertion post placentaire, post partum immédiate, <48 heures ou pendant l'accouchement par césarienne
- ≥ 4 semaines post partum

✓ **Catégorie 2** : il n'existe pas de situation applicable

✓ **Catégorie 3** :

- Entre 48 heures et 4 semaines
- Chorioamniotite
- Rupture prolongée des membranes > 18 heures

✓ **Catégorie 4** :

- Septicémie puerpérale
- Hémorragie du postpartum non maîtrisée.

Les quatre conditions ci-dessous méritent de faire l'objet d'une discussion plus approfondie. Il est à noter que ces conditions ne sont pas représentées dans les MEC pour l'utilisation du DIU ; néanmoins elles précisent les exclusions et précautions basées sur des études cliniques et l'opinion des experts.

- **La chorioamniotite**
- **La rupture prolongée des membranes de plus de 18 heures**
- **L'hémorragie du postpartum persistante**
- **Traumatisme génital important :**
- **Après la seconde évaluation**

✓ **Si aucun critère d'exclusion n'est identifié**, le prestataire pourra informer la femme qu'on peut puis, insérer le DIU en toute sécurité et prendre les dispositions en vue de l'insertion.

Si un critère d'exclusion est identifié, le prestataire doit expliquer la raison pour laquelle le DIU ne peut être inséré et aider la femme à choisir une autre méthode, au moins une méthode temporaire. Si elle souhaite toujours adopter le DIU comme sa méthode de planification familiale du post partum, il est possible de la lui offrir après quatre semaines.

d. types d'insertion

Post placentaire	L'insertion post placentaire du DIU est effectuée immédiatement après l'expulsion du placenta, dans les 10 minutes.
	Le scénario : La femme se trouve dans la salle de travail ou d'accouchement L'insertion est réalisée immédiatement après la gestion active de la troisième période de l'accouchement et après la délivrance (l'expulsion du placenta).
	Insertion à l'aide d'un instrument (à l'aide d'une pince) : le DIU est tenu par un instrument (pince placentaire Kelly ou une autre longue pince approprié sans verrou). L'instrument est inséré au fond de l'utérus, et le DIU y est déposé. Cette technique exige que les instruments appropriés soient disponibles dans la salle d'accouchement. NB : Il existe des DIU à long inserteur dont l'insertion ne nécessite pas l'utilisation de pince.
Per césarienne :	le DIU est introduit à travers l'incision utérine pendant une césarienne et placé au fond de l'utérus.
	Le scénario : La femme a reçu un counseling et a été préparée avant le début de la césarienne. Après l'extraction du placenta, le prestataire insère le DIU
Insertion post partum immédiate :	Le DIU est inséré plus de 10mn et moins de 48 heures après la naissance du bébé. Le DIU ne devrait pas être inséré après 48 heures du post partum compte tenu du risque plus élevé d'expulsion spontanée.
	Le scénario : L'insertion post partum immédiate est d'habitude effectuée quelques heures après la naissance, voire le lendemain matin du premier jour du post partum afin de réduire les taux d'expulsion et d'éviter les problèmes logistiques au moment de la sortie de l'hôpital.
Insertion pendant la période post partum tardive et prolongée	✓ les femmes retournant pour des soins post partum à la quatrième semaine ou plus tard, peuvent également recevoir le DIU.

e. Instruments et matériels destinés à l'insertion du DIUPP

Tableau 7.1. Les instruments et les matériels nécessaires à l'insertion du DIU dans le Post Partum suivant la technique d'insertion

Technique d'insertion	Instruments et matériels	
Insertion postplacentaire	1.	Surface plate pour poser les instruments
	2.	Valves vaginales (Simms ou une autre valve vaginale)
	3.	Pinces à anneau ou pinces porte tampon
	4.	Pinces placentaires Kelly ou longue pince sans verrou
	5.	Bol pour tampons de coton
	6.	Tampons de coton
	7.	Bétadine
	8.	Gants stériles/ d'examen propres (si c'est le même prestataire qui a réalisé l'accouchement qui insère le DIU, les mêmes gants peuvent être portés)
	9.	Copper T 380A, qui a été ouvert sur une surface stérile
Insertion per césarienne	1.	Copper T 380A, qui a été ouvert sur une surface stérile
Insertion postpartum	1.	Surface plate pour poser les instruments
	2.	Source d'éclairage
	3.	Champ stérile à placer sur l'abdomen de la femme
	4.	Valves vaginales (Simms ou une autre valve vaginale)
	5.	Pinces à anneau ou pinces porte tampon
	6.	Pinces placentaires Kelly ou longue pince sans verrou
	7.	Bol pour tampons de coton
	8.	Tampons de coton
	9.	Bétadine
	10.	Gants stériles/ d'examen propres
	11.	Copper T 380A, qui a été ouvert sur une surface stérile

6. Etapes d'insertion du DIU dans le PP

Il existe plusieurs listes de vérification

a. Insertion post placentaire du DIU à l'aide d'une pince

✓ Sélection et évaluation médicale pré insertion

Ces étapes initiales sont destinées à s'assurer que la femme souhaite toujours obtenir le DIU dans le Post Partum et comprend ce qui sera fait. Le prestataire s'assure que rien concernant son travail n'a restreint sa capacité à utiliser la méthode. De même, le prestataire doit vérifier que les instruments et le DIU sont disponibles.

No	Etape	Explication
1.	Analysez le dossier de la femme pour vous assurer qu'elle est une bonne candidate du DIU.	Avant de s'approcher du lit de la femme, le prestataire doit analyser le dossier de la femme afin de confirmer que toutes les conditions la concernant, et qui pourraient faire que le DIU ne soit pas une bonne option de contraception pour elle, ont fait l'objet d'un examen. Le prestataire vérifie le dossier afin de s'assurer qu'elle a reçu un counseling sur la méthode.
2.	Assurez-vous qu'elle a reçu un counseling approprié portant sur l'insertion du DIU.	
3.	Utilisez le Support de sélection pré insertion, confirmez l'absence de conditions liées à l'accouchement empêchant l'insertion du DIU en ce moment : ▪ Rupture des membranes pendant plus de 18 heures ▪ Chorioamnionite ▪ Hémorragie postpartum non maîtrisée	

PPIUCD PRE-INSERTION SCREENING

In preparation for insertion of the IUCD, confirm the following information about the woman and her clinical situation:

Ask the woman whether she still desires the IUCD for PFPP	Yes	No
Review her antenatal record and be certain that:		
• her antenatal screening shows that an IUCD is an appropriate method for her	Yes	No
• she has had EP counseling while not in active labor and there is evidence of consent to her choice	Yes	No
• she is being counselled in the post-partum period	Yes	No
Review the course of her labor and delivery and ensure that none of the following conditions are present:		
If planning an immediate post-partum insertion, check that none of the following conditions are present:		
• Chorioamnionitis (during labor)	Yes	No
• More than 18 hours from rupture of membranes to delivery of baby	Yes	No
• Uncontrolled postpartum hemorrhage	Yes	No
If planning a postpartum insertion, check that none of the following conditions are present:		
• Prolapsed uterus	Yes	No
• Postpartum endometritis/infection	Yes	No
• Continued excessive postpartum bleeding	Yes	No
• Extensive genital trauma where the repair would be disrupted by postpartum placement of an IUCD	Yes	No
Confirm that sterile instruments are available*	Yes	No
Confirm that IUCDs are available and accessible on the labour ward*	Yes	No

* If sterile instruments or suitable IUCDs are not available, postpartum IUCD insertion if they become available within an appropriate time period.

If **YES**, has a checklist for the woman, after insertion of the IUCD and provide the woman with information about her choice.

If **NO**, the woman is not suitable for IUCD insertion.

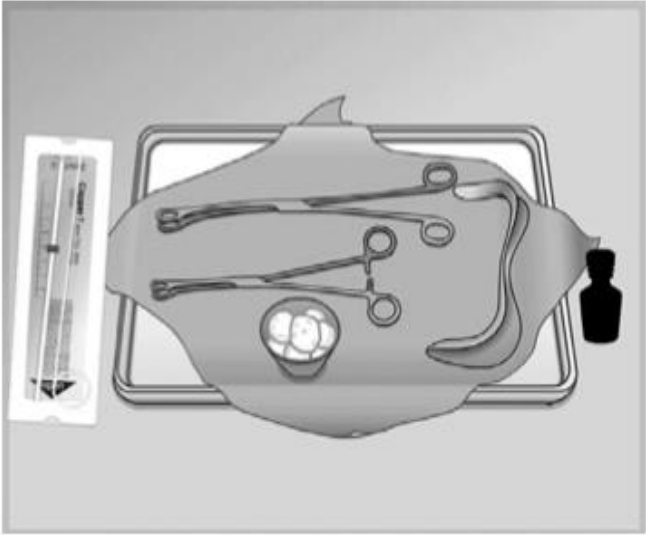
Le prestataire utilise le support de travail pour s'assurer qu'il n'existe pas d'infection liée à l'accouchement. En cas d'hémorragie non maîtrisée, la prise en charge de l'hémorragie devrait être assurée en priorité avant l'insertion du DIU.

4.	Si une de des conditions citées à l'étape 3 se présente, entreprenez-vous avec la femme et expliquez lui que ce n'est pas le bon moment pour insérer le DIU. Proposez à la femme de procéder à une nouvelle évaluation en vue de l'insertion du DIU à la sixième semaine postpartum. Conseillez-la et offrez-lui une autre méthode de PFPP en lieu et place.	Les femmes qui ne peuvent pas recevoir le DIU maintenant peuvent le recevoir le premier ou le deuxième jour postpartum. Autrement, il vous faudra l'aider à choisir une autre méthode de PFPP.
5.	Rassurez-vous que des instruments appropriés, du matériel et une source de lumière sont disponibles pour une insertion postplacentaire immédiate.	Le prestataire devrait être certain que tous les matériels sont prêts. Voir Tableau 7.1.
6.	Confirmez que des DIU sont disponibles dans la salle de travail.	

No	Etape	Explication
7.	Saluez la femme avec gentillesse et respect.	 Le prestataire devrait parler à la femme et lui permettre de poser des questions. Il est important de réaliser que la femme acceptera mieux le DIU si elle comprend comment il fonctionne et si vous la soutenez dans sa décision.
8.	Confirmez que la femme souhaite toujours obtenir le DIU.	
9.	Expliquez que vous allez insérer le DIU après la naissance du bébé et la délivrance du placenta. Répondez à toutes les questions qu'elle pourrait avoir.	

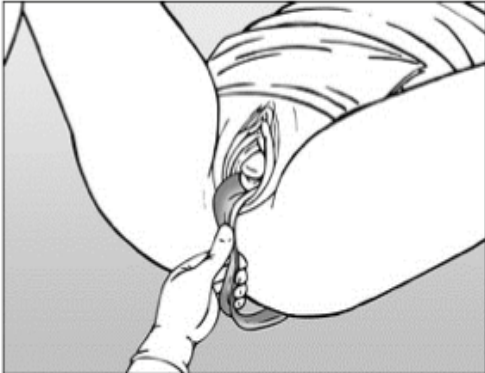
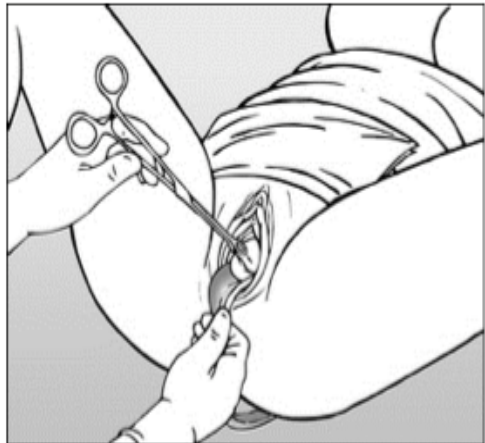
✓ Tâches pré-insertion

Avant de commencer l'insertion, le prestataire prépare les instruments pour ne pas avoir à reporter l'insertion, faute d'un instrument qu'il doit rechercher.

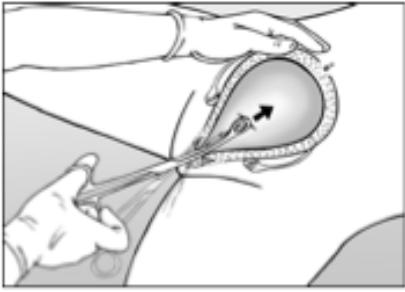
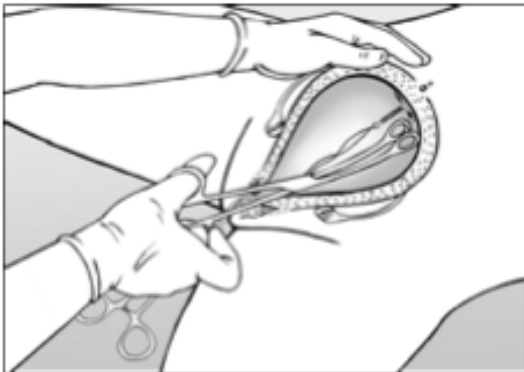
No	Etape	Explication
1.	Conformez-vous à l'hygiène des mains et portez des gants d'examen propres ou des gants stériles.	Si c'est le même prestataire qui a réalisé l'accouchement et l'insertion du DIU, il n'est pas nécessaire de changer de gants. Si un autre prestataire réalise l'insertion du DIU, alors ce prestataire devra se conformer à l'hygiène des mains et porter une nouvelle paire de gants stériles ou d'examen propres.
2.	Disposez les instruments et le matériel sur un plateau stérile ou une surface recouverte d'un drap stérile.	 A black and white illustration showing a sterile surgical tray. On the tray are several instruments: a pair of long-handled forceps, a pair of curved scissors, a pair of long-handled clamps, and a small circular object. To the left of the tray is a long, thin, rectangular object, possibly a speculum or a long forceps. To the right of the tray is a small, dark, cylindrical object, possibly a container for lubricant or a small bottle.

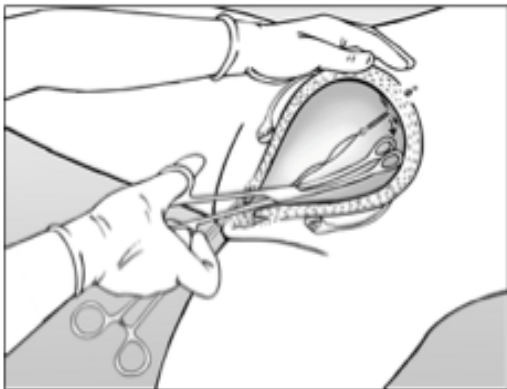
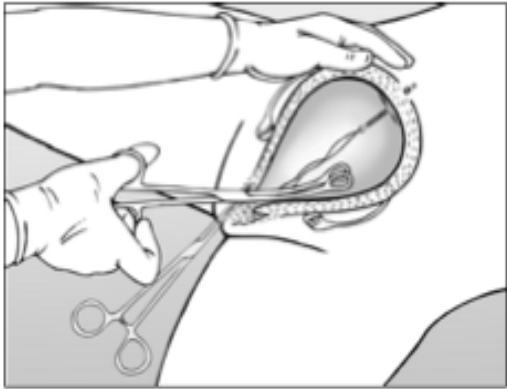
✓ Insertion du DIU

Les étapes de l'insertion du DIU devraient être suivies très minutieusement afin de réduire le risque d'expulsion spontanée. Les étapes ci-dessous concernent l'insertion post placentaire. Ces étapes diffèrent légèrement de l'insertion post partum immédiate.

No	Etape	Explication
1.	Inspectez le périnée, les lèvres et les parois vaginales à la recherche de déchirures. Si les déchirures ne saignent pas beaucoup, faites une réparation si nécessaire après l'insertion du DIU.	 Le prestataire tient la valve de Simms ou un autre spéculum approprié dans sa main gauche et l'utilise pour visualiser le col. D'habitude, il n'est pas nécessaire de faire tenir le spéculum en place par un assistant, mais si le prestataire a des difficultés, un assistant peu utiliser la valve pour visualiser doucement le col de l'utérus.
2.	Visualisez doucement le col de l'utérus en pressant la paroi postérieure du vagin.	
3.	Nettoyez le col de l'utérus et le vagin à l'aide d'une solution antiseptique deux fois en utilisant deux gazes.	 Utilisez de la bétadine ou de la chlorhexidine pour nettoyer doucement le col de l'utérus et les bords du vagin deux fois.
4.	Saisissez doucement la lèvre antérieure du col de l'utérus à l'aide de la pince à anneau.	
5.	Exercez doucement une traction sur la lèvre antérieure du col de l'utérus en utilisant la pince à anneau.	

No	Etape	Explication
6.	Saisissez le DIU à l'aide d'une pince placentaire Kelly ou d'une pince à anneau posez-le de côté.	 Comme noté plus haut, le DIU devrait être tenu juste au niveau du bord de la pince à anneau de sorte à ce que l'instrument puisse le déposer facilement lorsqu'il est ouvert.
7.	Insérer le DIU dans la cavité utérine inférieure. Evitez de toucher les parois du vagin.	
8.	Déplacez la main sur le segment inférieur de l'utérus (base de la main sur la partie inférieure du corps de l'utérus et les doigts vers le fond) et poussez doucement l'utérus vers le haut pour redresser l'utérus et faciliter l'entrée de l'instrument.	Le prestataire saisit la pince placentaire Kelly tenant le DIU et fait minutieusement passer le DIU dans la cavité utérine inférieure. Une fois que le DIU se trouve dans la cavité utérine inférieure, le prestataire baisse la pince à anneau qui tient la lèvre antérieure du col de l'utérus. La main gauche du prestataire se déplace sur l'abdomen de la femme et à travers la paroi abdominale, pousse tout l'utérus vers le haut. Ce geste vise à redresser l'angle se trouvant entre l'utérus et le vagin de sorte à ce que l'instrument puisse traverser facilement vers le haut, vers le fond de l'utérus.

No	Etape	Explication
9.	Déplacez doucement le DIU vers le haut, vers le fond de l'utérus (angle vers l'ombilic), après le contour de la cavité utérine. Faites attention de ne pas perforer l'utérus.	 Le prestataire déplace l'instrument vers le haut dans l'utérus, suite à un arc vers l'ombilic. Le prestataire devrait faire attention de ne pas exercer une force excessive. Si l'utérus n'est pas poussé vers le haut, il est possible que l'angle se trouvant entre le vagin et l'utérus ne permette pas à l'instrument d'avancer sans heurt. Le prestataire pourrait perforer la paroi postérieure de l'utérus s'il ne fait pas attention. S'il y a une grande résistance, le prestataire devrait repositionner l'utérus (en le poussant doucement vers le haut) et essayer de faire avancer l'instrument à nouveau. Le prestataire devrait toujours maintenir l'instrument fermé afin que le DIU ne tombe pas par inadvertance à mi-chemin dans la cavité utérine.
10.	Maintenez la pince fermée pour ne pas déplacer le DIU.	
11.	Vérifiez que le bout de la pince placentaire atteint le fond.	Lorsque l'instrument atteint le fond de l'utérus, le prestataire sentira une résistance. Le prestataire sentira probablement aussi que l'instrument est au fond de l'utérus à l'aide de sa main gauche à travers la paroi abdominale. Un autre avantage supplémentaire de la pince placentaire Kelly est le fait que l'anneau large se trouvant au niveau de l'extrémité distale diminue la probabilité qu'il puisse perforer le fond de l'utérus.
12.	Ouvrez la pince et déposez le DIU au fond.	
13.	Faites glisser la pince placentaire/ à anneau sur la paroi latérale de l'utérus.	
14.	Stabilisez l'utérus (en vous servant de la base de votre main que vous placez contre la partie inférieure du corps de l'utérus).	
15.	Retirez lentement la pince de la cavité utérine, en le maintenant légèrement ouvert. Faites particulièrement attention de ne pas déloger le DIU en retirant la pince.	

No	Etape	Explication
16.	Stabilisez l'utérus jusqu'à ce que la pince soit entièrement en dehors de l'utérus.	Le prestataire ouvre la pince et dépose le DIU au fond.  Pour aider à prévenir que le DIU ne soit entraîné vers le bas dans l'utérus, l'instrument est glissé vers la droite afin de s'assurer qu'il est loin du DIU.  Puis, l'instrument est retiré lentement, en le maintenant légèrement ouvert tout le temps. Si l'instrument se referme et attrape les fils du DIU, il peut par inadvertance déplacer le DIU de sa position au fond de l'utérus, augmentant ainsi le risque d'expulsion. Une traction dans le sens contraire est appliquée pour stabiliser l'utérus pendant le retrait de l'instrument.
17.	Examinez le col pour vous assurer qu'il n'y a pas de saignement. Si les fils du DIU sont visibles, retirez le DIU et réinsérez-le.	Il est important de vérifier que le DIU n'est pas visible au niveau de l'orifice cervical. S'il est visible, ou si les fils semblent être trop longs, alors le DIU n'a pas été bien placé au fond et le risque d'expulsion spontanée est plus grand. S'il se trouve que le DIU n'a pas été placé assez haut, le prestataire peut utiliser la même pince Kelly pour retirer le DIU et répéter les étapes 6 à 17.
18.	Retirez tous les instruments utilisés et placez-les dans une solution de chlore à 0,5%.	La pince placentaire Kelly est placée dans une solution de chlore à 0,5%. Le prestataire retire la pince à anneau du col, et le met, en même temps que le spéculum dans la solution de chlore.

✓ Tâches post insertion

Après l'insertion du DIU, le prestataire termine certaines étapes qui se rapportent au counseling, à la prévention des infections et à l'enregistrement des données.

No	Etape	Explication
1.	Laissez la femme se reposer quelques minutes. Encouragez-la à commencer les soins postpartum de routine, y compris l'allaitement dans l'immédiat.	La femme devrait se reposer sur la table pendant plusieurs minutes après la procédure d'insertion. Le prestataire devrait la rassurer que l'insertion s'est bien passée et qu'il n'y a rien d'autre à faire en ce moment.
2.	Eliminer tous les déchets de manière adéquate.	Toutes les étapes de prévention des infections devraient être suivies. Etant donné que la procédure a eu lieu immédiatement après un accouchement par voie vaginale, le prestataire devrait se conformer à toutes les pratiques routinières de prévention des infections, y compris l'évacuation des déchets dans le récipient approprié, le retrait des gants, et le respect de l'hygiène des mains.
3.	Plongez tous les deux gants dans une solution de chlore à 0,5%. Retirez les gants en les retournant vers l'intérieur et jetez les dans la poubelle.	
4.	Conformez-vous à l'hygiène des mains.	
5.	Donnez à la femme les instructions post insertion. ▪ Prévoyez une fiche précisant le type de DIU inséré et la date d'insertion. ▪ Passer en revue les effets secondaires du DIU et les symptômes normaux du postpartum. ▪ Dites à la femme quand elle doit revenir pour un contrôle du DIU/ visite postnatale / examen du nouveau-né. ▪ Insistez en lui disant qu'elle devrait revenir à tout moment si elle a des soucis ou observe certains signes avertisseurs. ▪ Passez en revue les signes d'alerte du DIU. ▪ Passez en revue comment vérifier la survenue d'une expulsion et que faire en cas d'expulsion. ▪ Assurez la femme que le DIU n'affectera pas le lait maternel ▪ Assurez-vous que la femme comprend les instructions post insertions. ▪ Donnez-lui des instructions post insertion écrites, si possible.	 Pendant que la femme se repose, et que le prestataire exécute les pratiques nécessaires de prévention des infections, il devrait donner à la femme les instructions post insertion nécessaires, comme noté. Ces instructions devraient être données encore par le personnel de l'unité postpartum et répétées à la femme, et peut-être à sa famille encore après afin de s'assurer que ces instructions ont été comprises. Si possible, ces instructions devraient être données à la femme sous forme écrite, afin qu'elle puisse les apporter à la maison.
6.	Enregistrez les informations sur la fiche ou le dossier de la femme.	Le prestataire devrait enregistrer les informations concernant l'insertion du DIU dans le dossier de la femme et dans le registre approprié. Il peut être plus approprié d'enregistrer ces informations dans le registre de la salle d'accouchement. Cependant, elles devraient être aussi enregistrées avec d'autres informations de contact dans un registre sur les services de DIUPP que le programme tient au début pour servir de preuve que le programme est exécuté avec succès.
7.	Enregistrez les informations dans le registre de la salle de procédure ou dans le registre du DIUPP.	

b. Soins post insertion immédiats et counseling

Après la procédure d'insertion, les directives obstétricales standard de soins post partum devraient être respectées :

- massage utérin possible,
 - initiation à l'allaitement
 - Surveillance des signes vitaux
 - Recherche des signes d'infection
 - Administration d'utérotoniques et ATB
- Le DIU ne devrait être retiré uniquement que sur demande de la patiente et/ ou si on suspecte une des**

conditions suivantes :

- ✓ Expulsion partielle
- ✓ Septicémie puerpérale
- ✓ Perforation de la paroi utérine
- ✓ Douleurs utérines persistantes d'origine non identifiée^[SEP]

Après l'insertion, rappelez à la cliente ce qui suit :

- ✓ S'attendre à un saignement vaginal ou des saignotements, ainsi qu'à des crampes et douleurs pendant au moins quelques jours après l'insertion.
- ✓ Savoir que les saignements vaginaux et les crampes intermittents sont normaux pendant les quatre à six premières semaines du post partum.
- ✓ Prendre de l'ibuprofène, du paracétamol ou un autre antalgique, si nécessaire.
- ✓ Vérifier si le DIU est expulsé ou pas. Une expulsion spontanée peut se produire au cours des trois premiers mois du post partum. La femme devrait contrôler les draps de lit le matin, et ses sous-vêtements lorsqu'elle se change. A la sixième semaine du post partum, certaines femmes peuvent sentir les fils du DIU. Il n'est pas nécessaire de faire un contrôle à la recherche des fils. Le prestataire vérifiera les fils lorsqu'elle retournera pour sa visite post natale. C'est pourquoi il est important pour elle de retourner voir le même prestataire, ou au moins, quelqu'un d'autre dans le même service qui s'y connaît en matière de services liés au DIU dans le Post Partum.
- ✓ Se rappeler que le DIU ne protège pas contre les IST et le VIH.
- ✓ Recommencer à avoir des relations sexuelles dès que vous vous sentez prête en sachant que vous êtes ^[SEP]entièrement protégée contre une grossesse.
- ✓ En cas de souhait de retrait du DIU retourner voir le prestataire à tout moment pour le retirer et vous retrouverez immédiatement votre fécondité.

Avant la sortie de la clinique, les signes de danger suivants devraient être soulignés et la cliente devrait être encouragée à appeler ou à venir immédiatement à la structure de santé pour une évaluation :

- ✓ Saignement vaginal abondant
- ✓ Malaise intense dans la partie inférieure de l'abdomen
- ✓ Fièvre
- ✓ Malaise général

La cliente devrait également être encouragée à appeler ou à venir à la maternité pour une évaluation si les signes suivants surviennent :

- ✓ Ecoulement vaginal inhabituel
- ✓ Expulsion suspecte : la cliente peut sentir que le DIU est dans le vagin ou l'a vu sortir du vagin.
- ✓ D'autres problèmes ou des questions se rapportant à son DIU.
- ✓ Retrait du DIU quand elle le désire ou 12 ans après l'insertion

Si possible, offrez à la cliente une fiche avec les informations suivantes sous forme écrite :

- ✓ Type de DIU inséré
- ✓ Date d'insertion du DIU
- ✓ Mois et année auxquels le DIU devra être retiré ou remplacé
- ✓ Date de la visite de suivi du postpartum
- ✓ Où aller ou appeler si la femme a des problèmes ou des questions concernant son DIU

c. Soins de suivi et gestion des problèmes potentiels

Des soins de suivi de haute qualité destinés aux clients de la planification familiale contribuent à une plus grande satisfaction, ainsi qu'à une utilisation en toute sécurité, efficace et continue de la méthode. Les soins et les conseils fournis aux clientes doivent insister sur la reconnaissance des signes de danger et la localisation de services de soins de santé accessibles en cas d'urgence. Les effets secondaires et les complications éventuels pouvant apparaître sont essentiellement liés au DIU, non au fait que l'insertion ait eu lieu pendant la période du post partum. Tout effet secondaire et toute complication capable de survenir devraient être par conséquent pris en charge de la même manière que ceux consécutifs à une insertion du DIU d'intervalle.

Après l'insertion du DIU dans le Post Partum, il y a lieu de conseiller à la femme de retourner à la maternité pour

des soins du post partum de routine conformément aux normes de l'OMS et aux normes nationales, à moins qu'elle ait des problèmes sérieux qui nécessitent des services d'urgence. Les soins routiniers de suivi du DIU dans le Post Partum devraient être entièrement intégrés dans les services du post partum standards. La femme est également encouragée à retourner si elle a des problèmes, s'il y a eu un changement au niveau de sa santé d'une manière générale, si elle souhaite faire retirer le DIU, ou pour une quelconque autre raison.

Le suivi routinier, Les utilisatrices auront besoin de soins et de soutien supplémentaires. Le présent chapitre met en exergue les éléments clés du soutien à apporter à l'utilisatrice du DIU, en mettant l'accent sur les prestations fournies, les services de suivi de routine et la gestion des problèmes potentiels.

7. Objectifs principaux des soins de suivi des clientes du DIUPP

Les objectifs clés des soins de suivi consistent à :

- Evaluer la satisfaction globale de la femme vis-à-vis du DIU
- Identifier et gérer les problèmes potentiels
- Répondre à toutes les questions ou préoccupations de la femme
- Renforcer les messages clés concernant le retrait et la durée d'action

➤ Visite routinière de suivi dans le post partum

Le suivi du DIU devrait être intégré dans les soins standards du post partum suivant les directives nationales et régionales.

L'OMS recommande actuellement au moins une visite du Post partum dans les six semaines après l'accouchement.

En plus des éléments habituels du bilan du post partum, les éléments suivants devraient être considérés chez toutes les femmes affirmant avoir bénéficié d'une insertion du DIUPP :

- Demandez à la cliente si elle a des questions ou a observé l'un des signes de gravité ou a rencontré l'un des problèmes tels que décrits ci-dessus
- Effectuez un examen pelvien si vous suspectez les conditions suivantes : une IST ou une IGH, expulsion partielle ou totale, grossesse.

Il n'est pas obligatoire de procéder à un examen pelvien routinier lors de la visite de suivi.

- Conseillez à la cliente de revenir si elle a une préoccupation éventuelle se rapportant au DIU et ou si elle souhaite changer de méthode de planification familiale.
- Passez en revue les signes avertisseurs qui renseignent sur la nécessité de retourner immédiatement à la clinique.
- Rappelez à la cliente de vérifier une éventuelle expulsion du DIU pendant ou après ses premières règles.
- Si le DIU a été expulsé, offrez à la cliente une autre méthode contraceptive ou prévoyez de lui insérer un autre DIU si elle le souhaite. Le DIU peut être inséré le jour même où l'expulsion s'est produite s'il n'y a aucun signe d'infection, de grossesse et si la cliente se trouve à <48 heures ou au moins à quatre semaines après l'accouchement.
- Encouragez l'utilisation de préservatifs en vue d'une protection contre les IST, si nécessaire.
- Si le DIUPP est en place et que la cliente n'a pas de problèmes, il n'est pas nécessaire de prévoir d'autres visites de suivi. Les contrôles annuels du DIU ne sont pas nécessaires. Il faudrait conseiller aux clientes de retourner pour faire retirer le DIU quand elles le désirent. Cependant elles ne doivent pas attendre après la durée recommandée de protection contre la grossesse ou si elles ont des problèmes ou préoccupations relatives au DIU.

➤ Identification et gestion des effets secondaires communs et problèmes potentiels

La plupart des effets secondaires associés à l'utilisation des DIU ne sont pas graves et se résolvent spontanément.

L'objectif visé par les directives ci-dessous consiste à aider le prestataire de santé à offrir un appui adéquat à une femme confrontée à de tels effets secondaires. Dans la plupart des cas, la femme peut continuer à utiliser le DIU tout en attendant l'évaluation. Certains problèmes liés à l'utilisation du DIU exigent une gestion spécifique ; ce sont entre autres :

- Les modifications des modes de saignement menstruels
- La survenue de crampes ou de douleurs
- Une infection
- Des problèmes liés aux fils du DIU (ou une expulsion éventuelle du DIU)
- L'expulsion partielle ou totale du DIU (confirmée)
- Une grossesse avec un DIU en place
- Une perforation utérine

➤ Principes généraux de prise en charge

- La femme devrait être rassurée et toutes les informations dont elle a besoin pour l'encourager à poursuivre (ou à

- arrêter) l'utilisation de la méthode devraient lui être données, si nécessaire, et suivant son désir.
- Si elle signale des problèmes qui ne sont pas abordés dans les directives, le prestataire devrait procéder à une évaluation plus profonde et offrir un traitement selon les protocoles directives nationaux (s'y référer, le cas échéant).
- Si le prestataire n'a pas reçu la formation ou ne dispose pas des ressources nécessaires pour effectuer les évaluations, les procédures ou pour prescrire les traitements indiqués dans les directives de prise en charge, il devrait référer la femme à une structure appropriée.
- Si la femme veut faire retirer le DIU pour une quelconque raison, et ou utiliser une autre méthode contraceptive, retirez le DIU ou proposez-lui une date à laquelle elle devrait revenir pour le retrait du DIU, le cas échéant et offrez-lui une autre méthode immédiatement.

➤ **Prévenir les problèmes liés à l'insertion du DIUPP**

Beaucoup de complications liées à l'insertion du DIUPP peuvent être évitées grâce à :

- La sélection minutieuse des clientes
- Une attention méticuleuse à la technique d'insertion appropriée
- L'observation stricte des techniques correctes de prévention des infections
- La réalisation des procédures d'insertion du DIUPP lentement et doucement pour garantir une exactitude technique, le confort et la sécurité de la cliente.

➤ **Identification et gestion des problèmes courants rencontrés pendant ou immédiatement après une insertion**

✓ **Malaise de la cliente**

La pose intra-utérine du DIUPP, indépendamment du moment après l'accouchement ou de la technique, s'accompagne couramment d'un certain malaise d'intensité modérée.

• **Gestion**

- Avertissez la cliente que l'insertion s'accompagne d'un certain malaise d'intensité modérée.
- Parlez à la cliente pendant la procédure et décrivez au fur et à mesure ce que vous faites au moment même où vous le faites.
- Effectuez la procédure aussi doucement et aussi rapidement que possible.
- Offrez des analgésiques, en cas de besoin.

✓ **Déplacement du DIUPP pendant ou immédiatement après l'insertion**

Le positionnement du DIUPP en haut, tout au fond de l'utérus peut constituer un facteur important évitant une expulsion plus tard. On ne cessera jamais de dire comment il est important de placer le DIU au fond de l'utérus. Même dans le cas où on utilise une technique chirurgicale rigoureuse, le DIU peut être délogé ou peut sortir spontanément pendant ou immédiatement après la pose.

• **Signes ou symptômes éventuels**

- Le DIU est délogé par la main (technique manuelle) ou la pince utilisée pour l'insérer (technique instrumentale) pendant le retrait de l'instrument hors de l'utérus.
- Le DIU peut être visualisé au niveau du col de l'utérus ou dans la partie supérieure du vagin après la pose.
- La longueur des fils qui pendent dans le vagin indique que le DIU n'a pas été placé au fond de l'utérus.

• **Gestion**

- En vous servant d'une pince stérile en cas de nécessité d'un sondage intra-utérin, retirez le DIU et éliminez-le s'il a été contaminé ou remettez-le dans son emballage stérile si cela n'est pas le cas. Quelquefois, le DIU peut être retiré en saisissant simplement les fils qui pendent dans le vagin.
- Changez de gants stériles si ceux-ci ont été contaminés.
- Changez d'équipements stériles si ceux-ci ont été contaminés.
- Prenez un nouveau DIU si le premier a été contaminé.
- Préparez à nouveau le vagin et le col en les nettoyant à l'aide d'un antiseptique approprié.
- Insérez le DIU conformément à la technique standard.

✓ **Déchirures du col**

Les déchirures du col qui se sont produites pendant le processus d'accouchement devraient être réparées comme indiqué en utilisant une technique obstétricale standard. En cas d'hémorragie, l'insertion du DIU devra être reportée jusqu'à ce qu'une réparation ait été réalisée, que l'hémorragie ait été maîtrisée et que la cliente soit stable. Pendant l'insertion du DIUPP, seule une pince à anneau ou un clamp similaire non traumatique devraient être utilisés pour la stabilisation du col.

L'application d'une traction douce à l'aide du clamp réduira davantage la survenue d'une déchirure d'une lèvre antérieure. Il faudrait toujours vérifier le col à la recherche d'une éventuelle déchirure après le retrait du clamp.

• **Signes ou symptômes éventuels :**

- Saignement vaginal commençant soudainement

Gestion

- Si une déchirure se produit, réparez comme il se doit, suivant la taille de la déchirure et l'abondance du saignement. On peut laisser les petites déchirures qui ne saignent pas se cicatriser spontanément.

✓ Perforation utérine

Bien qu'une perforation de l'utérus soit très rare, lorsqu'elle se produit, c'est presque toujours au moment de l'insertion. Les principales étapes de gestion d'une perforation utérine sont les mêmes, qu'il s'agisse ou non d'une insertion d'intervalle ou d'une insertion postpartum immédiate. Une perforation peut être silencieuse et être découverte des jours, des semaines ou des mois après la procédure d'insertion du DIU. De telles perforations sont d'habitude découvertes en même temps qu'une grossesse non planifiée et/ ou au cas où l'on ne retrouve pas les fils et sont confirmées grâce à une radiographie ou à une échographie pelvienne.

Une prise en charge appropriée d'une perforation utérine dépend du moment auquel la perforation s'est produite et/ ou a été découverte, qu'elle soit partielle (le DIU s'est incrusté dans la paroi de l'utérus) ou complète (le DIU se trouve en dehors de la cavité utérine), et si elle s'accompagne de signes/ symptômes.

- Signes/ symptômes éventuels :
 - Perte soudaine pendant l'insertion de la résistance de l'instrument utilisé pour insérer le DIU
 - Profondeur utérine plus grande que ce à quoi l'on s'attend pendant l'insertion
 - Douleurs inexplicables qui sont pires que celles que l'on observe en général pendant l'insertion post partum
 - Perforation partielle ou totale confirmée par la radiographie ou l'échographie
 - Fils introuvables à l'examen pelvien

Gestion

- Si pendant l'insertion on suspecte une perforation, arrêtez immédiatement l'insertion et retirez doucement l'instrument/ l'objet qui a pu perforer la paroi utérine, à savoir le DIU (en tirant sur les fils ou sur le DIU lui-même) ou la pince utilisée pour insérer le DIU.
- Si vous rencontrez une résistance et que le retrait n'est pas possible, arrêtez de tirer et référez la femme immédiatement à une consultation chirurgicale d'urgence. Il peut être obligatoire de recourir à une radiographie ou à une échographie pour documenter le lieu où se trouve le DIU. Il peut être obligatoire de recourir à un retrait par voie chirurgicale réalisé par un chirurgien qualifié.
- Maintenez la cliente au repos et observez-la à la recherche de signes de saignement intra-abdominal : hypotension ; tachycardie ; douleur abdominale intense accompagnée d'endolorissement, contractures musculaires ou rigidité de l'abdomen à l'examen.
- Commencez une perfusion intraveineuse et effectuez une série de contrôles de l'hémoglobine/ des hématocrites à des intervalles réguliers.
- Vérifiez les signes vitaux de la cliente en surveillant son pouls, son rythme respiratoire, sa pression artérielle et sa température toutes les 5 à 10 minutes pendant les 60 premières minutes qui suivent la perforation. Si les signes vitaux sont stables, continuez à surveiller la cliente chaque heure pendant les quatre prochaines heures et puis toutes les quatre heures pendant 24 heures.
- S'il y a un changement dans les signes vitaux ou si la cliente se plaint de douleurs intenses ou de signes péritonéaux, continuez à la surveiller et référez-la pour une évaluation chirurgicale d'urgence.
- Envisagez l'administration d'un traitement à base d'antibiotiques suivant les directives nationales.
- Si vous suspectez une perforation utérine plusieurs jours ou semaines après l'insertion du DIU, confirmez à l'aide d'une radiographie ou d'une échographie.
- Si le DIU est incrusté dans la paroi de l'utérus (perforation partielle), référez la femme pour un retrait auprès d'un prestataire spécialement qualifié qui utilisera une pince étroite pour retirer le DIU de manière transvaginale, si possible.
- Si le DIU se trouve en dehors de la cavité utérine (perforation totale), référez la femme auprès d'un chirurgien qualifié pour le retrait du DIU par laparoscopie ou laparotomie.

➤ Autres effets secondaires et problèmes courants rencontrés après l'insertion du DIUPP

✓ Changements de modes de saignement menstruels

Les changements de modes de saignement menstruels sont un effet secondaire courant chez les utilisatrices du DIU, indépendamment du moment d'insertion. Au cours des six premières semaines post partum, de tels changements sont masqués par les saignements et les saignotements irréguliers habituels liés à l'involution de l'utérus pendant la période post partum. D'habitude, ces changements ne sont pas dangereux pour la femme et diminuent ou disparaissent après les premiers mois qui suivent l'insertion du DIU. Si cependant ces symptômes sont sévères, persistent et s'accompagnent de certains autres signes ou symptômes, ils ont besoin d'un suivi spécial.

Par exemple, pour une femme en période post partum qui pratique la MAMA, l'aménorrhée peut se produire en association avec le DIU.

- Signes/ Symptômes éventuels :

- Augmentation de la quantité du saignement menstruel plus que ce à quoi l'on s'attend habituellement pendant la période post partum
- Augmentation de la durée du saignement menstruel plus que ce à quoi l'on s'attend habituellement pendant la période post partum
- Spotting/ saignements légers entre les règles une fois qu'elles commencent le post partum

Gestion

- Déterminez la sévérité des symptômes : abondance du saignement par rapport aux saignements habituels ; pendant combien de temps les symptômes ont-ils duré ; A quel moment les symptômes avaient-ils commencé ; sont-ils accompagnés d'autres symptômes (exemple, douleur, fièvre) ; comment la femme supporte-t-elle ces symptômes ?
- Si les symptômes sont modérés et sont ceux qui accompagnent normalement l'involution de l'utérus pendant la période postpartum, rassurez la femme.
- Si nécessaire, recherchez d'autres pathologies gynécologiques et réferez la femme à un praticien qualifié .
- Si nécessaire, investiguez à la recherche d'une grossesse en vous basant sur les antécédents ou les tests disponibles.
- Si nécessaire, procédez à des vérifications pour voir si le DIU n'a pas été expulsé : palpez les fils grâce à un examen vaginal bi manuel ou visualisez au niveau de la vulve ou en utilisant un spéculum.
- Si la cliente souhaite avoir un traitement, offrez-lui un traitement court à base de médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens à commencer pendant les saignements et à poursuivre pendant trois à 5 jours.
- Si les saignements continuent à être abondants et durent longtemps ou sont suivis de signes cliniques ou laboratoires accompagnent logiquement une anémie grave, offrez- lui un traitement à base de fer par perfusion et envisagez de retirer le DIU avec le consentement de la patiente.
- Si la cliente trouve qu'elle saigne de manière inacceptable, retirez le DIU et offrez-lui un counseling portant sur d'autres méthodes alternatives de planification familiale afin de l'aider à choisir une autre méthode.

✓ Crampes ou douleurs

Les crampes modérées intermittentes peuvent se produire au cours des quelques premières semaines suivant l'insertion du DIU, mais elles sont généralement masquées par les crampes habituelles accompagnant l'involution de l'utérus pendant la période postpartum (« tranchées utérines »). Le retour des règles peut s'accompagner également de plus de crampes et de douleurs et est un effet secondaire que l'on rencontre couramment chez toutes les utilisatrices du DIU. Il est nécessaire de procéder à un suivi spécial si les symptômes sont gênants, intenses ou s'accompagnent d'autres signes ou symptômes.

- Signes ou Symptômes éventuels
- Plus de crampes ou des douleurs plus intenses accompagnant ou non la menstruation.

Gestion

- Déterminez la sévérité des symptômes : quelle est l'intensité des douleurs ; depuis combien de temps durent les douleurs, et à quel moment les douleurs avaient-elles commencé ; les douleurs s'accompagnent-elles d'autres symptômes (exemple, saignements, fièvre) ; comment la femme supporte-t-elle ces douleurs ?
- Procédez à une bonne évaluation incluant les signes vitaux, un examen abdominal et pelvien et des examens de laboratoire appropriés (test de grossesse ; hémogramme, cultures) afin d'identifier d'autres causes éventuelles des douleurs : infection ; expulsion partielle du DIU, perforation utérine ; grossesse intra utérine ou grossesse ectopique ; infection urinaire (Voir la section portant sur la prise en charge des infections et de la grossesse avec le DIU en place).
- Si les symptômes et les résultats des examens physiques sont modérés et accompagnent logiquement l'involution de l'utérus pendant la période post partum, rassurez la femme.
- Recommandez un traitement court à base d'anti-inflammatoires non stéroïdiens immédiatement avant ou pendant la menstruation afin d'aider à réduire les douleurs et les crampes menstruelles qui ennuiant la cliente.
- Si les crampes ou les douleurs sont intenses, retirez le DIU. Si le DIU avait été mal placé, est partiellement expulsé ou est tordu de manière anormale, discutez avec la cliente de l'insertion d'un nouveau DIU. Si le DIU semble être dans une bonne position et est normal, conseillez à la patiente une méthode alternative de planification familiale.

✓ Infection

Bien que le risque d'infection après l'insertion d'un DIU d'intervalle et non lié à une grossesse soit très faible, il atteint son plus haut degré dans les 20 premiers jours suivant l'insertion et on pense qu'il est en général lié à une infection à gonorrhée ou à chlamydia concomitante.

Il n'existe pas d'estimations similaires de risques concernant l'insertion post-partum immédiate du DIU, mais des études indiquent que le risque est très faible. Compte tenu du fait qu'une infection pelvienne peut conduire à la stérilité et à d'autres problèmes graves, les prestataires devraient traiter tous les cas suspects. Par exemple, le DIU ne devrait jamais être inséré lorsqu'une infection puerpérale telle qu'une endométrite est suspectée.

- Signes ou Symptômes éventuels
- Douleurs dans le bas-ventre
- Fièvre

- Douleurs pendant les rapports sexuels
- Saignements après les rapports sexuels ou entre les règles une fois que les menstrues ont recommencé à revenir chaque mois normalement pendant la période postpartum
- Nouvel épisode de douleurs associé aux règles
- Écoulement vaginal anormal
- Nausées et vomissement

Gestion

- Procédez à une bonne évaluation incluant les signes vitaux, un examen abdominal et pelvien, examens de laboratoires appropriés (test de grossesse, hémogramme, cultures) afin d'identifier d'autres problèmes : endométrite ; appendicite ; expulsion partielle du DIU ; perforation utérine, grossesse extra utérine ou grossesse ectopique ; ou infection urinaire. (Voir la section pour une prise en charge de la grossesse avec un DIU en place).
- Suspectez une MIP si l'un des signes ou symptômes suivants se présente et si on ne peut pas identifier d'autres causes :
 - Sensibilité du bas-ventre, de l'utérus ou des annexes (sensibilité dans les ovaires ou dans les trompes de Fallope)
 - Preuve d'une infection cervicale : écoulement cervical jaune contenant du mucus et du pus, saignement cervical au toucher à l'aide d'un tampon, prélèvement sur écouvillon positif
 - Sensibilité ou douleur lorsqu'on déplace le col et l'utérus pendant un examen vaginal bi manuel
 - D'autres signes ou symptômes possibles : écoulement cervical purulent ; augmentation de volume ou durcissement (induration) d'une ou des deux trompes de Fallope ; une masse pelvienne sensible ; douleur lorsque l'on presse doucement l'abdomen (sensibilité abdominale directe) ou lorsque l'on presse doucement et puis relâche soudainement (sensibilité abdominale au rebond)
- Si une endométrite ou une MIP est suspectée, commencez immédiatement le traitement à l'aide d'un protocole à base d'antibiotiques appropriés suivant les directives et les protocoles nationaux de traitement de la gonorrhée, de la chlamydia et des infections anaérobies. Retirez le DIU uniquement en cas de septicémie ou si les symptômes ne s'améliorent pas en l'espace de 72 heures. Des études n'ont pas indiqué que le retrait du DIU affecte les résultats du traitement.
 - Si la femme ne souhaite pas garder le DIU pendant le traitement, retirez-le deux à trois jours après le début du traitement antibiotique.
- Si vous suspectez une IST, conseillez si nécessaire à la femme d'utiliser un préservatif pour se protéger contre une autre IST et recommandez un traitement à son partenaire.

✓ Problèmes liés aux fils du DIU

Des fils introuvables, trop courts ou trop longs peuvent indiquer divers problèmes, à savoir une grossesse, une expulsion du DIU, un mauvais emplacement et/ ou une perforation utérine. Quelquefois, il n'y a pas de problème réel. Dans certaines circonstances, par exemple, il est possible que les fils du DIU ne descendent jamais à travers le col dans le vagin après une insertion post partum immédiate. Même des fils visualisés dans la partie supérieure du vagin après insertion peuvent remonter dans l'utérus pour une raison inconnue. Les fils du DIU n'ont rien à voir avec un souci d'efficacité. Ils ont été mis uniquement dans le but de faciliter le retrait et la confirmation de sa présence dans l'utérus. Compte tenu du fait que les fils ne sont pas encore coupés au moment de l'insertion post placentaire, per césarienne et post partum immédiate, on doit s'attendre à ce qu'ils atteignent facilement le milieu du vagin et peut être le niveau de la vulve d'ici 4 à 6 semaines post partum.

- Signes ou Symptômes éventuels :

- Le partenaire peut sentir les fils
- Des fils trop longs
- Des fils trop courts
- Des fils introuvables

Gestion

- Gestion des fils capables d'être sentis par le partenaire de la femme :
 - Rassurez la femme et son partenaire que les fils sont très souples et inoffensifs.
 - Si c'est très dérangement pour le partenaire de la femme, échangez avec la femme et conseillez-la comme suit :
 - Il est possible de couper les fils de sorte à les rendre courts, au niveau de l'orifice externe ou de sorte à ce que les fils se courbent autour de la lèvre cervicale, mais une fois coupés, elle ne pourra plus les vérifier.
 - Un nouveau DIU peut être inséré et les fils coupés de sorte à ce que son partenaire ne les sente pas
- Gestion des fils introuvables ou des fils plus longs ou plus courts ;
- Investiguez à la recherche d'une grossesse (un examen gynécologique ou une analyse des antécédents ou à des examens de laboratoire ou une échographie).
 - Examinez le canal cervical en vous servant d'une brosse cervicale ayant subi une désinfection de haut niveau ou stérile ou d'une pince étroite (exemple : pince
 - « caïman », pince à griffes) pour localiser les fils et les tirer doucement vers l'extérieur de sorte à ce qu'ils soient en saillie dans le canal vaginal.

- Si les fils ne sont pas situés dans le canal cervical, référez la femme pour une radiographie ou une échographie pelvienne pour confirmer un positionnement normal dans l'utérus.
- Offrez une méthode de soutien pendant que vous attendez les résultats. Gérez comme il se doit en fonction des résultats suivants :
 - Si le DIU est situé à l'intérieur de l'utérus et que la femme souhaite le garder, ne le retirez pas. Expliquez-lui que le DIU la protège toujours d'une grossesse mais qu'elle ne pourra plus sentir les fils. Passez en revue les signes et les symptômes d'une expulsion spontanée.
 - Si le DIU se trouve à l'intérieur de l'utérus et la femme souhaite le faire retirer, référez-la auprès d'un prestataire formé qui se chargera de le retirer.
 - Si le DIU se trouve en dehors de l'utérus, gérez comme prévu en cas de perforation utérine.
 - Si le DIU ne peut pas être visualisé dans l'utérus ou dans la cavité péritonéale, gérez comme prévu en cas d'expulsion totale du DIU (ci-dessous).

✓ **Expulsion partielle ou totale du DIU**

Une expulsion partielle ou totale du DIU peut se produire de manière silencieuse ou peut s'accompagner de signes ou symptômes suivants :

- Nouvel épisode de saignement irrégulier et/ ou survenue de crampes
- DIU expulsé observé (expulsion totale)
- DIU senti/ vu dans le canal vaginal (expulsion partielle)
- Règles en retard ou absentes (voir grossesse avec DIU en place)
- Fils introuvables ou trop longs (voir problèmes liés aux fils du DIU)

Gestion

- Procédez à une bonne évaluation, y compris un examen pelvien afin d'identifier d'autres causes possibles des symptômes comme une infection et une grossesse.
- Lorsque d'autres causes possibles des symptômes sont identifiées gérez-les en fonction des résultats :
 - Si une expulsion totale du DIU est confirmée (exemple, vu par la femme, confirmée par rayons X ou ultrason) : remplacez immédiatement le DIU si la femme le souhaite et s'il n'y a pas de contre indications (ni enceinte, ni infectée) ou conseillez à la femme d'utiliser une autre méthode de planification familiale.
 - Si une expulsion partielle du DIU est confirmée (exemple, senti/ vu par la femme ou le clinicien) : retirez le DIU et remplacez-le si la femme le désire et si s'il n'y a pas de contre indications (ni enceinte, ni infectée) ou conseillez à la femme d'utiliser une autre méthode de planification familiale.
 - Si le DIU semble s'être incrusté dans le canal cervical et ne peut pas être retiré facilement de la manière standard, référez la femme auprès d'un prestataire spécialement formé qui se chargera de retirer le DIU.
 - Si une expulsion totale de DIU est confirmée et qu'une grossesse est diagnostiquée, gérez en fournissant des soins prénataux conformément aux standards nationaux et régionaux.

a. Grossesse avec un DIU en place

Bien que le DIU soit une des formes les plus efficaces de contraception réversible, des échecs peuvent se produire. Approximativement un tiers des grossesses avec un DIU en place sont dus à des expulsions partielles ou totales non détectées du DIU. Lorsqu'une grossesse survient avec un DIU en place, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une grossesse ectopique et le DIU devrait être retiré. Si le DIU demeure en place pendant la grossesse, il y a un risque accru de déclenchement prématuré du travail, d'avortement spontané et d'avortement septique.

- Signes/ Symptômes éventuels :
 - Retard ou absence de règles
 - D'autres signes/ symptômes de grossesse
 - Fils introuvables
 - Fils plus courts ou plus longs que ce à quoi on s'attend

Gestion

- Confirmez qu'il s'agit d'une grossesse et identifiez le trimestre. Si la femme se trouve dans le deuxième ou troisième trimestre de sa grossesse, gérez selon les directives nationales/ protocoles locaux et référez-la si nécessaire à un prestataire approprié.
- Déterminez qu'il ne s'agit pas d'une grossesse ectopique : douleur violente/ lancinante qui est souvent unilatérale ; saignement vaginal anormal ; sensation d'ébriété/ étourdissement ; évanouissement. Si vous suspectez une grossesse ectopique, référez immédiatement/ transportez la femme dans une structure de santé avec antenne chirurgicale
- Si une grossesse ectopique a été écartée, et si la grossesse est au premier trimestre :

- Conseillez la femme sur les avantages et les risques d'un retrait immédiat du DIU : le retrait du DIU augmente légèrement le risque de fausse couche ; et laisser le DIU en place peut provoquer une fausse couche au deuxième trimestre de la grossesse, une infection et un accouchement avant terme.
 - Si la femme demande le retrait, procédez immédiatement au retrait si les fils sont visibles et si la grossesse est au premier trimestre. Si les fils ne sont pas visibles, faites une échographie pour savoir si le DIU se trouve toujours dans l'utérus ou a été expulsé. Si le DIU est toujours en place, il ne peut pas être retiré en toute sécurité ; suivez les conseils ci-dessous pour retirer le DIU à l'accouchement.
 - Si la femme refuse le retrait, offrez-lui de l'assistance et des soins conformément aux directives nationales/ protocoles locaux et arrangez une visite de suivi de la grossesse par un prestataire qualifié à une date rapprochée. Souligner l'importance de retourner à la clinique immédiatement si la femme présente des signes d'avortement spontané ou d'infection (exemple, fièvre, douleurs dans le bas-ventre, et/ ou saignements) ou d'autres signes d'avertissement. Prévoyez de retirer le DIU lors de l'accouchement.
- Perforation utérine : Il n'a pas été rapporté de cas de perforation de la paroi utérine pendant l'insertion du DIUPP.
 - Infection : Le risque de survenue d'une infection génitale haute parmi les utilisatrices du DIU est de moins de 1%. Ce risque minimal est plus élevé au cours des 20 premiers jours après l'insertion. Après, le risque d'infection parmi les utilisatrices du DIU semble être comparable à celui des non utilisatrices du DIU.
 - Expulsion : Les taux d'expulsion spontanée du DIU suite à une insertion post partum semblent être plus élevés que les taux d'expulsion après des insertions d'intervalle et des insertions qui ne sont pas consécutives à une grossesse.

8. Gestion des services liés au DIUPP

Toute structure de santé offrant des soins obstétricaux de base peut offrir le DIU en post partum aux femmes. Il est recommandé que les DIU soient offerts en post partum par un prestataire de santé (sage-femme, infirmier (ière), médecin) formé en compétences de prestations des services liés au DIUPP.

a. Critères de prestation de services

Les critères minimum pour une prestation sécurisée des services de DIUPP incluent :

- **Infrastructure** : un service de consultations prénatales (CPN), une salle d'accouchement, une salle de suites de couches si possible , un service de consultations post natale (CPoN).
- **Matériels** : une table d'accouchement ou d'examen munie d'étriers (ou d'un endroit où la femme peut poser ses pieds) ; les instruments pour l'insertion (on spéculum Sims, une pince placentaire Kelly ; des serviettes stériles, des gants stériles ou d'examen propres (y compris de longs gants si l'on prévoit de procéder par une technique d'insertion manuelle) ; une solution antiseptique et des DIU dans leurs emballages stériles).
- **Personnel** : un prestataire de santé (e sage-femme, un médecin infirmier/ ière) formé .
- **Coordination des soins** : un système de communication et de partage d'informations devrait être mis en place entre le service de CPN, la salle d'accouchement, les suites de couches, le service de CPoN, le service de PF, le service de pesée et le service de vaccination.
- **Systèmes de gestion** : Il doit y avoir une bonne intégration de tous les éléments cités ci-dessus de sorte à ce que les services soient offerts d'une manière garantissant un bon counseling, de bonnes pratiques de prévention des infections, et un bon suivi.

b. Standards de performance pour les services de DIUPP

Ces standards sont destinés à servir comme un guide pour la mise en place et le fonctionnement de services de DIUPP de haute qualité. L'atteinte de chaque standard de performance peut être vérifiée grâce la liste de vérification. (voir Annexe D)

Les standards servent de guide aussi bien pour les prestataires de services que pour les superviseurs. Les prestataires de services peuvent utiliser l'outil comme un guide de vérification de leurs propres performances cliniques. Il peut être utilisé comme un support de travail relatif aux étapes du counseling ou à la technique d'insertion. Les prestataires peuvent également l'utiliser comme un moyen d'orienter d'autres collègues qui sont en train de développer les compétences nécessaires pour la prestation de services. Les superviseurs peuvent utiliser l'outil comme un moyen spécifique et détaillé pour assurer une supervision des services de DIUPP. Ceci peut leur permettre d'offrir un feedback spécifique aux prestataires et aux gestionnaires sur ce qui est fait de manière adéquate et les domaines auxquels il faudrait accorder une plus grande attention.

L'évaluation séquentielle des performances comparée aux standards permet aux gestionnaires de programmes et aux autorités départementales/ étatiques de suivre la qualité des services au fil du temps et de pouvoir comparer les performances des structures de santé d'une manière quantifiable.

Tableau 9.1 Standards de performance pour les services relatifs au DIUPP

Evaluation initiale de la cliente et counseling pendant les soins prénataux ; visites ultérieures

1. Le prestataire utilise les techniques de counseling recommandées.
2. Le prestataire/ conseiller donne des informations sur les avantages liés à l'espacement des grossesses et évalue les connaissances de la femme sur les méthodes de planification familiale.
3. Le prestataire/ conseiller donne des informations spécifiques à la femme en tenant compte de son intérêt et de ses besoins, si la femme a une méthode/ ou plusieurs méthodes à l'esprit.
4. Le prestataire procède à une petite évaluation en vue de savoir quelle est l'éligibilité de la femme et détermine si le DIU est une méthode appropriée pour cette femme.
5. Le prestataire donne des informations spécifiques sur la méthode du DIU.
6. Le prestataire fait une notation qui prévient les autres prestataires de soins, que la femme a choisi l'insertion du DIU dans le post partum.
7. Le prestataire donne et explique le calendrier de suivi comme il se doit.
8. Le prestataire identifie les femmes qui ont des problèmes et gère les complications, si besoin est.

Counseling sur le DIU et l'évaluation de la cliente pendant le travail ou la période post partum

1. Le prestataire consulte le dossier de la cliente pour s'assurer qu'elle est une candidate appropriée à l'insertion du DIUPP
2. Le prestataire prépare la parturiente pour l'insertion du DIUPP.

Prestation des services relatifs au DIU

1. Le prestataire se prépare à la procédure d'insertion du DIU dans le Post Partum
2. Le prestataire exécute toutes les tâches pré insertion pour l'insertion post placentaire ou per césarienne du DIU.
3. Le prestataire effectue l'insertion dans le post partum immédiat ou en per césarienne.
4. Le prestataire effectue les tâches post-insertion
5. Le prestataire effectue le counseling post-insertion

c. Gestion et enregistrement des données

1. Le prestataire enregistre les données pertinentes concernant les services offerts sur le dossier de la patiente.
2. Le prestataire enregistre les données pertinentes concernant les services offerts dans le registre.
3. La structure de santé dispose des matériels et des documents adéquats pour la planification familiale post partum.
4. Le prestataire possède les qualifications requises.

➤ Enregistrement des données

Il est extrêmement important de conserver minutieusement les données des services de DIUPP. Ceci est dû au fait que les critères de sélection des clientes et la technique d'insertion sont directement liés au taux d'expulsion, et par conséquent, potentiellement au succès du service de DIUPP dans son ensemble. S'il se trouve qu'un nombre plus élevé de clientes que celui auquel on s'attendait reviennent pour cause d'expulsions partielles ou totales du DIU, il peut être important de savoir quels étaient les critères d'évaluation qui avaient été utilisés au moment de l'insertion, et si le prestataire avait été confronté à une quelconque difficulté au moment de l'insertion. Ceci permettrait aux gestionnaires de programmes et aux superviseurs de réviser la formation et les critères d'évaluation des clientes afin de déterminer si une modification devrait être faite.

Après l'insertion du DIU, une notation devrait être faite sur la fiche de la femme, ainsi que dans le registre d'accouchement et dans le registre des services de PF PP. De même, lorsque la femme

revient pour la visite de suivi, s'il y a un quelconque problème, le registre de PF PP devrait être consulté afin que l'on sache si certains facteurs auraient pu permettre de prédire ce problème.

Un exemple de fiche de collecte des données est joint à l'annexe E.

Le registre des services de PF PP peut comporter entre autres titres possibles, les éléments suivants :

- Date d'insertion du DIU
- Numéro d'enregistrement
- Nom
- Numéro de contact
- Age
- Parité
- Moment d'insertion du DIU : post placentaire, postpartum, per césarienne
- Age gestationnel à l'accouchement : 21–32 semaines, 33–36 semaines, 37–41 semaines
- Durée de la rupture des membranes : < 6 heures, 6–12 heures, > 12 heure
- Instrument utilisé pour l'insertion (pince placentaire Kelly, autre type de pince) ou DIU à long inserteur
- Moment du counseling : prénatal, début du travail, postpartum
- Avis du prestataire par rapport à la facilité de l'insertion : (échelle 1–10)
- Avis de la patiente : anxiété (échelle 1–10) et douleur (échelle 1–10)

CONTRACEPTION CHIRURGICALE VOLONTAIRE (CCV)

PREREQUIS :

L'étudiante doit avoir préalablement pris connaissance et/ou assimilé :

- Anatomie et la physiologie de l'appareil génital féminin et masculin,
- Counseling (cf Support pédagogique de PF/GL2019)
- Contraception Chirurgicale Volontaire

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître les éléments de prise en charge éducative et informative des couples relatifs Contraception Chirurgicale Volontaire (CCV)

ENONCES DE RESULTATS

6. Décrire correctement la Contraception Chirurgicale Volontaire
7. Expliquer selon le cours le principe du consentement écrit et volontaire du client
8. Identifier tous les critères d'éligibilité de la CCV
9. Enumérer les instructions à donner aux couples accepteurs de la C.C.V.
10. Enoncer les éléments du suivi en cas de CCV

I. DESCRIPTION DE LA CCV

1.1. Définition

LA CCV est une intervention chirurgicale qui met fin de façon définitive et irréversible à toute possibilité de reproduction sexuée sans toutefois troubler la sexualité et perturber la fonction hormonale.

1.2. Différents Types

Chez la femme : la ligature des trompes	Chez l'homme : la vasectomie
Elle consiste à sectionner ou pratiquer l'occlusion des trompes de Fallope (conduits par lesquels passent les ovules jusqu'à l'utérus) ou à y insérer des micro-inserts Essure.	Elle consiste à sectionner ou à pratiquer l'occlusion des canaux déférents (conduits par lesquels passent les spermatozoïdes).
	

1.3. Bénéficiaires

- Grandes multipares ;
- Couples ne désirant absolument plus d'enfants;
- Femmes ayant des antécédents médico-chirurgicaux ou obstétricaux contre indiquant la grossesse.

N.B : la CCV sera pratiquée sur présentation d'une fiche de consentement signée.

1.4. Avantages et limites

Avantages contraceptives	Limites
- Plus efficace que toute autre méthode de contraception - Peut être facile à pratiquer - Les risques de complication ne se présentent qu'une seule fois, contrairement aux risques continus que présentent d'autres méthodes de contraception. - Peut être faite à un moment choisi entre les grossesses, mais aussi pendant le post partum et après avortement chez la femme et à tout moment chez l'homme. - Peut être pratiquée en per césarienne, dans la première semaine suivant l'accouchement ou à partir de la 6^{ème} semaine du post-partum - Taux d'efficacité élevé 99,9%.	- Irréversible - Regret - Exige du personnel qualifié - N'est pas accepté dans toutes les cultures - Comporte des risques de complication (chirurgie) - Retard dans l'efficacité (méthodes complémentaires 3 premiers mois en cas de vasectomie) - Ne protège pas contre ITG et IST/SIDA.

II. PRINCIPE DU CONSENTEMENT ECRIT ET VOLONTAIRE

- Rencontrer les 2 partenaires ensemble :
 - ◆ Examiner de nouveau le choix du partenaire qui va être stérilisé
 - ◆ Conseiller le couple jusqu'à obtenir une décision ferme sans se sentir forcé
 - ◆ Prévoir des entretiens individuels
 - ◆ Tenir compte de la préférence de chacun des partenaires en privilégiant les motifs d'ordre médical
- Encourager les clients à s'exprimer en leur donnant l'occasion de poser toutes les questions qu'ils souhaitent et à formuler leurs craintes.
- Lors des entretiens, parler aux clients d'une manière compatible avec leurs origines, cultures, leurs langues et les informer clairement sur les thèmes:
 - ◆ Il existe d'autres méthodes temporaires de P.F.
 - ◆ Il s'agit d'une intervention chirurgicale
 - ◆ Risque de complication liée à l'anesthésie
 - ◆ Avantages de cette méthode
 - ◆ Risque minimum d'échec
 - ◆ Résultats sont permanents
 - ◆ Libre choix de la méthode
 - ◆ Peut retirer son consentement à tout moment avant l'intervention
 - ◆ Cette méthode ne protège pas contre ITG et IST/SIDA.

III. CRITERES D'ELIGIBILITE (voir chapitre critère médicaux d'éligibilité)

IV- INSTRUCTIONS A DONNER AUX COUPLES

Instructions communes
◆ Se reposer à la maison pour le reste de la journée ◆ Prendre correctement les médicaments prescrits ◆ Prendre soin de la plaie opératoire ◆ Expliquer les complications possibles et la conduite à tenir dans chaque cas ◆ Expliquer le moment de reprise des activités habituelles et des rapports sexuels ◆ Lui demander de revenir au centre de PF en cas de problèmes ◆ Lui indiquer le moment et le lieu de la visite de suivi.
En cas de vasectomie
◆ Laissez l'incision propre et sèche ◆ Peut prendre un bain après 24 heures sans noyer la plaie. Nettoyer la plaie avec de l'eau savonneuse après 3 jours ◆ Porter un soutien scrotal et garder le repos pendant 2 jours ◆ Prendre 2 comprimés de paracétamol en cas de douleurs ◆ Eviter les travaux pénibles pendant 3 jours ◆ Reprendre les relations sexuelles protégées (condom spermicide) pendant 3 mois après 2 à 3 jours ◆ Observer une période de 03 mois ou 20 éjaculations chez l'homme ◆ Conseiller l'utilisation d'une méthode complémentaire pendant cette période
En cas d'occlusion des trompes
◆ Veiller à ne pas mouiller le champ opératoire pendant 2 jours. ◆ Reprendre les activités normales progressivement. (Vous devriez pouvoir reprendre les activités normales dans les 7 jours qui suivent l'intervention chirurgicale.) ◆ Eviter d'avoir des rapports sexuels pendant 1 semaine. Après avoir repris les rapports, arrêter en présence de gêne et d'inconfort. ◆ Eviter de soulever des choses lourdes et de travailler dur pendant 1 semaine. ◆ Prendre 1 ou 2 sachets d'analgésique contre la douleur, toutes les 4 à 6 heures. (ACETAMINOPHENE, IBUPROFENE OU PARACETAMOL) ◆ Prendre rendez-vous pour une visite de suivi entre le 7^{ème} et le 14^{ème} jour après l'intervention chirurgicale. ◆ Revenir au service de PF après 1 semaine pour le retrait des fils non résorbables ou en cas de problèmes.
Informations générales
◆ Une douleur à l'épaule pendant les 12 - 24 heures après la paroscopie est relativement fréquente (gaz (CO₂) ou à la présence air sous le diaphragme, secondaire au pneumopéritoine). ◆ L'occlusion des trompes est efficace immédiatement après l'intervention chirurgicale. ◆ Les menstruations continueront comme d'habitude. (Si la femme utilisait une méthode hormonale avant la procédure, surtout des COC ou des CIC, la quantité et la durée des menstruations peuvent augmenter après l'intervention chirurgicale.) ◆ L'occlusion des trompes ne fournit pas de protection contre les ITG ou autres IST, y compris le virus du sida. Si l'un des partenaires est à risque, le couple devrait utiliser les condoms même après l'occlusion des trompes.

V. ELEMENTS DE SUIVI

5.1. Signes avertisseurs

Contactez un prestataire de services ou une clinique si vous notez un des problèmes suivants :

Ligature des trompes	Vasectomie
◆ Fièvre (plus élevée que 38°C) ◆ Vertiges ou évanouissement ◆ Douleur abdominale persistante ou plus prononcée ◆ Saignement ou liquide (pus) sortant de l'incision ◆ Signes ou symptômes de grossesse	◆ Fièvre >38°C ◆ Saignement ou liquide (pus) sortant de l'incision ◆ Scrotum enflammé ◆ Si partenaire n'a pas de menstruation

5.2. Calendrier de suivi

➤ Vasectomie:

- Revoir le client un mois après l'intervention pour l'examen de l'éjaculat
- Consulter en cas de fièvre, de saignement au niveau des cicatrices et de douleurs ou inflammation au niveau du scrotum dans le mois suivant l'intervention.

➤ Ligature des trompes :

- Contrôler après deux semaines pour vérifier les cicatrices,
- Consulter en cas de saignement au niveau des incisions, de douleurs abdominales sévères et fièvre.

RECAPITULATIF

1. Décrire la Contraception Chirurgicale Volontaire
2. Enumérer les bénéficiaires de la CCV en Côte d'Ivoire
3. Expliquer le principe du consentement écrit et volontaire du client
4. Enumérer les avantages et les limites de la C.C.V.
5. Appliquer les critères d'éligibilité de la C.C.V.
6. Citer les signes avertisseurs dans les deux cas de CCV
7. Enumérer les instructions à donner aux couples accepteurs de la C.C.V.

PREREQUIS :

Avant d'assister à ce cours, l'étudiante doit avoir lu et/ou assimilé le contenu des chapitres suivants :

- Méthodes contraceptives
- Santé sexuelle et reproductive des adolescents/approche genre
- Santé des femmes
- Critères médicaux d'éligibilité
- Contraception du post partum /post abortum (cf cours de PF et gestion logistique des produits de SR.2018)

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les situations particulières de prescription des méthodes contraceptives.

ENONCES DE RESULTATS

1. Expliquer les différentes conditions et situations particulières
2. Décrire la prise en charge d'une cliente en situation d'urgence de façon appropriée
3. Décrire la prise en charge des adolescents de manière adéquate
4. Décrire correctement la prise en charge des femmes du post-partum
5. Décrire correctement la prise en charge des femmes du post-abortum
6. Décrire correctement la prise en charge des femmes de plus de 35ans
7. Décrire sans se tromper la prise en charge de personnes vivantes avec leVIH.
8. Décrire correctement la prise en charge des personnes réfugiées, déplacées ou à risque environnemental.

I. LA CONTRACEPTION DES ADOLESCENTS

1.1. Définition de l'adolescence

L'adolescence appelée aussi puberté est la période entre l'enfance et l'âge adulte, période où le corps subit de remarquables changements hormonaux et physiques.

Elle commence à l'âge de 9 ou 10 ans chez les filles et 10 ans ou plus chez les garçons.

La plupart des changements se poursuivent jusqu'à l'âge de 16 ans -19 ans.

1.2. Counseling chez les adolescents

Les adolescents sexuellement actifs ont besoin d'une contraception sûre et efficace. Ils tendent à avoir des styles de vie imprévisibles centrés sur l'assertion de leur indépendance, la facilité et l'acceptation de leur camarade.

Leurs relations peuvent être temporaires et ils peuvent souvent avoir de multiples partenaires sexuels.

Par conséquent, ils sont exposés à un risque considérable de contracter des infections du tractus génital et autres IST (HBV, VIH/SIDA).

Souvent les adolescents n'utilisent pas des méthodes contraceptives efficaces.

Et ceux qui le font ont tendance à les utiliser irrégulièrement ou incorrectement. Cela entraîne souvent une grossesse précoce associée à une mauvaise santé tant chez les jeunes mères que leurs bébés.

Les adolescents ont besoin d'accès à la planification familiale quel que soit leur situation matrimoniale, et les services pour les adolescents devraient éviter les procédures cliniques inutiles pouvant les décourager à venir consulter.

Considérant tous ces éléments, le counseling devrait apporter des informations positives aux adolescents afin de leur faciliter l'accès aux services de contraception.

Le prestataire doit par conséquent :

- Créer un terrain de confiance entre lui et l'adolescent en insistant sur le caractère privé et confidentiel de l'entretien.
- Expliquer à l'adolescent que la contraception permet de prévenir les grossesses non désirées et les IST/VIH/SIDA (préservatifs)

1.3. Méthodes contraceptives spécifiques pour les adolescents

- Abstinence+++
- Préservatifs masculin et féminin+++
- Contraceptifs oraux combinés (COC)++
- Contraceptifs oraux progestatifs (COP)++
- Les injectables++
- Les implants++
- Contraception d'urgence+
- Le DIU (moins souhaitable) + Les méthodes d'auto-observation+

Sur le plan médical, les adolescentes sont en général éligibles pour l'utilisation de toutes les méthodes de contraception efficaces et réversibles, ainsi que pour la contraception d'urgence.

Le suivi de la contraception chez les adolescents se fera en général selon la méthode choisie.

Mais les prestataires sont appelés à être encore plus attentifs vis-à-vis des adolescents.

Les adolescentes et les jeunes filles ne doivent pas être sujettes aux préjugés. Elles sont éligibles à toutes les méthodes contraceptives tout en respectant les critères médicaux d'éligibilités

II. CONTRACEPTION D'URGENCE

2.1. Définition de la contraception d'urgence

La contraception d'urgence est l'administration d'une méthode contraceptive suite à un rapport sexuel non protégé à une période du cycle où le risque de survenue d'une grossesse non désirée est élevé.

La contraception d'urgence est aussi appelée contraception post-coïtale.

Par le passé ces méthodes étaient appelées pilule du lendemain en ce qui concerne la contraception orale d'urgence.

Actuellement, il existe deux types de contraceptifs d'urgence :

- Les contraceptifs mécaniques
- Les contraceptifs chimiques

2.2. Méthodes contraceptives recommandées

- ♦ **Mécaniques** :DIU
- ♦ **Chimiques** : COP,COC
- ♦ **Œstrogène**

CONDITIONS D'ADMINISTRATION

PRODUIT	DOSAGE	PERIODE D'ADMINISTRATION	EFFICACITE	INCONVENIENTS
COC : Faiblement dosé	4 cp 1ère H 4 cp 12 H Après	Avant 72 H suivant le rapport sexuel	Très efficace 98 %	Nausées, vomissements, sensibilité des seins
Normo dosées	2 cp 1ère H 2 cp 12 H après	IDEM	IDEM	IDEM
COP : Ovrette	20 cp 1ère H 20 cp 12 H Après	48 H suivant le rapport sexuel	96 %	Moins prononcés que ceux des COC
Œstrogène E.C	5 mg/j pendant 5J	Dans les 72 H heures après le rapport sexuel Non protégé	99 %	Nausées, vomissements, perturbation du cycle
- Postinor ou Pregnon - Norlevo (Levonorgestrel)	- 2cp prise unique 1cp prise unique	Dans les 72 H après le rapport sexuel non Protégé	99%	Perturbation du cycle en cours
L'acétate d'ulipristal (UPA)	1cp prise Unique	Dans les 120 H après le rapport sexuel non protégés (5 jours)	Est d'autant plus efficace qu'elle est prise tôt après le rapport sexuel non ou mal protégé. 95% d'efficacité en cas d'utilisation dans les 24 heures (1er jour) 85% d'efficacité en cas d'utilisation entre la 24 ^{ème} et la 48 ^{ème} Heure	nausées, douleurs abdominales, gêne abdominale, vomissements, maux de tête, sensations
D.I.U	-----	Dans les 5 jours suivant les rapports sexuels	Posé très tôt très efficace	-----

NB :

- Prendre la 1ère dose de préférence le soir au coucher. En cas de vomissements dans les 2 heures suivant la prise de la première ou de la deuxième dose, la cliente peut répéter la dose.
- Une contraception d'urgence ne peut être utilisée de façon abusive, à cause de ses effets secondaires;conseillertoujours laclienteaadopteruneméthodecontraceptiv erégulière.

• Contraception d'urgence

Conditions	COC	Levonorgestrel (LNG)	ulipristalacetate (UPA)	DIU
Allaitement maternel	Sans danger (Catégorie =1)	Sans danger (Catégorie =1)	(Catégorie = 2)	à partir de la 4 ^{ème} semaine

En absence d'allaitement	Sans danger	Sans danger	Sans danger	Ne peut être posé qu'à partir de la 4 ^{ème} semaine
--------------------------	-------------	-------------	-------------	--

III. CONTRACEPTION DU POST- PARTUM

3.1 Définition du post-partum

C'est la période durant laquelle l'organisme maternel, modifié par la grossesse, subit des changements destinés à le ramener à l'état antérieur.

- ◆ Elle débute deux (2h) heures après la délivrance,
- ◆ Sa durée varie selon le mode d'allaitement et s'étend sur environ six (6) semaines après l'accouchement.
- ◆ Elle se termine par le retour de la menstruation sauf dans les cas d'aménorrhée physiologiques des nourrices.

On distingue quatre (4) périodes dans le post-partum :

- **Post-placentaire** : Dans les dix (10) minutes qui suivent l'expulsion du placenta ;
 - **Post-partum immédiat** : dans les 48 heures qui suivent l'accouchement ;
 - **Post-partum tardif** : de 48 heures à 6 semaines après l'accouchement;
 - **Post-partum prolongé** : de 6 semaines à un an après l'accouchement;
- **La planification familiale du post-partum** : est la prévention des grossesses non désirées, trop rapprochées et trop nombreuses, durant les douze (12) premiers mois qui suivent l'accouchement.
- **La contraception du post-partum** : est l'initiation et l'utilisation des méthodes de PF durant les douze (12) premiers mois qui suivent l'accouchement.

3.2 Importance de la contraception dans le post-partum

- ✓ Selon une analyse des données provenant d'EDS de 27 pays : 95 % des femmes durant les 12 premiers mois qui suivent un accouchement veulent éviter une grossesse dans les 24 mois suivants, mais 70 % d'entre elles n'ont pas recours à la contraception (*Ross & Winfrey, 2001*).
- ✓ Avantages considérables pour la mère et pour l'enfant : un intervalle de 24 mois entre une naissance vivante et le début d'une prochaine grossesse (recommandations de l'OMS) peut permettre d'éviter
 - 10% des décès d'enfants de moins de 1 an
 - 21% des décès d'enfants de 1-4 ans
- ✓ Risques liés aux grossesses rapprochées

Plusieurs études réalisées dans le monde ont montré que les risques liées aux grossesses rapprochées sont particulièrement élevés pour les femmes qui tombent enceintes très peu de temps après une grossesse précédente, une fausse couche ou un avortement (Voir Tableau 1.1 pour un résumé des résultats de recherches).

- Un **bébé** né après un intervalle court entre les accouchements est exposé à un risque accru de:
 - naître avant terme ;
 - avoir un poids en dessous de la normale à la naissance ;
 - être trop petit par rapport à l'âge gestationnel ;
 - décès néonatal ou infantile.

- Une **femme** qui tombe enceinte trop peu de temps après une fausse couche ou un avortement provoqué court des risques accrus de:
 - anémie ;
 - rupture Prématurée des Membranes ;
 - avortement ;
 - hémorragies ;
 - fausse couche ;
 - mortalité maternelle.
- Une **grossesse précoce** (lorsque la mère a moins de 18 ans) s'accompagne d'un risque accru de complications sanitaires pour les mères et les nouveau-nés comparé à des femmes dont l'âge est compris entre 20 et 24 ans. Les mères adolescentes dont l'âge est compris entre 15 et 19 ans courent deux (2) fois plus le risque de mourir pendant la grossesse ou l'accouchement que les mères qui ont plus de 20 ans ; les filles de moins de 15 ans courent un risque cinq (5) fois plus élevé.

3.3. Caractéristiques de la contraception dans le PP

Retour à la fécondité :

- **Femme non allaitante**
 - Retour des menstruations dans les 6 semaines;
 - Première ovulation dans une moyenne de 45 jours après l'accouchement;
 - 2 femmes sur 3 vont ovuler avant de revoir les règles ;
 - Risque de survenue d'une grossesse à partir de vingt et un (21) jours;
- **Femme allaitante**
 - ◆ Période d'infertilité plus longue chez les femmes qui allaitent exclusivement;
 - ◆ Probabilité d'avoir les règles et d'ovuler les six (6) premiers mois faibles;
 - ◆ Après six (6) mois, l'enfant reçoit des compléments alimentaires et le nombre de tétées diminue.

3.4. Méthodes contraceptives utilisables dans le PP

- **En cas d'allaitement**

Méthodes non hormonales :	Méthodes hormonales :
- La contraception locale /Méthodes barrières (préservatifs, spermicides); - La Méthode d'allaitement Maternel et d'Aménorrhée MAMA); - Le dispositif intra-utérin (stérilet) : DIU au cuivre.	- La contraception orale : pilule progestative - Le DIU hormonal ; - L'implant contraceptif; - Injectables à seul progestatif (CISP).

- **En absence d'allaitement**

Méthodes non hormonales :	Méthodes hormonales :
---------------------------	-----------------------

- La contraception locale/Méthodes barrières (préservatifs); - Le dispositif intra-utérin (stérilet) : DIU au cuivre ;	- La contraception orale : pilule progestative et œstro-progestative micro dosée en éthynil (EE); - Le stérilet : DIU hormonal au progestatif; - L'implant progestatif ; - Injectables à seul progestatif (CISP); - Injectables œstroprogestatifs(CIC).
---	---

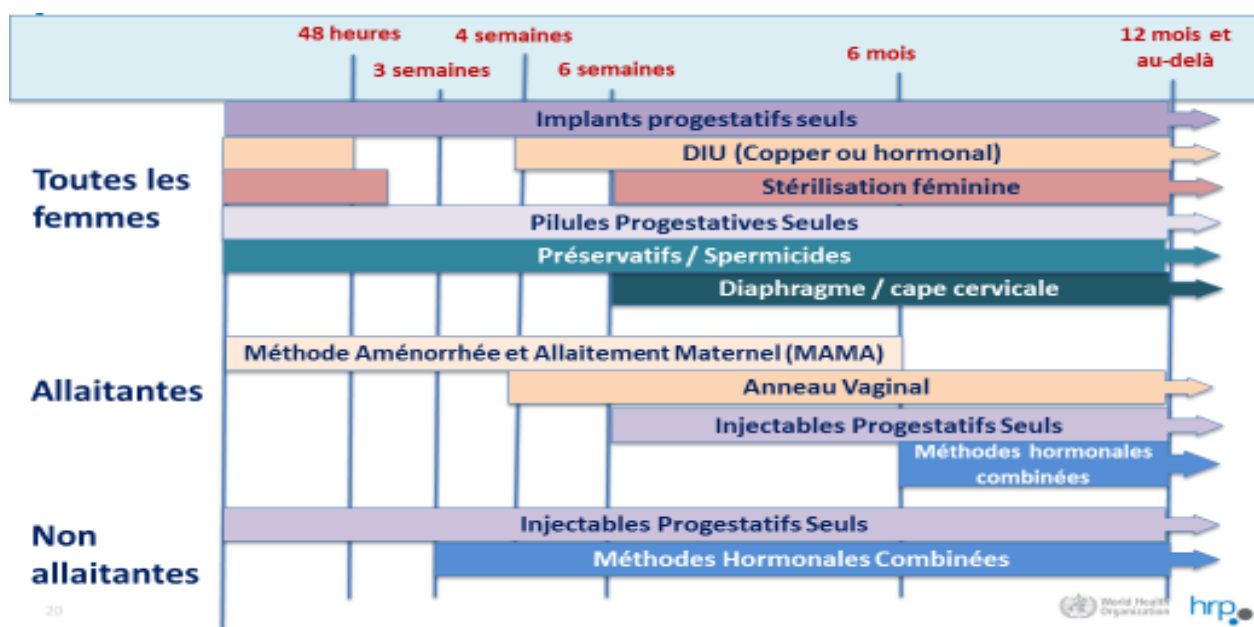
3.5. Critères d'éligibilité appliqués aux méthodes contraceptives du post partum

ETAT	Sous état	CHC				CHP			DIU	
		COC	PATCH	AIVC	CIC	COP	CIP DPMA- NET	Implant LNG- ETO	DIUcu	DIULNG
Grossesse		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	so	so
Allaitement au sein	< 48 h	4	4	4	4	2	3	2	1	2
	≥ 48 h à < 4 semaines	4	4	4	4	2	3	2	3	3
	≥ 4 semaines à < 6 semaines	4	4	4	4	2	3	3	1	1
	≥ 6 semaines à < 6 mois	3	3	3	3	1	1	1	1	1
Post-partum et femmes non allaitantes TEV	< 21 jours	3a	3a	3a	3a	1	1	1	1	1
	< 21 jours sans autres facteurs de risque TEV	3a	3a	3a	3a	1	1	1	1	1
	< 21 jours avec autres facteurs de risque TEV	4a	4a	4a	4a	1	1	1	1	1
	De 21 à 42 jours sans autres facteurs de risque TEV	2a	2a	2a	2a	1	1	1	1	1
	De 21 à 42 jours avec autres facteurs de risque TEV	3a	3a	3a	3a	1	1	1	1	1
	> 42 jours	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Adapté des Critères de recevabilité médicale pour l'adoption et l'utilisation continue de méthodes contraceptives. de l'OMS — 2016 : fiche de consultation rapide pour les catégories 3 et 4 FHI 360, octobre 2016										

Adapté des Critères de recevabilité médicale pour l'adoption et l'utilisation continue de méthodes contraceptives. de l'OMS — 2016 : fiche de consultation rapide pour les catégories 3 et 4 FHI 360, octobre 2016

SO Sans Objet : les femmes enceintes n'ont pas besoin de contraception. Si ces méthodes sont adoptées accidentellement, aucun dommage ne résultera.

Tableau récapitulatif des critères d'éligibilité des méthodes contraceptives dans le post partum



IV. PLANIFICATION DU POST ABORTUM

4.1. Définitions

➤ **Avortement :**

Selon l'OMS, l'avortement est une interruption de la grossesse avant 22^{ème} Semaines d'âge gestationnel. L'avortement peut être spontané (fausse couche) ou induit (provoqué) sous forme d'interruption volontaire de grossesse (IVG) ou d'avortement à risque (dans la clandestinité)

En Côte d'Ivoire, l'avortement est l'expulsion spontanée ou provoquée de l'embryon ou du fœtus avant la date de sa viabilité c'est-à-dire avant la 28^{ème} semaine d'aménorrhée.

➤ **Post Abortum:** C'est la période qui suit un avortement, c'est-à-dire l'expulsion du produit de conception avant la 22^{ème} semaine d'âge gestationnel.

4.2. Counseling et offre de services en PF (Voir chapitre counseling)

- Référer vers les autres services (si nécessaire). Liens avec les autres services de SR
Exemples : Traitement des infections du tractus génital (ITG)
 - Dépistage du cancer du col de l'utérus
 - Services d'infertilité
 - Conseils avant la grossesse (par ex : nutrition, vaccination, prise en charge d'autres problèmes de santé existants)
- Donner un rendez-vous

- **Première consultation** : Deux semaines après la prise en charge.

- ♦ Recherche de signes de complication (douleur, saignement, fièvre, anémie...),
- ♦ Vérifier l'utilisation de la contraception,

- **Deuxième consultation** : Six (06) semaines après la prise en charge,

- ♦ Rechercher les plaintes éventuelles,
- ♦ Vérifier le retour de couches,
- ♦ Vérifier la prise et la tolérance de la contraception.

4.3. Importance de la contraception en PA

Chez les femmes ayant subi un avortement, la fécondité se rétablit rapidement, parfois 14 jours seulement après l'intervention.

La planification familiale est une composante essentielle des soins de qualité pendant le postabortum. Les services de planification familiale offerts en post-abortum peuvent contribuer à réduire le nombre de grossesses non désirées et d'avortements à risque, et, en conséquence, celui des décès maternels.

4.4. Principes et caractéristiques de la contraception en PA

➤ Principes de la contraception en post-abortum

Quel que soit le type d'avortement, une période de repos de 6 mois devrait être observée avant de contracter une nouvelle grossesse.

➤ Caractéristiques de la contraception en post-abortum

Il est pertinent de tenir compte des situations spécifiques des clientes comme suit :

- **Avortement spontané**

- S'il existe un désir de grossesse, ne pas prescrire de contraception définitive ou les injectables. Toutes les méthodes de contraception peuvent être utilisées.
- S'il n'existe pas de désir de grossesse, toutes les méthodes de contraception peuvent être utilisées.

N.B. : Quel que soit la situation, le D.I.U. sera proposé en absence absolue d'infection de la filière génitale.

- **Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)**

En cas d'IVG ou d'interruption thérapeutique de grossesse, s'il existe un désir de grossesse ne pas prescrire de contraception définitive.

Toutes les autres méthodes de contraception peuvent être utilisées. Le D.I.U. sera proposé en absence absolue d'infections de la filière génitale.

4.5. Méthodes de contraception utilisables dans le post-abortum

Avortement	1 ^{er} Trimestre	2 ^{ème} Trimestre
Spontané	* Pilule combinée * D.I.U. * Pilule progestative * injectable ○ Implant ○ Préservatif ○ Spermicide ○ Contraception ○ Chirurgicale Volontaire (CCV – Anneaux– Patch-	*pilule combinée * Pilule Progestative * injectable * Préservatif * spermicide □ Implant □ Préservatif □ CCV
IVG /ITG	* D.I.U. * injectable *Pilule ○ □ Implant ○ □ Préservatif ○ □ Spermicide ○ □ CCV	* injectable *Pilule □ Implant □ Préservatif □ Spermicide □ CCV

Choix de la méthode contraceptive en post- abortum selon la technique utilisée pour l'évacuation utérine :

V. CONTRACEPTION CHEZ LES FEMMES DE PLUS DE 35 ANS

5.1. Besoins de femmes de plus de 35ans

Les femmes de plus de 35 ans ont besoin d'une contraception sûre et efficace car elles ont des risques accrus de santé (morbidité et mortalité) si elles tombent enceintes.

Dans le passé, avec la dose élevée d'œstrogène des COC ($\geq 50 \mu\text{g EE}$: Ethinyl-Estradiol) les femmes de plus de 35 ans couraient un risque accru de graves complications (attaques cardiaques, attaques d'apoplexie et problèmes de coagulation sanguine).

Mais de nos jours les nouveaux COC à faibles dose ($30 - 35 \mu\text{g EE}$) ou les CIC, indiquent que les femmes plus âgées peuvent maintenant utiliser toutes les méthodes sans risques jusqu'au moment de la ménopause si elles n'ont pas d'autres facteurs de risques.

Le prestataire est appelé à accorder une attention particulière à leur suivi.

5.2. Les différents problèmes de santé chez les femmes de plus de 35ans

- Troubles de la circulation (HTA-Thrombophlébite etc.)
- Prolapsus /Ostéoporose
- Cancer de l'appareil génital et du sein
- Tabagisme
- Diabète
- Obésité

5.3. Les méthodes contraceptives appropriées

- Méthodes d'Auto-Observation
- Méthodes-Barrières
- DIU
- COP
- Injectables
- Implants
- CCV

VI. CONTRACEPTION CHEZ LES PERSONNES REFUGIEES, DEPLACEES ET A RISQUE ENVIRONNEMENTAL

6.1. Problèmes et besoins en santé de la Reproduction des personnes réfugiées, déplacées

La notion de base est que les services concernant la santé de la reproduction pour les populations déplacées sont difficiles à réaliser compte tenu du contexte environnemental et psychologique.

Les populations sont certes confrontées à des besoins d'urgence pour leur survie (eau potable, aliments, abri etc.) ; mais il ne faut pas perdre de vue leurs besoins en santé tels que :

- Soins prénatals et accouchement
- Planification familiale
- Protection contre les IST/VIH/sida
- Protection contre les violences sexuelles

6.2. Prise en charge de la contraception

Ces considérations amènent à assurer une prise en charge spécifique en matière de contraception. Cette prise en charge doit s'inscrire dans le paquet minimum des services en santé de la reproduction. Elle se fera en fonction des modules réels :

- La contraception d'urgence sera prescrite en cas de viol complétée d'une assistance psycho-sociale
- La contraception sera prescrite de manière appropriée
- Les schémas d'application seront les mêmes que dans les autres situations particulières; mais un accent sera mis sur les aspects psycho-sociaux (counseling spécifiques)

VII. CONTRACEPTION ET PERSONNES VIVANTS AVEC LE VIH/Sida

Chez une femme séropositive pour le VIH, les conséquences d'une grossesse sont souvent graves. Si elle ne reçoit aucun traitement, le risque de transmission du virus au nouveau-né est de l'ordre de 30%. Et un grand nombre d'enfants ainsi contaminés sont plus tard atteints du sida et en meurent. Malgré ce risque, certaines femmes séropositives veulent avoir un enfant. D'autres au contraire optent pour la contraception.

Le prestataire doit aider la femme infectée par le VIH à décider de l'opportunité d'envisager ou non une grossesse.

Selon l'option de la femme, le prestataire doit l'éclairer et l'informer sur son choix et les moyens disponibles en PF.

7.1. Lien entre la prévention du VIH et les programmes de santé en matière de reproduction

Les services de santé en matière de reproduction peuvent aider à prévenir la transmission du VIH par les moyens suivants :

- Faire connaître les risques de manière à influencer sur le comportement sexuel ;
- Déceler et gérer les infections sexuellement transmissibles (IST);
- Promouvoir l'utilisation correcte et régulière de préservatifs ;
- Aider à prévenir la transmission mère-enfant.

En mettant en relation la prévention du VIH et les préventions et traitement des IST avec les services de planification familiale et de santé maternelle, on peut accroître leur couverture, limiter la stigmatisation et réaliser des économies en utilisant les ressources et l'infrastructure existantes.

7.2. Avantages de la PF/VIH/sida

- Possibilité de décider de l'opportunité d'envisager ou non une grossesse
- Possibilité de limiter ses naissances
- Avoir une vie sexuelle normale avec des rapports sexuels protégés
- Protection contre les IST et une ré- infection au VIH.
- Protection du partenaire contre les IST /VIH/Sida.

Options contraceptives

Les femmes séropositives doivent savoir que, outre l'abstinence, les préservatifs offrent la meilleure protection contre les IST. Elles devraient recourir au préservatif masculin ou féminin à chaque rapport sexuel.

Il faut apprendre aux clientes séropositives le mode d'emploi des préservatifs et les moyens de négocier cet emploi avec leurs partenaires.

Si une femme séropositive veut éviter une grossesse, elle devrait considérer une double méthode : le préservatif en prévention anti-infectieuse et un autre contraceptif plus efficace dans un but anticonceptionnel.

Pour les clientes séropositives ne souhaitant pas avoir d'enfant, la stérilisation féminine est une bonne option.

En prévention des grossesses, les contraceptifs hormonaux sont en général plus efficaces que les méthodes de barrière. On peut cependant craindre que plus l'efficacité du contraceptif adopté par une femme séropositive sera grande, plus l'emploi du préservatif par ses partenaires sexuels sera irrégulier. Les médicaments anti rétroviraux peuvent limiter l'efficacité des contraceptifs oraux, ce qui oblige l'adaptation de leur posologie ou la sélection d'une autre méthode.

7.3. Chez les femmes vivant avec le VIH/SIDA (Cas du DIU)

A l'exception du DIU, les autres méthodes contraceptives peuvent être utilisées sans risques majeurs. Les DIU n'offrent aucune protection contre les IST/VIH. En cas de risque, l'usage correct et régulier du préservatif est recommandé (double protection)

On peut poser sans risque le DIU à des femmes exposées au risque de contracter le VIH ou qui sont infectées par le VIH

On peut poser le DIU sans risque à des femmes qui ont le SIDA, qui suivent un traitement (ARV) et qui sont bien portant au point de vue clinique (stade 1 ou 2 de l'OMS)

Ne pas poser un DIU chez les femmes porteuses du VIH et qui sont au stade 3 ou 4 de la maladie selon l'OMS

Chez les femmes porteuses du VIH et ayant déjà un DIU en place, il n'est pas indiqué de l'enlever même si elle est au stade 3 ou 4 de l'OMS

Les femmes ayant le SIDA et qui portent un DIU doivent être suivies pour détecter des maladies inflammatoires pelviennes.

CONCLUSION

La prescription en matière de contraception dans les situations particulières et ou face à des conditions bio médicales particulières doit être de qualité et répondre de façon appropriée aux besoins des personnes. Il importe donc que les prestataires en soient conscients et aient les compétences nécessaires afin d'apporter leur aide de manière spécifique

RECAPITULATIF

Comment assurer la prise en charge :

- d'une cliente en situation d'urgence de façon appropriée
- des adolescents de manière adéquate
- des femmes de plus de 35ans
- de personnes vivantes avec le VIH.

ORGANISATION ET GESTION D'UN CENTRE DE PF

PREREQUIS

Avant d'assister à ce cours, l'étudiante doit avoir lu et assimilé le contenu du chapitre relatif à l'organisation et gestion d'un centre de PF (cf cours de planification familiale et gestion logistique des produits de santé de la reproduction. Version 2019)

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître le fonctionnement d'un centre de planification familiale.

ENONCES DE RESULTATS

1. Citer toutes les activités d'un centre de planning familial
2. Décrire tous les outils de travail en planning familial en spécifiant leur fonctionnement.

I- ACTIVITES D'UN CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE

1.1. Activités cliniques

- La sensibilisation, CCC, counseling
- La prestation des services cliniques
 - La lutte contre les IST et le VIH/SIDA
 - La lutte contre l'infertilité et l'infécondité
 - Choix éclairé pour les méthodes de contraception

1.2. Activités administratives

➤ La gestion du personnel

En zone rurale, les activités de prestation de services de planification familiale sont intégrées aux activités courantes de santé.

En zone urbaine il existe des cliniques de planification familiale, et le personnel ne dispensera que des activités de planification familiale. La clinique doit disposer du personnel suivant :

- Un médecin vacataire
- Deux prestataires qualifiés permanents (Infirmier(ère) ou Sage-femme)
- Un(e) éducateur (trice), assistant (e) social(e)
- Une aide-soignante.

La gestion du personnel du centre de planification familiale tourne autour des éléments suivants :

➤ Description du poste de travail

Elle consiste à déterminer ce que chacun doit faire dans l'organigramme. Elle sert aussi à déplacer les personnes selon leurs compétences.

➤ Calendrier des activités - répartition des tâches et permanences

Il indique toutes les activités des centres :

- A chaque activité correspond des tâches
- A chaque tâche est affecté périodiquement un agent en fonction de ses compétences et du personnel disponible.

Le calendrier doit être affiché et à la portée de tous.

➤ Planning des congés

Il comprend les noms et les périodes de congé de chacun et doit être affiché à la portée de tout le monde.

➤ Formation du personnel

Les agents formés en SR/PF sont chargés de la mise à niveau des autres membres de l'équipe en fonction de leurs tâches.

➤ Gestion du matériel, équipements, et contraceptifs (voir cours de gestion logistique)

II- LES OUTILS DE TRAVAIL EN PLANNING FAMILIAL OU INSTRUMENTS DE COLLECTE DES INFORMATIONS

Les programmes de planification familiale utilisent de manière générale les instruments de collecte de données suivants :

- La fiche individuelle ou dossier médical
- Le Registre Journalier des clients et des contraceptifs (Registre de consultation)
- Les fiches de Rapports Mensuels d'Activités
- L'échéancier
- La fiche de référence et contre référence
- La carte de rendez-vous
- Le carnet de commande
- La fiche de rapport mensuel

2.1. La fiche individuelle ou dossier médical

Il Permet de collecter les informations sûres:

- Les caractéristiques socioculturelles du client
- L'histoire génésique des clientes
- Le passé sanitaire et les résultats des examens médicaux
- Le choix et le changement des méthodes
- Les intentions de reproduction
- Les raisons de visites
- Le suivi des clientes (date de rendez-vous, type d'acte posé, etc...)

2.2. Le Registre Journalier des clients et des contraceptifs (Registre de consultation)

Il permet d'enregistrer les clients et les méthodes choisies et sert à tenir des comptes sur le nombre de clients venus à la consultation. C'est à dire le volume de consultation

- Date de la visite;
- Numéro du mois ;
- Numéro de la fiche (AC ou NC).

A la fin du mois, il sera donc aisé pour le prestataire d'obtenir les données suivantes :

- Nombre de femmes protégées (total et par méthode);
- Nombre de femmes perdues de vue;
- Nombre de femmes ayant abandonnées;

2.3. Les fiches de Rapports Mensuels d'Activités

- **Rapport sur les prestations IEC.** Il permet de collecter les informations sur:

- Les conférences
- Les causeries
- Les visites à domicile
- Les projections de film
- Les activités des Mass Média
- Le nombre de personnes touchées etc...

- **Rapport sur les prestations cliniques.** Il permet de collecter les informations sur:

- Le nombre de nouveaux utilisateurs par méthode contraceptive
- Le nombre d'utilisateurs par méthode contraceptive
- Le nombre de visites de contrôle
- Le nombre total d'utilisateurs
- La quantité de contraceptifs distribués par méthode

- **Rapport sur la Distribution à Base Communautaire (DBS).** Il permet de collecter les informations sur :
 - Le nombre de nouveaux utilisateurs par méthode contraceptive
 - Le nombre d'utilisateurs réapprovisionnés par méthode contraceptive
 - La quantité de contraceptifs distribués par méthode
 - Le nombre de clientes référées
- **Rapport sur les stocks de contraceptifs.** Il permet de collecter les informations sur :
 - Le stock de chaque méthode au début du mois
 - Les entrées et sorties pour chaque méthode
 - Le stock de chaque méthode à la fin du mois
- **Rapport sur la prise en charge des IST :**
 - Il permet de collecter les informations sur les cas des IST rencontrés, le traitement reçu et les références effectuées.

2.4. L'échéancier

Il peut être un classeur, une boîte, ou une armoire selon l'importance du centre. Il permet de classer la fiche de consultation au mois du RDV prochain.

Exemple : Si consultation en mars et RDV en avril, la fiche sera classée dans le compartiment avril.

2.5. La fiche de référence et contre référence

Elle sert de support pour tout problème dépassant la compétence du prestataire et la référence se fait vers le centre compétent le plus proche.

Elle comporte deux volets :

- **Le 1^{er} volet sera rempli par le prestataire où seront notés :**
 - La date
 - Nom et prénoms de la cliente
 - N° de la fiche de consultation;
 - La méthode contraceptive utilisée;
 - Le problème rencontré par le prestataire ;
 - Le nom et la signature du prestataire;
- **Le 2^{ème} volet est rempli par le médecin chez qui la référence est faite où seront notés également :**
 - La date de la visite
 - Le résultat de l'observation médicale
 - Le diagnostic trouvé
 - Le CAT médical
 - Le nom et la signature du médecin

2.6. La carte de rendez-vous

Elle représente la carte d'identité de la consultante. Le numéro de la fiche de consultation et la date des rendez-vous y sont mentionnés

2.7. Le carnet de commande

Il permet de commander les produits contraceptifs et le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement de centre de planification familiale.

2.8. La fiche de rapport mensuel

Elle résume l'ensemble des activités réalisées pendant un mois, provenant du registre de consultation et de l'échéancier et est présenté sous forme de tableau statistique.

Elle comprend : Les éléments d'identification du centre de planification familiale, le mois et l'année du rapport, le nom, la qualification et la signature du prestataire qui l'aura établi.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

LIVRES

1. **MANUEL DE LOGISTIQUE** : Guide pratique à l'intention des responsables de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre des programmes de santé et de planification familiale
USAID/Projet Deliver, mars 2007
2. **PLAN D'ACTION NATIONAL BUDGETISE D EPLANIFICATION FAMILIALE**
(2015-2020)
3. **MANUEL DE REFERENCE** : Fournir les services de DIUPP / USAID juillet 2013
4. **DRAFT MANUEL DE REFERENCE** : Formation des agents de santé en technologie contraceptive version 2019/ PNSME -CI
5. **DRAFT MANUEL DE REFERENCE** : Guide du formateur pf dans le post partum et dans le Post abortum / PNSME -CI
6. **MANUEL DE REFERENCE** : Méthode d'Allaitement Maternel et del'Aménorrhée (MAMA) : Une Référence pour les Prestataires de Services et Formateurs / USAID juin 2009
7. **GUIDE DU FORMATEUR DES PRESTATAIRES** : SAYANAPRESS/PATH
Version 3 Novembre 2013
8. **GUIDE DU FACILITATEUR** : Implanon NXT : Formation en cours d'emploi à l'attention des prestataires formés aux services d'implants, mars 2016, Jhpiego.
9. **CRITERES D'ELIGIBILITE MEDICALE** pour l'adoption et l'utilisation continue des méthodes contraceptives
Cinquième édition, 2015. Guide Essentiel OMS pour la Planification Familiale
10. **Planification familiale** : un manuel à l'intention des prestataires du monde
Entier 2011/OMS

SITES WEB CONSULTER:

1. <http://www.fptraining.org/content/conducting-training>
2. choisirmacontraception.com
3. www.uvmaf
4. <http://www.k4health.org/toolkits/iud>
5. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning
6. <http://www.prime2.org/sst/http://www.pathfinder.org/publications-tools/pdfs/Advanced-Training-of-Trainers-Participants-Guide.pdf?x=144&y=18http://www2.pathfinder.org/pf/pubs/module14.pdf>
7. <http://www.dossimo>

GLOSSAIRE SR/PF/

Adolescence

L'OMS considère que l'adolescence est la période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans.

Adrénaline

Hormone sécrétée par les glandes surrénales : c'est l'un des nombreux neurotransmetteurs présents dans le cerveau.

Barrières physiques individuelles

Tabliers, gants, écrans faciaux (masques) et autres accessoires protégeant contre une exposition aux agents pathogènes.

Cardiopathie valvulaire

Terme désignant dans son ensemble les maladies du cœur, qu'elles soient héréditaires ou acquises ou cours de l'existence.

Cardiopathies ischémiques

Ou maladies coronariennes, recouvrent, un ensemble de troubles dus à l'insuffisance des apports en oxygène au muscle cardiaque (myocarde) du fait du développement et des complications de l'athérosclérose au niveau d'une (ou plusieurs) artère(s) coronaire(s).

Choix éclairé et volontaire

Communication bidirectionnelle entre un client et un prestataire de soins dans le but de confirmer ou faciliter une décision par le client ou de l'aider pour adresser ses problèmes ou ses préoccupations.

Consentement éclairé

L'acceptation, l'accord, ou la permission du client donnée en vertu de son propre gré après une prise de décision éclairée.

Feedback

Transmission d'information sur les résultats d'une action ou d'un programme ; réponse permettant une évaluation.

Endométriose

Est une maladie gynécologique dans laquelle l'endomètre (tissu utérin) colonise d'autres organes, à proximité ou à distance de l'utérus

Grave maladie du foie

Un dysfonctionnement touchant tout ou partie du foie, un organe localisé dans le ventre et ayant de nombreuses fonctions notamment de sécrétions et de régulation...

Hépatite aiguë

Affection inflammatoire du foie qui détermine une destruction des cellules hépatiques.

Indicateur

Critère permettant de mesurer quantitativement et de monitorer tel ou tel effet d'une intervention ou d'un programme

Infection

Une infection désigne l'envahissement puis la multiplication de micro-organismes au sein d'un organe du corps vivant.

Infécondité

possibilité biologique de concevoir cependant les conditions non réunies.

Infertilité

On dit d'une femme qu'elle est infertile si sa capacité à concevoir ou à mettre au monde un enfant est nulle ou réduite; chez l'homme, c'est la capacité à féconder la partenaire qui sert de critère. Une impossibilité biologique de concevoir.

Méthode contraceptive d'appoint

toute méthode contraceptive employée en complément d'une première méthode susceptible d'échouer.

Méthode contraceptive moderne

technique contraceptive développée de manière scientifique et offrant une innocuité et une efficacité prouvées.

Méthodes contraceptives temporaires

la plupart des méthodes contraceptives ont un effet temporaire. Seules les stérilisations masculine et féminine sont permanentes. Toujours réversibles, les méthodes temporaires peuvent protéger de manière brève (ex. : préservatif masculin ou féminin) ou durable (ex. : dispositif intra-utérin).

Micro-organisme

organisme de taille microscopique ou submicroscopique comme une bactérie ou un virus.

Mode d'action ou mécanisme d'action

le mécanisme par lequel la méthode prévient la grossesse.

Néoplasie cervicale

évolution anormale, acquise, d'un tissu pouvant constituer un état précancéreux.

Tabagisme

une intoxication par le tabac

Tumeur

est un terme générique correspondant au développement d'un tissu nouvellement formé au sein d'un tissu normal. Elle est provoquée par le dysfonctionnement du développement cellulaire.

Troubles de la thyroïde

mauvais fonctionnement de la glande thyroïde qui se traduit par un trouble de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, en plus ou en moins, variable selon le type et l'intensité de l'atteinte.

Saignement vaginal inexplicable

les femmes ne devraient pas avoir de saignements vaginaux en dehors de la période des menstruations, bien que certaines constatent la présence de quelques gouttes de sang au moment de l'ovulation.

Santé sexuelle

elle a une dimension physique (santé du système reproducteur) et une dimension psychologique (capacité à exprimer sa sexualité d'une manière appropriée).

GLOSSAIRE GESTION LOGISTIQUE**Approvisionner/livrer**

Fournir un produit contraceptif ou tout autre article à un lieu d'entreposage ou point de prestation de services

Délai de livraison

Le temps nécessaire pour que les nouveaux produits commandés arrivent à destination et soient prêts à être expédiés au prochain niveau ou à être distribués aux clients.

Distribuer (aux utilisateurs)

Fournir un contraceptif ou tout autre article à l'utilisateur final (le client).

Formation sanitaire ou point de prestation de services

Cliniques ou autres sites où les contraceptifs sont distribués aux utilisateurs.

Période de revue ou intervalle de commande

L'intervalle de temps entre les vérifications de niveaux de stock pour déterminer s'il y a lieu ou non de passer une nouvelle commande, ou entre les périodes régulières de commande.

Pipeline

Est le circuit de distribution des produits depuis le fabricant jusqu'au client.

Produit contraceptif

Nom de la méthode et de la marque d'un contraceptif.

ANNEXES

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE SUR LES CONNAISSANCES EN PLANIFICATION FAMILIALE

1. La personne responsable du choix de la méthode de planification familiale est (une bonne réponse):
 - A. le prestataire de soins de santé
 - B. la cliente
 - C. le partenaire de la cliente
 - D. l'ancien du village
2. Lorsqu'une cliente revient à la structure sanitaire pour sa visite de suivi, le travailleur de la santé devrait (une bonne réponse):
 - A. lui demander si elle est satisfaite de la méthode choisie et lui offrir davantage de fournitures (selon la méthode)
 - B. changer de méthode de planification familiale
 - C. laisser les fournitures au kiosque d'accueil pour que les clientes qui reviennent puissent les y prendre
 - D. rien de ce qui précède
3. La partie la plus importante du counseling est (une bonne réponse):
 - A. renseigner la cliente sur toutes les méthodes disponibles et répondre à ses préoccupations et questions concernant l'usage des contraceptifs
 - B. prendre une bonne décision à la place de la cliente
 - C. utiliser toutes les fournitures excédentaires dans l'établissement de santé
 - D. se lier d'amitié avec la cliente
4. Le counseling initial en planification familiale doit être offert (une bonne réponse) :
 - A. si la cliente ne sait pas quelle méthode utiliser
 - B. à chaque cliente, pour s'assurer qu'elle connaît toutes les méthodes et fait un choix informé
 - C. par un médecin
 - D. uniquement pour les couples mariés
5. Les préservatifs (une bonne réponse):
 - A. ne doivent être utilisés qu'une fois et ensuite, jetés de la façon appropriée
 - B. doivent être gonflés à l'eau ou à l'air avant l'usage pour vérifier s'ils sont percés
 - C. ne sont pas affectés même s'ils sont entreposés dans un endroit chaud
 - D. peuvent être lubrifiés à l'aide d'huile de cuisson ou de gelée de pétrole
6. Pour que le préservatif masculin soit efficace, il est important (une bonne réponse):
 - A. que le pénis soit retiré du vagin juste avant l'éjaculation
 - B. que le pénis soit retiré encore en érection modérée
 - C. que l'homme place le préservatif lui-même
 - D. tout ce qui précède
7. L'un des avantages du préservatif féminin est (une bonne réponse):
 - A. qu'il dure plus longtemps
 - B. qu'il coûte moins cher
 - C. qu'il offre une meilleure protection contre le VIH
 - D. qu'il peut être inséré d'avance de façon à ne pas interrompre la relation sexuelle
8. Lequel des énoncés suivants est vrai à propos des spermicides (une bonne réponse):
 - A. ils peuvent causer une inflammation vaginale et des démangeaisons chez la femme
 - B. ils sont très efficaces pour prévenir la grossesse
 - C. ils peuvent être utilisés par les femmes séropositives
 - D. ils peuvent être insérés dans le vagin plusieurs heures avant la relation sexuelle
9. La femme qui prend des contraceptifs oraux combinés doit consulter à nouveau son prestataire de service immédiatement si elle (une bonne réponse):
 - A. a des crampes menstruelles
 - B. a la migraine
 - C. a de fortes douleurs aux jambes ou des problèmes visuels, par exemple une vision trouble
 - D. prend du poids
10. Avant de remettre à une femme son premier paquet de contraceptifs oraux combinés, le prestataire de service doit (une bonne réponse):
 - A. s'assurer que la femme ne veut plus d'enfant
 - B. expliquer tous les effets secondaires possibles et lui préciser quand revenir à la clinique
 - C. s'assurer que la femme allaite
 - D. procéder à un examen pelvien
11. Si une cliente se présente à la clinique et a une métrorragie pendant qu'elle prend des contraceptifs oraux, la conduite à tenir immédiatement est (une bonne réponse):
 - A. d'établir un rapport et de discuter avec elle pour savoir de quelle façon elle prend la pilule
 - B. l'envoyer en consultation d'urgence
 - C. modifier la méthode de contraception
 - D. tout ce qui précède

12. L'effet secondaire le plus courant du DEPO-PROVERA est (une bonne réponse):
- A. jaunisse et dommages au foie
 - B. augmentation de la pilosité faciale
 - C. baisse de la libido
 - D. modification du cycle menstruel
13. Dans la période du post-partum, une femme qui allaite devrait recevoir sa première injection de DEPO-PROVERA:
- A. Immédiatement
 - B. après une semaine
 - C. dans les 48 heures
 - D. n'importe quand six semaines après le post-partum, si elle est certaine de ne pas être enceinte
14. Les implants contraceptifs sont insérés (une bonne réponse):
- A. par un médecin
 - B. juste sous la peau, dans la partie supérieure du bras
 - C. si la cliente ne veut plus d'enfant
 - D. tout ce qui précède
15. Un des avantages des implants est que les bâtonnets peuvent être enlevés (une bonne réponse):
- A. par la femme elle-même
 - B. par une infirmière, une sage-femme ou un médecin formé
 - C. dans un environnement non stérile
 - D. facilement, avec les doigts
16. Un DIU peut être inséré n'importe quand (une bonne réponse):
- A. si la cliente ne veut plus d'enfant
 - B. si vous avez la certitude que la cliente n'est pas enceinte
 - C. si la cliente est mariée
 - D. à titre de protection contre les IST
17. Chez la plupart des femmes, il y a changement du cycle menstruel après l'insertion d'un DIU. Vous devriez expliquer à nouvelles utilisatrices d'un DIU qu'elles peuvent constater (une bonne réponse):
- A. un écoulement sanguin moins abondant qu'à l'habitude, mais plus de crampes menstruelles pendant les quelques premières règles suivant l'insertion
 - B. un écoulement sanguin plus abondant que d'habitude et moins de crampes menstruelles pendant les quelques premières règles suivant l'insertion
 - C. un écoulement sanguin moins abondant que d'habitude et aucune crampe menstruelle pendant les quelques premières règles suivant l'insertion
 - D. un écoulement sanguin plus abondant que d'habitude et plus de crampes menstruelles et de douleurs pendant les quelques premières règles suivant l'insertion
18. Le DIU est une méthode contraceptive très efficace pour (une bonne réponse):
- A. prévenir la transmission du VIH
 - B. empêcher la grossesse
 - C. empêcher la syphilis
 - D. accroître le plaisir sexuel
19. L'un des effets secondaires de la vasectomie est (une bonne réponse):
- A. perte de l'intérêt pour les relations sexuelles
 - B. diminution des érections
 - C. éjaculation prématurée
 - D. rien de ce qui précède
20. La stérilisation féminine peut être exécutée (une bonne réponse):
- A. dans les 48 heures suivant un avortement spontané ou provoqué, moyennant un choix volontaire informé
 - B. chez une femme qui voudrait avoir plus d'enfants
 - C. uniquement par un médecin
 - D. dans un environnement non stérile
21. Une mère a accouché depuis moins de six mois et qui fait de l'aménorrhée (ses règles ne sont pas revenues après l'accouchement) bénéficie d'une protection contre la grossesse aussi longtemps qu'elle (une bonne réponse):
- A. allaite son bébé de jour et que le bébé dort la nuit
 - B. allaite le bébé sur demande jour et nuit
 - C. nourrit le bébé à la bouteille
 - D. allaite le bébé la nuit et le nourrit à la bouteille pendant le jour

22. Parmi les personnes qui peuvent avoir recours à la contraception d'urgence, il faut mentionner (une bonne réponse):
- A. les femmes non mariées
 - B. les jeunes femmes
 - C. les fumeuses de moins de 35 ans
 - D. toute femme qui a eu une relation sexuelle non protégée
23. Lorsqu'un COC est utilisé comme contraceptif d'urgence, il doit être pris (une bonne réponse):
- A. dans les 24 heures de la relation sexuelle non protégée
 - B. jusqu'à 120 heures après la relation sexuelle non protégée
 - C. jusqu'à 72 heures après la relation sexuelle non protégée
 - D. dans la semaine suivant la relation sexuelle non protégée
24. La décontamination des instruments chirurgicaux par trempage dans une solution de chlore à 0,5% pendant 10 minutes (une bonne réponse):
- A. tuera la totalité des micro-organismes y compris les endospores bactériennes
 - B. tuera les virus, par exemple le VIH et le virus de l'hépatite B
 - C. éliminera les matières organiques, la saleté et autres matières
 - D. rendra les instruments plus éclatants
25. Si vous utilisez de l'eau bouillante pour la désinfection de haut niveau (DHN), vous devez toujours faire bouillir les instruments (une bonne réponse) :
- A. 20 minutes en démarrant le chronomètre lorsque l'eau atteint le point d'ébullition
 - B. 10 minutes en démarrant le chronomètre dès que vous versez l'eau dans le contenant
 - C. 20 minutes en démarrant le chronomètre dès que vous versez l'eau dans le contenant
 - D. 10 minutes en démarrant le chronomètre lorsque l'eau atteint le point d'ébullition
26. Idéalement, les objets pointus doivent être éliminés de la manière suivante (une bonne réponse):
- A. brûlage dans un petit feu
 - B. incinération industrielle
 - C. jetés dans un buisson
 - D. placés soigneusement dans la poubelle

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE PRETEST GESTION LOGISTIQUE

Instructions : Inscrire dans l'espace prévu un grand **V** si l'énoncé est vrai ou un grand **F** si l'énoncé est faux

Introduction à la logistique

1. Le but du système logistique est de permettre à la population de choisir, obtenir et utiliser des produits de santé de la reproduction chaque fois qu'elle en a besoin. _____
2. Le but de la gestion de contraceptifs est uniquement d'avoir des contraceptifs en grande quantité dans le centre _____
3. Le pipeline est le réseau de distribution des produits _____
4. Le cycle logistique doit respecter les « cinq bons » _____
5. Les politiques et l'adaptabilité influencent le cycle logistique _____

Système d'information en gestion logistique

6. Le système d'information en gestion logistique n'est pas important pour le système logistique _____
7. La fiche de stock renseigne sur les quantités de produits reçues et sorties ou éliminées d'une façon quelconque _____
8. Le formulaire de réception des produits de SR se présente sous forme de registre _____
9. Le bon de commande et de sortie est utilisé pour placer une commande d'approvisionnements, et sert aussi de reçu lorsque l'approvisionnement est livré. _____
10. Le bordereau d'emballage est un document de gestion de stock. _____
11. La fiche de contrôle de stock est un document de mouvement de stock _____
12. Le registre des activités quotidiennes et la feuille de pointage sont des documents relatifs à la consommation _____

Evaluation de l'état de stock

13. L'évaluation des stocks se mesure en mois de stock _____
14. Le stock disponible et la consommation mensuelle moyenne ne sont pas nécessaires pour évaluer l'état de stock. _____
15. L'évaluation de l'état de stocks doit se faire régulièrement pour chaque produit _____
16. Les documents de gestion de stocks sont utilisés pour enregistrer les informations concernant les articles entreposés _____

Système de contrôle max-min

17. Tout niveau de stock supérieur au minimum est une situation de sur stockage _____
18. Tout niveau de stock inférieur au minimum est une situation de stock insuffisant. _____
19. Le but d'un système de contrôle des niveaux de stock est de déterminer la période où le stock va être commandé /expédié _____
20. Les commandes régulières sont faites lorsque les stocks sont épuisés pour éviter d'être à cours de produits. _____
21. La consommation moyenne mensuelle (CMM) permet de décrire plus précisément la quantité de produit que l'on utilise _____
22. Le principe de premier entré, premier sorti est le meilleur principe pour la gestion des contraceptifs _____
23. Prendre des décisions au niveau local d'une organisation est un principe de base du Système d'Information de Gestion (SIG) _____
24. L'utilité de la fiche individuelle de consultation est de recueillir des informations sur la quantité des contraceptifs fournis aux clients _____

Organisation des services

25. La supervision vise le contrôle des agents _____
26. Vérifier ses propres performances n'est pas pour le prestataire un avantage de l'auto-évaluation _____
27. Augmenter le rendement du personnel n'est pas un avantage pour l'intégration des services _____

Concept de qualité des services

28. La qualité des services implique uniquement l'accessibilité des services et la réduction d'un nombre de perdes de vue et d'abandon. _____
29. L'indicateur de qualité exprime le problème à résoudre. _____
30. La qualité des services est l'affaire des seuls professionnels de la santé. _____
31. La qualité des services vise la satisfaction des bénéficiaires/clients _____

Généralités sur la communication

32. Le but de l'IEC/CCC est d'améliorer le comportement de la population. _____
33. Les éléments de la communication sont : Emetteur, Canal, Récepteur, Feed-back. _____

Counseling

34. Au cours du Counseling, le prestataire ne donne que des instructions à la cliente. _____
35. Le prestataire est la personne la mieux indiquée pour choisir une méthode contraceptive à une femme en bonne santé. _____

Consultation de planification familiale

36. Au cours de la consultation de Planification Familiale, l'examen physique seul suffit. _____
37. Pour prescrire une méthode contraceptive à une cliente pour la première fois, le prestataire se base sur l'interrogatoire et l'examen clinique. _____

Physiologie de la reproduction

38. Le cycle menstruel est la période qui va du premier jour des règles au premier jour des règles prochaines.

39. La progestérone est l'hormone qui prédomine au début du cycle.

Généralités sur la contraception

40. Une méthode de contraception qui répond seulement au critère de réversibilité est une méthode sûre.

41. Appliquer les critères médicaux d'éligibilité permet de classer les méthodes contraceptives selon leur mode d'action.

Contraceptifs oraux

42. Pour être efficace, les contraceptifs oraux combinés doivent être pris uniquement au moment des rapports sexuels.

43. L'efficacité des contraceptifs oraux combinés est renforcée lorsqu'ils sont pris en association avec l'arifampicine.

44. Une cliente sous contraceptifs oraux progestatifs qui constate des saignements doit immédiatement arrêter la prise des comprimés.

Contraceptifs injectables

45. Les troubles du cycle menstruel sont les effets secondaires les plus fréquents du DEPO-PROVERA.

46. Une mère qui allaite ne recevra pas sa première injection de DEPO-PROVERA ou de NORISTERAT avant le retour des couches.

Les implants

47. Les implants sont administrés par voie sous cutanée.

48. Une femme qui a des saignements vaginaux non diagnostiqués ne devrait pas utiliser les Implants avant que la cause des saignements ne soit déterminée.

Dispositif intra-utérin

49. La femme qui porte un DIU doit retourner au service de PF si elle ne sent pas les fils de son DIU lorsqu'elle essaie de les palper.

50. Le DIU Tcu 380 A empêché l'ovulation et épaissit la glaire cervicale.

51. L'hystéromètre n'est pas nécessaire pour la pose de DIU.

Méthodes de barrière

52. Toutes les méthodes de barrière protègent contre l'IST/VIH/SIDA.

53. Pour une meilleure efficacité, le préservatif masculin doit être enfilé sur le pénis en érection, avant tout contact sexuel.

54. Le préservatif féminin peut être porté une heure avant le rapport sexuel.

Contraception chirurgicale volontaire

55. La C.C.V interfère avec les rapports sexuels.

56. Un homme qui a subi une vasectomie doit utiliser une méthode de barrière durant au moins les trois premiers mois.

Méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée

1. La montée laiteuse importante est la principale condition pour que l'allaitement maternel soit une méthode efficace de contraception.

Méthodes d'auto-observation

2. Les méthodes d'Auto-Observation tiennent essentiellement compte des modifications physiologiques qui surviennent dans l'organisme de la femme.

Contraception chez les groupes particuliers

3. Les contraceptifs oraux combinés sont les méthodes contraceptives les plus recommandées dans le post partum immédiat.

4. La contraception d'urgence correspond seulement à la prise de la pilule du lendemain.

Prise en charge des IST

5. Les infections sexuellement transmissibles sont toujours transmises par les bactéries.

6. Le traitement du ou des partenaires n'est pas une condition importante dans la prise en charge correcte des IST.

7. Avoir plus d'un partenaire ne peut pas être un comportement à risque.

Prise en charge de l'infécondité / infertilité

8. Le couple est infécond lorsqu'après six mois de vie commune et de rapports sexuels réguliers et normaux, ils n'ont pas d'enfants.

9. Les infections du tractus génito-urinaire sont les premières grandes causes d'infécondité chez les couples.

Prévention de l'infection

10. Les instruments chirurgicaux (en métal) qui ont été soigneusement décontaminés peuvent être stérilisés en les faisant bouillir dans de l'eau pendant 20 minutes.

11. La pratique la plus importante dans le cadre de la prévention des infections est le lavage des mains.

12. Afin d'éviter tout risque de transmission des virus de l'hépatite B et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au personnel pendant le nettoyage, les instruments souillés et les gants réutilisables doivent être trempés dans une solution chlorée à 0,5% pendant 10 minutes.

ANNEXE 3 : FICHE INDIVIDUELLE DE CONSULTATION

	CONDUITE A TENIR				
	DIU	C O C	C O P	I N J	IMPLA NT
<u>ANAMNESE</u>					
1. Nulligeste	(-)	+	+	+	+
2. Post partum de moins 6 semaines	(-)	-	+	+	+
3. Allaitement exclusif de moins de 6 mois	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4. Avortement moins de 6 semaines	(-)	+	+	+	+
5. Césarienne moins de 6 mois	(-)	+	+	+	+
6. Diabète non surveillé	-	(-)	(-)	(-)	(-)
7. Deux signes parmi: Age sup 35ans () Tabagisme important () Obésité ()	+	-	+	+	+
8. Hyperménorrhée, dysménorrhée	(-)	+	+	+	+
9. Métrorragie	-	-	-	-	-
10. Traitements médicamenteux pouvant interférer avec l'efficacité de contraceptifs oraux	+	(-)	(-)	+	+
<u>ANTECEDENTS</u>					
1. Phlébite, Thrombose artérielle, embolie	+	-	+	(-)	(-)
2. GEU	(-)	+	+	+	+
3. Infection génitale haute	(-)	+	+	+	+
4. Maladie récente du foie (moins de 6 mois)	+	-	-	-	-
5. Statut VIH connu	-	+	+	+	+
<u>EXAMEN GENERAL ET GYNECOLOGIQUE</u>					
1. Conjonctives jaunes (maladie du foie)	+	-	-	-	-
2. Pathologie valvulaire cardiaque	-	+	+	+	+
3. T.A. Supérieure à 14/9	+	-	(-)	(-)	(-)
4. Tumeur mammaire	+	-	-	-	-
5. Phlébite, varices importantes, profondes	+	-	+	+	+
6. Grossesse	-	-	-	-	-
7. Infection génitale haute ou basse	-	+	+	+	+

ANNEXE 4 : FICHE D'APPRENTISSAGE POUR LES COMPETENCES EN COUNSELING

TACHES/GESTION	Atteint	Non atteint
1. PREPARER LE COUNSELING		
1.1 Veiller à ce que la salle soit bien éclairée et ventilée.		
1.2 S'assurer de la disponibilité des sièges et des tables.		
1.3 Réunir le matériel pédagogique (p. ex., affiches, diagrammes, dépliants).		
1.4 S'assurer qu'il y a de quoi écrire (p. ex., dossier de la cliente, registre des activités quotidiennes et fiches de suivi).		
1.5 Veiller à la protection de l'intimité.		
2. COUNSELING INITIAL (GROUPE OU PERSONNES). UTILISER « BERGER ».		
2.1 BIENVENUE Accueillir la cliente avec respect et gentillesse ; la faire se sentir à l'aise.		
2.2 Offrir à la cliente un siège près de vous.		
2.3 Vous présenter à la cliente et lui demander son nom.		
2.4 Présenter les autres membres du staff si nécessaire		
2.5 ENTRETIEN Demander à la cliente ce que vous pouvez faire pour elle. Informer le client des services disponibles y compris la prise en charge des cas d'IST/SIDA		
2.6 Demander à la cliente ce qu'elle sait de la PF et si elle a déjà utilisé une méthode ; si tel est le cas, lui demander de quelle façon elle a utilisé la méthode et si elle a des préoccupations à ce propos.		
2.7 Demander à la cliente quels sont ses objectifs en matière de reproduction: - Combien d'enfants veut-elle? - Est-elle intéressée à espacer les grossesses ou à les empêcher totalement? - Quel intervalle la cliente veut-elle entre les grossesses?		
2.8 Établir le dossier de la cliente en matière d'antécédents de reproduction et médicaux: - nom - date de naissance - possibilité de grossesse (date de dernières réglées) - nombre de grossesses - nombre de naissances - toute méthode de planification familiale qu'elle peut avoir utilisée par le passé, pendant combien de temps, les raisons de l'arrêt et tout problème rencontré dans cette méthode - méthode de planification familiale utilisée actuellement - toute pathologie médicale qui pourrait être contre-indiquée pour la ou les méthodes que la cliente souhaite utiliser - antécédents d'infection de l'appareil reproducteur(IAR).		
2.9 RENSEIGNEMENTS Fournir des renseignements généraux mais brefs sur toutes les méthodes de PF disponibles, notamment : - efficacité - problèmes ou complications possibles - effets secondaires et leur gestion - avantages et inconvénients - besoins éventuels de protection contre les IST/le VIH - différence entre contraception réversible et permanente.		
2.10 Demander à la cliente quelle méthode l'intéresse.		
2.11 CHOIX Aider la cliente à choisir une méthode appropriée. S'assurer qu'il n'y a aucune pathologie médicale contre-indiquant le recours à la méthode. Dans le cas contraire, proposer des solutions de rechange.		

COUNSELING SPÉCIFIQUE À LA MÉTHODE			
1.1 Lorsque la cliente a choisi une méthode, LUI DEMANDER si elle a d'autres questions à poser à propos de cette méthode.			
1.2 RENSEIGNEMENTS Expliquer en détail la méthode choisie : • types • fonctionnement • avantages et avantages non contraceptifs • inconvénients • indications • contre-indications • effets secondaires fréquents et signes avertisseurs • protection contre les IST/ le VIH.			
1.3 Évaluer la cliente par rapport à la méthode choisie; si cela est indiqué, envoyer la cliente en évaluation.			
1.4 CHOIX Aider la cliente à choisir une autre méthode si celle retenue est jugée inappropriée après une évaluation supplémentaire.			
1.5 Offrir la méthode choisie, si elle est disponible, ou référer la cliente vers la structure sanitaire la plus proche où elle est disponible.			
1.6 EXPLIQUER Donner à nouveau à la cliente des instructions sur : • comment utiliser cette méthode • ses effets secondaires et leur prise en charge • problèmes ou complications possibles pour lesquels la cliente doit revenir immédiatement à la structure sanitaire; où s'adresser • toute autre information pertinente.			
1.7 Demander à la cliente de répéter les instructions pour s'assurer qu'elle a compris.			
1.8 Demander à la cliente si elle a d'autres questions ou préoccupations.			
1.9 RETOUR POUR LE SUIVI Discuter avec la cliente des visites ultérieures et du suivi : • où s'adresser pour obtenir d'autres fournitures (le cas échéant) • à quel moment revenir à la structure sanitaire.			
Rassurer la cliente et lui dire qu'elle peut revenir à la même structure sanitaire n'importe quand pour obtenir des conseils ou des réponses à ses questions ou si elle a un problème ou a besoin de soins médicaux			
Inscrire l'information dans le dossier de la cliente et au registre quotidien des activités.			
Remercier la cliente et lui dire poliment au revoir.			
COUNSELING DE SUIVI			
BIENVENUE Accueillir la cliente respectueusement et avec gentillesse ; faire en sorte qu'elle se sente à l'aise.			
Offrir à la cliente un siège près de vous.			
Vous présentez et demander à la cliente quel est son nom.			
ENTRETIEN Demander à la cliente ce que vous pouvez faire pour elle.			
Vérifier si la cliente est satisfaite de la méthode et si elle l'utilise encore.			
RENSEIGNEMENT / CHOIX Chercher à savoir si des changements dans l'état de santé actuel ou le mode de vie de la cliente peuvent permettre de conclure qu'elle a besoin d'une méthode différente ou à savoir si elle utilise la méthode correctement et, au besoin, lui demander de répéter les instructions.			
Demander à la cliente si la méthode qu'elle utilise lui cause des problèmes.			
EXPLICATION Rassurer la cliente à propos de tout effet secondaire mineur qu'elle pourrait éprouver et procéder au traitement au besoin.			
Évaluer s'il est nécessaire d'envisager une autre méthode et conseiller la cliente encore une fois à propos des autres méthodes.			
Évaluer s'il est nécessaire d'envisager une autre méthode et conseiller la cliente encore une fois à propos des autres méthodes.			
Au besoin, lui remettre des fournitures.			

RETOUR VISITE ULTÉRIEURES Planifier le rendez-vous suivant.		
Demander à la cliente si elle des questions à poser et lui répondre adéquatement.		
Au besoin, lui remettre des fournitures.		
RETOUR VISITE ULTÉRIEURES Planifier le rendez-vous suivant.		
Inscrire l'information au dossier de la cliente et au registre quotidien des activités		
Remercier la cliente poliment, lui dire au revoir et l'inviter à revenir à la clinique.		
6. EXPLIQUER LA METHODE CHOISIE		
6.1 Expliquer comment utiliser la méthode		
6.2 Expliquer les effets secondaires et signes avertisseurs		
6.3 Demander au client de répéter ces informations		
6.4 Corriger les informations si nécessaires		
6.5 Expliquer les effets de la méthode en rapport avec la prévention des MST/SIDA		
6.6 Faire la démonstration du port de condom sur le mannequin		
6.7 Expliquer le calendrier de suivi		
7. FIXER LE RENDEZ VOUS		
7.1 Marquer la date du rendez-vous dans le carnet ou carte de suivi		
7.2 Remplir la fiche de référence si nécessaire		
7.3 Dire au client la date de rendez-vous		
7.4 Expliquer au client qu'elle peut revenir à la clinique selon ses besoins		
7.5 Dire au revoir à la cliente (si possible la raccompagne à la porte)		

Commentaires :

Le participant est Qualifié pour le counseling

DATE: _____

ANNEXE 5 : FICHE D'APPRENTISSAGE POUR LA PRISE DE L'ANAMNÈSE

TACHES/GESTION	Atteint	Non atteint
1. PRÉPARER LE COUNSELING		
1. Préparer l'environnement pour l'anamnèse : éclairage adéquat • sièges • tables • dossier et fiche de la cliente • confidentialité • registre quotidien des activités.		
2. Accueillir la cliente avec respect et gentillesse et faire qu'elle se sente à l'aise.		
3. Vous présentez à la cliente et lui demander son nom.		
4. Noter les antécédents personnels/sociaux de la cliente: • nom • âge • adresse postale/civique • nationalité.		
5. Prendre l'anamnèse de la cliente: • migraine avec aura • système respiratoire • tuberculose • cardiovasculaire • diabète • système digestif • maladie hépatique • maladie rénale • cholécystopathie • considérations générales : *chirurgie *tabagisme *prise actuelle de médicament ** allergies.		
ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE DE REPRODUCTION		
1. Prendre les antécédents menstruels et gynécologiques de la cliente: • dernières réglés • durée des règles • abondance des règles • jours d'intervalle • symptômes associés: ** crampes *Céphalées *nausée *vomissements • antécédents de saignements génitaux anormaux • chirurgie des organes de la reproduction • antécédents d'IAR *écoulement vaginal *dysurie **prurit génital *plaies/ulcères aux organes génitaux.		

2. Prendre les antécédents obstétricaux de la cliente:		
- grossesses *gestité *parité *résultats des grossesses *mode d'accouchement - complication de grossesse/d'accouchement/de post-partum - état de santé de la famille nucléaire - nombre d'enfants vivants - date du dernier accouchement/avortement - allaitement *durée **fréquence.		
3. Prendre les antécédents en matière de la planification familiale de la cliente:		
- utilisation antérieure de méthodes de planification familiale - types de méthodes utilisées - durée de l'utilisation des méthodes - lieu d'obtention de la ou des méthodes - raison de l'arrêt ou du changement de méthode - tout effet secondaire/toute complication de la ou des méthodes - dernière fois où la méthode a été utilisée - méthode utilisée constamment et correctement.		
4. Prendre les antécédents sexuels de la cliente:		
- nombre de partenaires sexuels actuels - douleur pendant ou après les relations sexuelles - saignement pendant ou après la relation sexuelle - dépistage des IAR (Infections de l'Appareil Reproducteur) - examen pelvien antérieur.		
5. Vous assurez que tous les antécédents notés sont versés au dossier de la cliente et au registre quotidien des activités.		
6. Préparer		
- salle/paravent - éclairage adéquat - sièges - table - balance - Tensiomètre - Table d'examen - dossiers et fiches de la cliente - registre quotidien des activités - linge.		
7. Garantir la confidentialité.		
8. Communiquer avec la cliente tout au long de la procédure.		
EXAMEN GÉNÉRAL		
1. Prendre:		
- tension artérielle - poids de la cliente		
APRÈS L'ANAMNÈSE		
1. Donner à la cliente un feed-back sur les constatations découlant de l'anamnèse et de l'examen général.		
2. Inscrire les constatations au dossier de la cliente et au registre quotidien des activités si aucun autre examen n'est nécessaire.		
3. Demander à la cliente si elle a d'autres questions à poser		
4. Si cela est exigé par l'anamnèse ou le choix de la méthode, préparer la cliente à l'examen physique.		
5. Procéder au counseling en planification familiale.		

Commentaires :

Le participant est Qualifié pour l'anamnèse

DATE: _____

ANNEXE 6 : FICHE D'APPRENTISSAGE POUR L'EXAMEN PHYSIQUE

TACHES/GESTION	Atteint	Non atteint
EXAMEN PELVIEN		
1. Préparer l'endroit et le matériel nécessaire pour l'examen physique: - salle/paravent - éclairage adéquat - sièges - table - balance - Tensiomètre - Table d'examen - dossiers et fiches de la cliente - registre quotidien des activités - matériel et fournitures - linge		
2. Garantir la confidentialité		
3. Accueillir la cliente avec respect et gentillesse et la faire se sentir à l'aise.		
4. Si c'est la première rencontre, vous présenter à la cliente et lui demander son nom.		
5. Communiquer avec la cliente tout au long de la procédure.		
6. Préparer la cliente à l'examen pelvien - expliquer la procédure et chaque étape, tout au long de l'exécution; - rassurer la cliente et lui dire qu'elle peut poser des questions n'importe quand et qu'il est possible d'arrêter l'examen n'importe quand si elle ne se sent pas à l'aise; - veiller à ce que la vessie de la cliente soit vide; - demander à la cliente de se dévêtir de la ceinture en descendant et de se couvrir d'un drap (au besoin, quitter la pièce pendant qu'elle fait cela); - installer la cliente en position de lithotomie; - couvrir la cliente pour protéger son intimité		
7. Veiller à assurer la PI tout au long de l'examen pelvien: - vous laver les mains au savon et à l'eau et les sécher - porter des gants propres - n'utiliser que des instruments stérilisés/désinfectés de haut niveau		
8. (A) Procéder à l'inspection externe des organes génitaux (dépistage des IST) et détecter toute anomalie : **verrues **écoulement anormal **ulcères **saignement vaginal **plaies **cicatrices **enflures. (B) Palpation : **glandes inguinales, en utilisant la main gauche **glandes de Bartholin et presser les glandes de Skene de la main droite.		
- Placer un ou deux doigts (lubrifiés) juste dans l'ouverture vaginale et presser doucement vers le bas pour relaxer les muscles. - Demander à la cliente de relaxer ses muscles le plus possible. - Introduire le spéculum fermé dans le vagin, les lames tournées d'environ 45°. - Glisser le spéculum sur vos doigts tout en le dirigeant vers le bas (de façon postérieure). - Insérer les lames pleinement et tourner le spéculum de façon que les lames passent à l'horizontale et que la poignée pointe vers le bas. - Ouvrir les lames et manœuvrer le spéculum de façon à ce que le col devienne pleinement visible. - Resserrer les vis à oreillettes pour maintenir l'ouverture des lames. - À l'aide d'une lampe à rayon étroit, examiner le col pour dépister tout écoulement anormal, toute lésion ou friabilité. - Vérifier s'il y a écoulement anormal et prendre un spécimen pour examen au microscope ou culture si nécessaire. - L'examen terminé, desserrer les vis à oreillettes et retirer doucement le spéculum.		

EXAMEN PELVIEN BIMANUEL		
1. Les deux mains gantées, humidifier l'index et les doigts intermédiaires d'une main.		
2. De l'autre main, séparer les lèvres avec deux doigts afin que 3. l'ouverture du vagin soit facilement visible.		
4. Introduire doucement dans le vagin l'index et le doigt intermédiaire lubrifiés de l'autre main.		
5. Exerger une pression vers le bas et localiser le col.		
6. Déplacer le col latéralement entre les doigts et demander à la cliente si c'est douloureux.		
7. Placer les doigts de la main servant à l'examen pelvien dans l'espace entre le col et la paroi vaginale postérieure, la paume vers le haut		
8. Placer l'autre main à plat sur l'abdomen, à mi-chemin entre le nombril et l'os pubien.		
9. Exerger, des doigts de la main servant à l'examen vaginal, une légère pression vers le haut.		
10. Glisser doucement la main servant à l'examen abdominal vers la symphyse pubienne.		
11. Palper doucement l'utérus entre les deux mains, vérifier la taille, la forme, l'emplacement, l'uniformité, la mobilité et la sensibilité.		
12. Déplacer les doigts de la main placée dans le vagin et de la main placée sur l'abdomen légèrement vers un côté de l'utérus et palper l'ovaire.		
13. Faire de même pour l'autre côté. Vérifier l'emplacement, la taille, l'uniformité et la sensibilité.		
14. Retirer doucement les doigts.		
15. Dire à la cliente que l'examen est terminé.		
1. Sauf si l'étape suivante est l'insertion d'un DIU, demander à la cliente de quitter la table et de s'habiller.		
2. Remercier la cliente de sa coopération		
3. Suivre les procédures de PI.		
4. Vous laver les mains au savon et à l'eau.		
5. Communiquer à la cliente les résultats de l'examen • Informer la cliente, tout en la rassurant, de ce que vous avez constaté à l'examen. • Informer la cliente de toute anomalie détectée. • Expliquer les causes possibles des anomalies détectées. • Préparer la cliente à l'étape suivante.		
6. Inscrire toutes les constatations dans le dossier de la cliente, en prenant note de toute anomalie détectée (si la méthode choisie est le DIU, suivre ensuite les étapes pour l'insertion du DIU).		
7. Si aucune autre intervention n'est requise dans la visite actuelle, dire poliment au revoir à la cliente et l'inviter à revenir si elle a des préoccupations ou questions.		

Commentaires :

Le participant est Qualifié pour l'anamnèse

DATE: _____

ANNEXE 7 : FICHE D'APPRENTISSAGE POUR LES PRÉSERVATIFS MASCULINS ET FÉMININS

TACHES/GESTION		
EXAMEN PELVIEN	Atteint	Non atteint
1. La cliente a été accueillie et a reçu un counseling général sur toutes les méthodes de PF; les antécédents personnels et médicaux de base ont été consignés et documentés, il a été question des objectifs en matière de reproduction et les méthodes à privilégier ont été envisagées en détail.		
2. Demander à la cliente ce qu'elle sait à propos des condoms et corriger tout renseignement erroné.		
• Discuter des facteurs de risque concernant les IST. • Demander à la cliente si, à sa connaissance, elle est allergique au latex. • Conseiller la cliente sur l'usage correct et constant du préservatif pour éviter la grossesse. Si cela n'est pas possible, lui conseiller des méthodes supplémentaires.		
4. renseigner la cliente sur les préservatifs masculins et féminins: • Efficacité : 89 % à 99 % s'ils sont utilisés correctement chaque fois qu'un couple a des relations sexuelles ; par contre, le taux d'échec est élevé s'ils ne sont pas utilisés correctement; • Comment les préservatifs empêchent la grossesse : en bloquant et en emprisonnant le sperme afin qu'il ne puisse pas pénétrer dans le vagin et l'utérus; • Avantages : efficacité immédiate, très efficace s'ils sont utilisés correctement et à chaque relation sexuelle, gratuits ou peu coûteux, peu d'effets secondaires, faciles à utiliser, encouragent l'homme à participer à la contraction, offrent une protection contre les IST; • inconvénients : exigent de la pratique; pour certains hommes, peuvent réduire les sensations sexuelles; doivent être utilisés correctement à chaque relation sexuelle pour garantir l'efficacité maximale; • effets secondaires : irritation locale au pénis, à la vulve ou au vagin, mais rarement.		
5. également faire la démonstration à l'aide du modèle. Donner à la cliente des instructions sur la façon d'utiliser le préservatif masculin:		
• pour une efficacité maximale, utiliser un préservatif chaque fois que vous avez une relation sexuelle; • ne pas utiliser d'huile minérale ou à cuisson, d'huile pour bébé ou de gelée de pétrole; si la lubrification est nécessaire, utiliser la salive ou les sécrétions vaginales; • ne pas ouvrir l'emballage avec les dents, un couteau, des ciseaux ou autres ustensiles pointus; • vérifier si le préservatif est déchiré et s'assurer de la date de péremption. • Ne pas l'utiliser si l'emballage est endommagé ; • le préservatif doit toujours être déroulé sur le pénis en érection avant la pénétration, car le liquide séminal pré-éjaculatoire contient déjà des spermatozoïdes actifs; ##si le préservatif ne comporte pas d'élargissement à l'extrémité (bout réservoir), laisser environ 1 à 2 cm à l'extrémité pour l'éjaculat; • après la relation sexuelle, tout en tenant la base (anneau) du préservatif, retirer le pénis avant la perte d'érection. Cela empêche le préservatif de glisser et le sperme de se répandre ; • le préservatif ne doit être utilisé qu'une fois; • jeter les préservatifs utilisés dans une poubelle, dans les toilettes ou les enterrer; • pour une protection plus complète contre la grossesse, on peut, avec les préservatifs, utiliser un spermicide; • le préservatif peut être obtenu gratuitement dans les structures sanitaires et les cliniques de PF ou être achetés dans des boutiques ou chez le pharmacien; • encourager la cliente et son partenaire à s'exercer à la maison.		

• Donner des explications sur les préservatifs féminins et en faire la démonstration; • utiliser un préservatif neuf pour chaque relation sexuelle; • le préservatif féminin peut être inséré jusqu'à huit heures avant la relation sexuelle; • vérifier l'emballage et la date de péremption et ouvrir délicatement; • retenir ensemble les parois du préservatif pour étendre le lubrifiant; • presser l'anneau intérieur (à l'extrémité fermée du préservatif) entre le pouce et le majeur; • de l'autre main, ouvrir les lèvres et localiser l'entrée du vagin; • insérer l'anneau intérieur du préservatif aussi loin que possible dans le vagin; • insérer votre index dans le préservatif et le pousser en place; • veiller à ce que le préservatif ne soit pas tordu et que l'anneau extérieur demeure à l'extérieur du vagin; • au cours de la relation sexuelle, veiller à ce que le pénis pénètre dans le préservatif et n'en sorte pas pendant la relation; • si le préservatif sort ou est poussé à l'intérieur du vagin pendant la relation, le replacer soigneusement; • après la relation, enlever le préservatif avant de se mettre debout; • presser et tordre l'anneau extérieur pour éviter que le sperme ne s'écoule; • éliminer correctement le préservatif usagé.		
6. Expliquer quoi faire s'il y a rupture du préservatif ou fuite pendant la relation: • remplacer immédiatement le préservatif par un préservatif neuf; • utiliser un spermicide avec le préservatif; • elle devrait aller à une structure sanitaire ou à une clinique dès que possible pour obtenir un contraceptif d'urgence.		
7. Demander à la cliente de répéter les instructions pour s'assurer qu'elle a compris.		
8. Demander à la cliente si elle a des questions ou des préoccupations à formuler.		
9. Fournir des préservatifs à la cliente.		
10. Encourager la cliente à revenir n'importe quand si elle des questions ou un problème.		
11. Inscrire l'information au dossier de la cliente et au registre quotidien des activités.		
12. Saluer poliment la cliente et l'inviter à revenir pour s'approvisionner.		

**ANNEXE 8 : FICHE D'APPRENTISSAGE POUR LES SEANCES DE COUNSELING SUR LES
PROGESTATIFS SEULS INJECTABLES ET DES APTITUDES CLINIQUES**

TACHE/ACTIVITE	Atteint	Non atteint
Premier entretien		
Accueille la cliente de manière aimable et respectueuse.		
Maintient un contact visuel avec la cliente.		
Se concentre pleinement sur ce que la cliente dit.		
Demande à la cliente quel service de santé maternelle et infantile ou de PF elle recherche et répond à toutes les questions générales qu'elle pourrait se poser.		
Offre une information générale sur les services de santé maternelle et infantile ainsi que sur les méthodes de PF disponibles.		
Explique à quoi la cliente doit s'attendre au cours de la visite.		
Demande à la cliente si elle a une méthode de contraception en tête.		
Demande à la cliente ce qu'elle pense de la méthode qu'elle a en tête ou d'une méthode de contraception qu'elle a déjà utilisé.		
• La questionne sur ses objectifs en matière de reproduction, pour espacer ou limiter les naissances.		
• Explore toute attitude ou toute croyance religieuse qui pourrait favoriser ou exclure une ou plusieurs méthodes de contraception.		
• Explique brièvement les choix qui existent en matière de contraception.		
• Explique brièvement les avantages de chaque méthode.		
• Explique brièvement les risques associés à chaque méthode.		
• Demande à la cliente si elle a des questions, et y répond.		
• Demande à la cliente quelle méthode de contraception elle préfère.		